1. СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА.

Кожа является самым большим и сложно устроенным органом человека.

- Площадь – 1.5-2м2
- Толщина- 0.5- 4мм
- Содержание воды- 62-70%
- Мин в-ва- 1% от массыкожи
- За сутки с поверхности кожи испаряется- 60-800 мл водяных паров
- 100-200 г кожного сала

СТРОЕНИЕ КОЖИ :

- Эпидермис
- Дерма или собственно кожи
- Подкожная жировая клетчатка

ЭПИДЕРМИС происходит из эктодермы и представляет собой многослойный ороговевающий эпителий (кератиноциты 85%), в котором в зависимости от стадии дифференцировки эпителиальных клеток различают следующие слои:

- базальный, или зародышевый
- слой шиповатых клеток
- слой зернистых клеток
- элеидиновый, или блестящий
- роговой

БАЗАЛЬНЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕРМИСА

- Представлен одним рядом цилиндрических клеток- эпидермоцитов, располагающихся перпендикулярно поверхности кожи в виде частокола.
- Соединяются базальные эпидермоциты друг с другом межклеточными мостиками, или десмосомы.
- В цитоплазме эпидермоцитов, преимущественно вокруг ядра, располагаются гранулы меланина, от количества которых зависит цвет кожи.
- В нем располагаются: кл. Лангерганса, кл. Гринштейна, осязательные кл. Меркеля

ШИПОВАТЫЙ СЛОЙ состоит из шиповатых эпидермоцитов, с очень неровными контурами за счет неровных выростов (шипов), проникающих в соответствующие углубления соседних клеток и образующих соединения типа застежки «молнии

ЗЕРНИСТЫЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

- Клетки зернистого слоя имеют форму вытянутого ромба, ядра их располагаются в центре.
- В цитоплазме клеток находятся различной формы и величины кератогиалиновые гранулы.
- Число гранул варьирует в зависимости от толщины рогового слоя.
- Имеет различную толщину которая зависит от толщины рогового слоя

БЛЕСТЯЩИЙ ИЛИ ЭЛЕИДИНОВЫЙ СЛОЙ Состоит из 1-3 слоев плоских клеток, содержат элеидин . Лучше выражен на ладонях и подошвах.

РОГОВОЙ СЛОЙ

- Состоит из 5-6 рядов ороговевших безъядерных клеток (на локтях и подошвах 10-15 рядов).
- Роговые чешуйки в нижних и средних отделах рогового слоя плотно прилежат друг к другу, ближе к поверхности они расположены более рыхло, легко слущиваются и заменяются новыми из нижележащих слоев.
- Роговое вещество состоит из нерастворимого белка — кератина, в который входят цистин, аргинин, лизин и гистидин.

Эпидермально-дермальное соединение

- Эта область представляет собой область взаимодействия и взаимообмена клеточными и гуморальными компонентами между дермой и эпидермисом.
- Представлено дермально-эпидермальной базальной мембраной которая является основанием для эпидермиса и барьерной зоной между эпидермисом и дермой.

2. СТРОЕНИЕ ДЕРМЫ. КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ. КРОВОСНАБЖЕНИЕ. ПРИДАТКИ КОЖИ

ДЕРМА

- состоит из сосочкового и сетчатого слоёв.
- Волокнистая субстанция состоит из коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон, среди которых расположены клеточные элементы.
- Основное вещество дермы представляет собой аморфную субстанцию, пропитанную тканевой жидкостью.

СОСОЧКОВЫЙ СЛОЙ – располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, выполняющей трофическую функцию. Название этот слой получил из-за многочисленных сосочков, вдающихся в эпидермис.

СЕТЧАТЫЙ – образован плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками коллагеновых и сетью эластических волокон.

Коллагеновые волокна в дерме располагаются в виде пучков. Основу коллагеновых волокон составляет коллаген. В сосочковом слое пучки тоньше и располагаются перпендикулярно по отношению к эпидермису, а в сосочковом слое пучки толще и располагаются параллельно .

Эластические волокна состоят из 2 компонентов: белковых комплексов и содержащих серу мукополисахаридов (хондроитинсульфат В).
Ретикулярные волокна располагаются преимущественно субэпидермально вокруг сосудов, сальных и потовых желез, а также волосяных фолликулов.
Клеточные элементы дермы

- Фиброциты и фибробласты
- Гистиоциты
- Тканевые базофилы
- Плазматические клетки
- Лимфоидные клетки

Кровоснабжение кожи:

- Глубокое кожное артериальное сплетение отходит от магистральных сосудов, которые находятся на границе между дермой и пжк, питают потовые и сальные железы, луковицы волос тельца фатера-пачини пжк.
- От глубокого артериального сплетения отходят сосуды и в сосочковом слое дермы образуют поверхностную сосудистую сеть, отходящие от нее каппиляры проникают в сосочки где и заканчивается кровоснабжение кожи, образуют петли и возвращаются назад в виде венозных каппиляров, формирую венозные сети
- Поверхностная сеть расположена около основания сосочков,вторая сеть немногогубже первой. Третья вен. Сеть между глубокой и поверхностной , четвертая на уровне глубой арт сети.

ПРИДАТКИ КОЖИ

1) Потовые железы

- **Эккринные потовые железы** – во всех отделах кожного покрова, за исключением красной каймы губ, кожи малых половых губ, головки полового члена и крайней плоти. Железа состоит из концевого отдела расположенного в сетчатом слое, и выводного протока идущего перпендикулярно к поверхности эпидермиса.
- **Апокриновые** – в подмышечных впадинах, в области грудных сосков, наружных половых органов, вокруг пупка и заднего прохода, в коже наружного слухового прохода. Функция апокриновых желез связана с половыми железами; у детей, до полового созревания и в старческом возрасте они не функционируют (гидраденит).

2) САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- Простые альвеолярные голокринновые железы.
- Разновидности: однодольчатые, двухдольчатые и пятидольчатые.
- во всех участках тела, за исключением ладоней и подошв, могут быть связаны со структурами волоса, но имеются и свободные сальные железы. За недели выделяют 100-200 г кожного сала.

3) ВОЛОСЫ

- длинные – голова, борода, усы, половые органы, подмышечные впадины
- щетинистые – брови, ресницы, наружный слуховой проход, слизистая носа
- пушковые – по всей поверхности тела за исключением ладоней, подошв, слизистых, мест роста длинных и щетинистых волос.

Строение волоса:

- Волос состоит из стержня и корня. Волосяной фолликул состоит из 3 частей: глубокой части — от сосочка до соединения с мышцей, поднимающей волос; средней - от соединения с мышцей,

поднимающей волос, до входа протока сальной железы и верхней части — от входа протока сальной железы до устья фолликула.

4) НОГТИ – роговой придаток кожи пластинообразной формы.

- Различают тело ногтя, свободный передний край, задний (корневой) край, два боковых края, ногтевые валики окружают ноготь с трех сторон.Темп роста ногтей индивидуальный и зависит от возраста, общего состояния, периферического кровообращения. Полное обновление ногтевой пластинки происходит в течение 3 - 4 месяцев; за день ноготь вырастает на 0,1 - 0,2 мм.Под ногтевой пластинкой расположено ногтевое ложе, в котором отсутствуютт сосочки дермы, но обильно снабжено кровеносными сосудами и нерными окнчаниями.

3. ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЖНЫХ СЫПЕЙ. **ПУЗЫРЕК (vesicula)** – п п м э, образуется в результате спонгиоза(межклнт отек) или баллонирующей или вакуольной дегенерации, исходит из эпидермиса, разм до 5 мм. При вскрытии образ эрозия, которая покрывается корочкой, после себя оставл пигментацию или изчез бесследно. **ПУЗЫРЬ (bulla)** – п п м э,диаметр больше 5 мм., Плоской или полушаровидной формы, содержимое гемморагическое,мутное или сероное. Локализ- интрадермально(вульг пузырчатка) и субэпидермально(дерматит дюринга) . механизм акантолиз(рассплавление межклет сзязей клеток шиповатого слоя). **ГНОЙНИЧОК (pustula)** – п п м э. может распологаться во всех слоях кожи. Эпидермальные пустулы послевскрытия форм язвы, покрыв корочками, и после седя рубца не оставляют.. Пустулы из дермы или пжк послк вскрытия оставляют язвы, которые оставл рубцы(фур, карб, гидра), фолликул пустулы связаны с волос фоллик и пронизаны волосом(фурункул). При стрептококовом поражении пэс- фликтены не связаны с волос фоликулом. **ВОЛДЫРЬ (urtica)** – островоспалительный, экссудативный, п бесп м э, возникающий в результате ограниченого отека сосочкового слоя дермы,существует от нескольких минут до нескольких часов. Цвет от розово-красного до диолетово-белого, размером от горошины до ладони. Исчезает бесследно. Возникает обычно как аллергическая реакция немедленного типа на эндогенные или экзогенные раздражители. (крапивница, токсикодермия). **ПЯТНО (macula)** – бппмэ, характ изменением окраски кожи. Пятна бывают сосудистые, пигментные и искусственные. Сосудистые пятна из сосочкового слоя дермы,заа счет разрушения сосудов(эритема), изчезают при надавливании(экзема), нарушение целостности сосуд стенки(петехии, разреш бесследно.пигментные наруш пигментобраз,из эпидермиса(веснушки пигмент невус). Искусственные татуировки **БУГОРОК (tuberculum)** возникает в дерме за счет ограниченного продуктивного воспаления - гранулемы, возвышается над уровнем кожи, плотной, тестоватой или мягкой консистенции., может некротизироваться или рассасываться, всегда оставляет рубец или рубцовую атрофию(третичный сифилис) **УЗЕЛ (nodus)** - крупное шаровидное образование, расположенное в глубоких слоях дермы и подкожной клетчатке, образуется в результате формирования клеточного инфильтрата (инфекционная гранулема). Воспалительные и невосполительные. При распаде язвы, заживают рубцом. **УЗЕЛОК (papula)** – п бес м э, характеризующийся изменением окраски кожи, её рельефа, консистенции и разрешающийся, как правило, бесследно. Папулы больших размеров называются бляшками.по величине милиарные, лентикулярные,нумулярные. По форме шаровидные, конусовидные, плоские.

4. ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЖНЫХ СЫПЕЙ. **Пятно(macula)** может быть вторичным морфологическим элементом в случае появления на месте рассосавшихся первичных элементов (папул, пустул и др.).гипопегмент пятна формир в связи с уменьшение содерж меланина. **ТРЕЩИНА (fissura)** – втор морф э, представляющий собой линейное нарушение целостности кожного покрова в результате снижения эластичности кожи,геперкератоза, восп инфильт в складках кожи.пов безследа а глуб рубцы.. **Экскориация (excoriatio, ссадина)** проявляется нарушением целостности кожного покрова в результате механического повреждения его при травмах и расчесах.,при чесотке, зуд дерматоз,поверх бесследно, глуб –рубцы. **ЭРОЗИЯ (erosio)** возникает при вскрытии первичных полостных морфологических элементо(пузырьков, пузырей, пустул)в и представляет собой нарушение целостности кожного покрова или слизистой оболочки в пределах эпидермиса (эпителия). **ЯЗВА (ulcus)** – представляет собой нарушение целостности кожного покрова в пределах соединительнотканного слоя дермы, а иногда даже и подлежащих тканей. Возникает при вскрытии бугорков, узлов или глубоких пустул. В язве выделяют дно и края, которые могут быть мягкими (туберкулёз) или плотными (рак кожи) .**ЧЕШУЙКА (squama)** – представляет собой отторгнувшиеся роговые пластинки, формирующие шелушение. По величине бывает мукоидные, отрубевидные, мелко и крупнопластинчатые. Физиологическое шелушение происходит постоянно и обычно незаметно. При патологических процессах (гиперкератоз, паракератоз) шелушение приобретает гораздо более выраженный характер. **КОРКА (crusta)** – возникает при ссыхании содержимого пузырьков, пузырей, гнойничков.бывают серозные гнойные сероззно-гнойные, кровянистые. **РУБЕЦ (cicatrix)** – возникает при заживлении язв, бугорков, узлов, глубоких пустул. Представляет собой новообразованную грубоволокнистую соединительную ткань (коллагеновые волокна). Различают плоские, атрофические, келлоидные. **ЛИХЕНИФИКАЦИЯ (lichenizatio, синоним: лихенизация)** характеризуется утолщением, уплотнением кожи за счет папулёзной инфильтрации, усилением кожного рисунка. Лихенефикация развивается при хронических воспалениях, обычно сопровождается зудом(нейродермит). **ВЕГЕТАЦИЯ (vegetatio)** характеризуется разрастанием сосочкового слоя дермы, имеет ворсинчатый вид, напоминающий цветную капусту или петушиные гребешки..

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОЖИ. ГИГИЕНА КОЖИ.

Защитная функция:

- Роговой слой, содержащий кератин и липиды, обеспечивает устойчивость к химическим и физическим воздействиям, обладает значительной электросопротивляемостью.
- Предотвращает высыхание кожи благодаря наличию водно- липидной мантии.
- Осуществляет защиту от микробной флоры
- Фото- и радиопротекторное действие (пигмент меланин).механ защ из-за пжк и волокон

Терморегулирующая функция обеспечивается за счет:

- низкой теплопроводности рогового слоя
- волокнистыми структурами дермы
- подкожной жировой клетчаткой
- состоянием крово- и лимфообращения в коже (расширения или сужения сосудов)
- выделительной способностью потовых и сальных желез центр и периф нервн сист

Резорбционная (всасывающая) и дыхательная функции кожи

- Резорбция различных жирорастворимых лекарственных веществ осуществляется через сальные и потовые железы, в меньшей мере – через роговой слой.
- При воспалении кожи резорбция веществ резко усиливается вследствие расширения сосудов дермы и патологических изменений эпидермиса. Кожа поглощ 1\180 o2 b dsl 1\90 co2

Секреторная функция

- Продукция кератиноцитами основного белка эпидермиса кератина.
- Сальные железы продуцируют кожное сало, содержащее жирные кислоты, эфиры холестерина, свободный холестерин, спирты, углеводороды, глицерин, азотистые и фосфатные соединения.
- Потовые железы, продуцируя пот, охлаждают кожу, участвуют в терморегуляции, pH эккринных потовых желез слабокислый.

Рецепторная функция (функция органа чувств)

- Кожа чувствительна к магнитно-радиационным атмосферным воздействиями, внешним раздражающими факторам, являясь мощным рецепторным полем, воспринимающим тепло, холод, боль, прикосновение.
- Проецирует функциональные и органические изменения внутренних органов, ЦНС, эндокринной и иммунной систем, осуществляет дермонейротропные и дермовисцеральные связи.

Обменная функция:

- Благодаря гидрофильности дермы и пжк в них задерж мин. В-ва. , витамины, накап аллергены и токсик в-ва.
- Осуществляется синтез эргокальциферола, накопление витамина А , синтезе половых гормонов.

Иммунологическая функция кожи Обеспечивается сложной иммунореактивной системой эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки, препятствующей проникновению и распространению чужеродных антигенов в организме человека. 1.кератиноциты(сходны поструктурой и по фукнц с клетками тимуса(обеспеч контакт с клетками лангерганса и гринштейна, спос созрев Т-ЛИМФОЦИТОВ., продуц ряд медиаторов им ответа))Т-лимф 90%распол в эпиди верх слоях дермы,В-лимф-в сред и ниж слоях дермы,клетки пришельцы(взаимодействие Т-лимф с неспец факторами защиты), базальная мембрана препятств проникновению.

ГИГИЕНА КОЖИ - это основа личной гигиены. Чтобы кожа была молодой и красивой, нужно правильно и регулярно ухаживать за ней.

Нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и полноценное питание способствуют поддержанию хорошего состояния кожи.

Для очистки от загрязнений, кожного сала, пота, микроорганизмов и чешуек требуется регулярное соблюдение правил гигиены кожи. Ванны продолжительностью до 15 минут следует принимать как минимум раз в неделю, а душ без мыла с водой комнатной температуры желательно принимать ежедневно.

Независимо от типа кожи, ее следует увлажнять и подпитывать.

Сухую и морщинистую кожу после умывания полезно смазать питательным кремом, а жирную кожу лица вместо умывания лучше протирать специальными лосьонами.

Кожу ног (голени, стопы) нужно мыть 2-3 раза в неделю, область половых органов и промежность - ежедневно перед сном.Ногти следует мыть щеточкой, каждую неделю подрезать их,подногтевое пространство очищать специальной ногтечисткой. Женщинам полезно периодически делать маникюр и педикюр.

6. Патогистологические изменения кожи

- Нарушение процессов ороговения
- Воспалительные или экссудативные процессы
- Пролиферативные процессы

Нарушение процессов ороговения

- Гиперкератоз-избыточное ороговение, ведет к утолщ рогового слоя(ихтиоз)
- Гипокератоз-истончение рогового слоя(атроф процессы кожи)
- Паракератоз- неполноценное ороговение, в отторгающ чешуйках сохраняются измен ядра клеток рогового слояя, исчезновение блестящего и зернистого(псориаз)
- Дискератоз- неправильное ороговение, преждевременное ороговени шиповатого слоя

Воспалительные или экссудативные процессы

- Внутриклеточный отек(вакуолная дегенерация)- изменение клеток шиповатого слоя, при котором внутри клеток скапливается экссудат, протоплазма мутнеет, ядро на переферии, границы между клетками нечеткие.
- Акантолиз- рассплавление межклеточных связей клеток шиповатого слоя. Между ними накапливается эксудат и возникает пузырь(вульгарная пузырчатка)
- Спонгиоз- межклеточный отек, скопление экссудата между клетками шиповатого слоя, образубтся пузырьки(экзема).
- Баллонирующая дегенерация- сочетание явлений спонгиоза с некробиозом клеток, в результате чего образуются пузырьки,пузыри.

Пролиферативные процессы

- Гранулез- утолщение зернистого слоя за счет увеличения числа клеток. За счет неравномерного утолщения зернистого слоя образуется «сетка»-уикхема(красный плоский лишай)
- Акантоз- утолщение мальпигиевого слоя эпидермиса, за счет увеличения рядов шиповатого слоя, что приводит к увеличению расстояния между сосочками дермы, в результате чего появляется симптом «кровяной росы» или «точечного кровотечения» при псориазе.
- Папилломатоз- разрастание сосочков дермы, в результате чего они удлиняются и доходит до роговорого слоя(вульгарные бородавки).

7.Формы для местного лечения дерматозов

Местное применение лек форм преследует 2 цели:

- Воздействие на причинц заболевания(этиотропное лечение)
- Предохранение пораженного участка кожи от влияния внешних факторов(патогенетическая терапия)

Лекарства для местного применения могут назначаться в различных лек формах.

1. Твердые-присыпки
2. Жидкие и мягкие- растворы(примочки),мази, пасты, кремы, линименты(жидкие мази),суспензии(эмульсии)

Присыпки- смесь мельчайших порошкообразных веществ минирального, органического или раст происхождения.(адсорбирующее, охлаждающее, противовосполит действие)(острое и подострое восп кожи)

Растворы применяют для примочек. Примочкипредставляют собой раствор лек средств в дистиллированной воде (адсорбирующее, охлаждающее действие, мокнутие, отек, острое воспаление.

Мазь – мягкая лекарственная форма, соятоящая из мазевой основы(ланолин,вазелин, свинное сало) и не более 25% порошкообразных веществ. По характеру действия мази могут быть кератопластическими (салициловая кислота до 5%) и кератолитическими (больше 5%0. Подострые и хронические воспалит процессы кожи. Широко применяются мази содержащие кортикостероиды(противоспалительное и гипосенсибилизирующее действие), мази на основе липосомальной эмульсии с включение бав.

Паста – лек форма, состоящая из смеси равных по количеству жировых веществ и индифферентных порошков. Обычная паста из равных количеств , мягкую пасту (больше жира) и твердую пасту (больше порошка).адсорбция смягчение рогового слоя (подострое воспаление)

Взбалтываемые суспензии – мелкозернистые порошкообразные вещества, находящиеся во взвешенном состоянии в воде с глицерином или в растительном масле. Порошкообразных веществ должно быть 1\3 от части всего объема. Адсробция , охлаждение сужение сосудов. Распространненны острый процесс без явлений мокнутия. **Кремы** – состоят из жировой основы , порошка и воды. Эта лек формаблизма к кожной смазке и лучше переносится кожей . адсорбция сужение сосудов . острое и подострое воспаление.

Лаки используются для нанесения лек в-в на ограниченный участок кожи. За основу используется коллодий

По характеру действия формы подразделяются на: антисептические(анилиновые краски 1-2%),антипаразитарные(сера до 33%), фунгицидные(деготь до 20%), вяжущие(1-2% таниновая кислота), кератопластические(нафталан 5-10%),кератолитические(салициловая кислота), противозудные(камфора 5-10%), фотозащитные(ттанин 5-10%_, фотосенсибилизирующие, рассасывающие, прижигающие, противовосплательные.

8. СТРЕПТОКОККОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ. Импетиго КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА.

СТРЕПТОКОККОВЫЕ ПИОДЕРМИты – это гнойничковые болезни (инфекционные поражения кожи, которые вызваны внедрением бактерий).не поражает придатки кожи, заразная, чаще женщины и дети. **Возбудители** – гноеродные бактерии (в-гемолитичесский стрептококки). Они находятся на коже, одежде, личных вещах (полотенце, расческа и др.), во вдыхаемом воздухе.

Формы

Стрептококковое Импетиго – первичным элементом является вялый пузырь (фликтена)на фоне гиперемированной кожи, пузырь склонный к периферическому росту. Заражение происходит через игрушки, полотенца, руки. Поражается кожа лица, рук в виде фликтен, подсыхающие в медово—желтые корки. За счет слияния элементов формируются полициклические фигуры.

Локализация.

- Кожа лица (в области усов и бороды).
- Красная кайма губ:
- покраснение, отек, трещины, шелушение, корки;
- болезненность при движении губами, трещины при этом могут увеличиваться и кровоточить.

Выделяют несколько форм импетиго.

Буллезное – на тыле кистей, нижних конечносятх. Вялые пузыри большого размера,с мутноватым сожержимым.

Кольцевидная – на коже лица, рук с появление красных пятен и фликтен, ссыхаются в корки желтого цвета. В центре может быть заживление а по периферии рост.

Турниоль(поверхностный панариций)- проявляется фликтенами вокруг ногтевых пластинок, эрозиями и болезненностью ногтевой фаланги.

Щелевидное (заеды) –в углах рта, эрозия трещинка с обрывками эпидермиса, покрыв корочками, зуд и полезненность при приеме пищи.

Простой лишай –чаще проявяется на коже лица светло-розовыми пятнами.

Импетиго слизистых- на слизистых носа, рта, конъюнктивы в виде очагов появляются дряблые пузыри, быстро вскрываются.

Вульгарная Эктима — локализуется чаще на коже голеней, бедер, ягодиц, поясничной области, появляется воспалительный инфильтрат или глубокая пустула, которая через 2-3 дня подсыхает в гнойно-кровянистую корку, под которой находится язва, заживающая рубцом.
локализация — нижние конечности (голени, бедра, ягодицы), поясница.

Лечение стрептококковых пиодермий

При импетиго: - спиртовые растворы анилиновых красок,10% борно-дегтярная мазь, мази с антибиотиками, Тридерм, обтирание здоровой кожи вокруг очагов салициловой кислотой(2%)

при эктиме: - общее- витамины, антибиотики

местно мазь с антибиотиками, стимуляторы регенерации

Профилактика стрептококковые пиодермии

Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук и тела с мылом и др.).

Правильный уход за кожей (ранняя обработка дезинфицирующими растворами поверхностных травм кожи (царапин, расчесов, трещин)).

Сбалансированное и рациональное питание (употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки (овощи, фрукты, зелень), отказ от консервированной, жареной, острой, соленой пищи).

9. СТАФИЛОКОККОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ. Остиофоликулит, фолликулит, фурункул, карбункул, гидрааденит

Особенность стафилококковых пиодермий - развитие воспалительного процесса преимущественно в области придаточных образовании кожи; волосяных фолликулов, сальных и потовых желез, а также гнойный или гнойно-некротический характер воспалительной реакции. Первичный элемент- пустула с плотной покрышкой.

ОСТИОФОЛЛИКУЛИТ

Остиофолликулит начинается с покраснения вокруг устья фолликула, быстро образуется конусообразное припухание с пустулой в центре, пронизанная волосом. Через несколько дней пустула подсыхает , образуется корочка, затем бесследно исчезает. Локализация- лицо, шея, плечи, бедра, голени .предрасполагающие факторы: повышенная потливость, мацерация кожи, загрязнение кожи.

Лечение. общее лечение обычно не проводится, только в случаях частых рецидивов, местно: обтирание здоровой кожи вокруг очагов салицилловым спиртом.., на очаги- анилиновые красители, пасты, содержащие антисептик.

ФОЛЛИКУЛИТ (folliculitis) стафилококки проникают в глубь фолликула, вызывают его воспаление.

Появляются болезненные гиперемированные узелки, превращающиеся в пустулы, пронизанные волосом. Происходит нагноение и некроз. Через неделю процесс заканчивается образованием мелких рубчиков. Локализация- волосистая часть головы и задняя поверхность шеи.

Лечение

Общее лечение обычно не проводится, только в случаях частых рецидивов. Местно- обтирание здоровой кожи вокруг очагов 3% саллициловым спиртом, на очаги- анилиновые краски, лаки с антисептиками.

ФУРУНКУЛ (чирей, furunculus) - острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей его соединительной ткани. Вызывается внедрением извне патогенных стафилококков. Проходит стадии созревания, разрешения и рубцевания. Кожа над инфильтратом окрашена в багрово-красный цвет. Развитие инфильтрата сопровождается нарастающей болезненностью. В окружности инфильтрата отмечается отёчность, которая при некоторых локализациях фурункула, например на лице, особенно около губ и глаз, а также на мошонке, может быть резко выражена. В результате процессов созревания некротический стержень вместе с гнойно-некторическими массами отторгается с образованием гранулирующей кратерообразной язвы, которая быстро рубцуется. На 3-4-и сутки в центре инфильтрата начинает определяться флюктуация Вскоре после размягчения фурункул вскрывается и из его толщи выделяется небольшое количество гноя. После отхождения гноя в месте прорыва выявляется некротическая ткань зеленого цвета, так называемый некротический стержень.

Лечение

В 1-ю стадию- УВЧ, при необходимости волосы вокруг очага выстригаются, участки вокругочага обрабатывают саллициловым спиртом. 2-ю стадию –вскрытие фурункула, дренирование, стерильные салфетки прикрепляются к коже бактерицидным пластырем. После ооторжения некротического стержня на язву мази с антибиотиками.

КАРБУНКУЛ

Карбункул- острое гнойно-некротическое воспаление нескольких сально-волосяных фолликулов с вовлечением в процесс лимфатических сосудов, глубоких слоев дермы и подкожно-жировой клетчатки. Образуется резко болезненный плотный инфильтрат, постепенно увеличиваясь, он может достигнуть величины детской ладони. Кожа над инфильтратом окрашена в багрово-красный, а в центральной части - в синюшный цвет. Образуется в результате слияния между собой нескольких фурункулов, и проходит те же стадии развития что и фурункул , только с образованием инфильтрата большого размера и более обширной зоной воспаления.

Лечение .Назначают антибиотики, в частности группы пенициллина (амоксициллин, ампициллин), детоксикационная терапия, флюктуирующие зоны вскрывают и дренируют. Для ускорения заживления язвы используют местные средства, ускоряющие регенеративные процессы(мазь Микулича).

ГИДРАДЕНИТ (hidradenitis) - гнойное воспаление апокринных потовых желез. Локализуется чаще всего в подмышечных впадинах (обычно одностороннее), реже - в области заднего прохода, у женщин - в области больших половых губ. НЕ болееют дети до полового созревания и старики. В толще кожи образуются вначале небольшие, величиной с горошину, болезненные узлы, которые быстро увеличиваются и возвышаются над уровнем окружающей здоровой кожи. Кожа над ними окрашена в багрово-красный цвет.Узлы вскрываются, выделяя сливкообразный гной, некротический стержень отсутствует, заживает рубцом.

Лечение

Такое же как и при фурункуле.

10. Пиодермии. Этиология, классификация, дифференциальная диагностика стрепто- и стафилодермий. **Пиодермии**— это большая группа дерматозов, вызываемых гноеродными кокками, в основном стафилококками и стрептококками. Возникают пиодермии как первичные заболевания кожи или как осложнения других дерматозов в результате микротравм, расчесов.

Возбудители пиодермии:

- стрептококки(зеленящий, гемолитический);
- стафилококки(золотистый, гемолитический).

Экзогенные факторы:

- травматизация кожи, повышенная влажность, перенагревание и переохлаждение организма и др.

Эндогенные факторы:

- нарушение углеводного обмена(сахарный диабет),эндокринный расстройства,ослабленный иммунитет, нарушение питания

Классификация пиодермии:

1. По этиологическому фактору:

   - стафилококковые,стрептококковые,смешанные

2. По глубине расположения:

   - поверхностные,глубокие

3. По течению:

   -острые и хронические

Диф диагностика стафиллодермий:

- Абсцессы
- Паразитарный сикоз
- Узловатая эритема
- Скрофулодерма
- Сибирская язва
- Сифилис

Диф диагностика стрептодермий:

- Кандидоз слизистых
- Кандидоз ногтевых валиков
- Первичный сифилис(твердый шанкр)
- Вторичный сифилис(пустулезный сифилид)

11. Иммунотерапия пиодермитов, показания для назначения.

Как правило, пиодермиты формируются у больных с явлениями вторичной иммунной недостаточности. Особенно выражены состояния изменения активности неспецифических факторов защиты организма. В связи с этим в лечебный комплекс больных пиодермитами часто включается специфическая и неспецифическая иммунотерапия, способствующая стимуляции процессов иммунитета. В комплексе терапевтических воздействий у больных гнойничковыми заболеваниями кожи значительное место занимают

Препараты специфического иммуномодулирующего действия:

- стафилококковый анатоксин,
- нативный и адсорбированный стафилококковый бактериофаг,
- стафилококковый антифагин,
- антистафилококковый гамма-глобулин,
- стрептококковая вакцина,
- бактериофаг стрептококковый,
- аутовакцина,
- Антистафилококковаяплазма.

Неспецифическая иммунотерапия- витамины группы А,В,С, пиротерапия(пирогенал), аутогемотерапия, иммуномодуляторы(тималин).

12. Разноцветный (отрубевидный) лишай. Этиология. Клиника. Лечение. Диагностика.

Разноцветный (отрубевидный) лишай- грибковое заболевание невоспалительного характера с поражением рогового слоя эпидермиса. Чаще болеют молодые лица с повышенной потливостью. **Возбудитель**- Malassezia- слабоконтагиозный дрожжеподобный липофильный микроорганизм.

Заболевание имеет хроническое течение с частыми рецидивами. Контагиозность незначительная.

Клиническая картина: типичная локализация- кожа плеч, груди, спины и живота. Характерезуется наличием желтовато- коричневого цвета пятен с мукоидным шелушением. Шелушение напоминает отруби, поэтому и название отрубевидный лишай. После загара остаются депигментированные белые участки кожи.

Диагностика: основывется на клинической картине болезни, осмотр под люминисцентной лампой Вуда, смазывание кожи спиртовым раствором йода (в очаге поражение более интенсивное окрашивание). Посев на среду сабуро.

Диф диагностика:

- Сифилитическая розеола
- Розовый лишай Жибера
- Лепра
- Сифилитическая лейкодерма

Лечение:

Основано на применеии кератолитических и противогрибковых средств. При распространенных формах кетоконазол. Шампуни с противогрибковыми препаратами, раствор салициллового спирта 2-5%.

Профилактика: обязательная дезинфекция нательного и постельного белья. Соблюдение праввил личной гигиены.

13. Псевдомикозы: эритразма, актиномикоз. Клиника, диагностика, лечение.

Эритразма— поверхностный псевдомикоз. Возбудитель рода Corynebacterium. Заражение возможно через ванну, белье, при полом акте.

Локализация болезни характерна в пахово-бедренно мошоночной области у мужчин и в подмышечных впадинах, под молочными железами, вокруг пупка у женщин. Дети болееют крайне редко.

Клиническая картина- проявляется наличием светло-коричневого или кирпично-красного цвета очагов с четкими фестончатыми или дугообразными очертаниями. Поверхность пятен гладкая или с нежным отрубевидными чешуйками. По краю очагов слегка возвышающийся валик , а в центре буроватая пигментация.

Диагностика основана на клинике и локализации поражения, микроскопическое исследование, применение люминисцентвого свечения лампой Вуда.

Лечение проводится спиртовыми растворами йода, салициловой кислоты, резорцина, клотримазол, внутрь орунгал.

Актиномикоз— глубокий псевдомикоз., хроническое гранулематозное гнойное поражение различных тканей и органов. **Возбудитель** – аэробные и анаэробные лучистые грибки Actinomycetales. Распространен повсеместно. Почва (особенно огородная) содержит большое количество актиномицетов. Кроме человека актиномикозом болеют и крупно рогайтый скот, лошади, свиньи, собаки.

Источником заражения являются актиномицеты, содержащиеся на травах, злаках, а также возможен и аэрогенный путь заражения.

Клиническая картина: Течение приемущественно хроническое. Различают 3 клинические форма кожного поражения: **язвенную, бугорково-пустулезную, гуммозно-узловатую.** Наиболее часто проявляется гуммозно-узловатая форма, когда в подкожной клетчатке появляются плотные узлы, образуют болезненный синюшно-багровый инфильтрат который вскрывается свищами. Лимфоузлы поражаются крайне редко обычно увеличиваются плотные и безболезненные.

Диагноз подтверждаентся нахождением друз иои мицелия гриба в гнойном отделяемом.

Лечение приминяют актинолизат, пенициллин, стрептомицин, эритромицин,, одногруппная кровь, общеукрепляющие средства.

Профилактика заключается в предупреждении травм, санации ротовой полости, зева, в чистоте рук и личной гигиене.

14. Поверхностная трихофития. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Эпидемиология

Вид грибов возбудителей:

• По отношению к волосу Trichophyton endothrix

• Чистая культура – Trichophyton violaceum (от больных телят) и Trichophyton crateriforme (грызуны).

Болеют: дети в дошкольном и школьном возрасте

Источник заражения : , дети болеющие трихофитией; женщины ,бабушки , прабабушки болеющие хронической , трихофитией

Путь передачи :

1. – Прямой путь контакт с больными
2. – Непрямой путь через предметы обихода ,расчески гребешки головные уборы и др

Клинические формы:

1. Поверхностная трихофития волосистой части
2. Поверхностная трихофития гладкой

Клиника:

Волосистая часть головы

•На волосистой части головы имеется несколько очагов округлой формы один , очаг большой материнский ,слегка гиперемированы со слабовыраженным шелушением . В очаге поредение волос за счет их обламывания на высоте 1-2 мм. Имеются и видимо здоровые волосы Может быть небольшой зуд. Очаги постепенно в увеличиваются в размерах и могут занимать обширные участки.

Гладкая кожа

• Поражение гладкой кожи проявляется наличием эритематозно -сквамозных пятен на - открытых участках кожи с четкими границами , имеющими зоны по периферии валик с 2 мелкими пузырьками в центре отрубевидное шелушение . Иногда может проявляться в виде колец или кольца в кольце форма ириса . На диспансерном учете находятся три месяца Без лечения поверхностная трихофития при наступлении полового созревания самоизлечивается . Однако преимущественно у женщин может не наступить самоизлечение и болезнь переходит в хроническую трихофитию взрослых

Диагностика трихофитии

Диагностика осуществляется с помощью лабораторных и инструментальных методов исследования.Микроскопическое исследование. С очагов поверхностной и хронической трихофитии на гладкой коже соскабливают тупым скальпелем чешуйки и "пеньки" обломанных пушковых волос. Обломанные волосы удаляют пинцетом.

Культуральное исследование. Рост колонии отмечается на 5-6-й день после посева в виде белого комочка.

Лечение трихофитии

При лечении трихофитии гладкой кожи без поражения пушковых волос применяют наружные противогрибковые препараты. На очаги поражения утром наносят 2-5% настойку йода, а вечером смазывают противогрибковой мазью.

Профилактика трихофитии

Профилактика заключается в своевременном выявлении, изоляции и лечении больных этим заболеванием. Необходимы периодические медосмотры в детских учреждениях. Обязательно обследуются родственники и контактировавшие с больным лица. Особое внимание следует уделять домашним животным (коровы, телята), поскольку именно они часто служат источником инфекции.

15. Хроническая трихофития. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Трихофития хроническая обычно начинается в детском возрасте, но со временем у девочек формируется хроническая (так называемая "черноточная") трихофития, а у подавляющего большинства мальчиков к пубертатному периоду происходит спонтанное излечение болезни

Хроническая трихофития гладкой кожи

Хроническая трихофития гладкой кожи имеет вялое и длительное течение. Это связано со сниженной реактивностью организма. В очагах поражаются пушковые волосы, и часто имеется сочетанное поражение волосистой части головы и ногтей. Бывает легкий зуд, но чаще жалоб нет.

Очаги располагаются в основном на коже голеней, ягодиц, коленных суставов, предплечий, реже всего - на лице и туловище. Очаги имеют застойно синюшный цвет, без резких границ, могут быть покрыты чешуйками, чем напоминают очаги хронической экземы. На ладонных поверхностях- мукоидное шелушение, ногтевые пластинки тусклые, легко крошатся.

Хроническая трихофития волосистой части головы

Местами локализации патологических очагов являются теменная и височные области. Очажки небольшие, бледно-красноватого цвета с синюшным оттенком. Пораженные волосы обломаны на одном уровне с гладкой кожей и напоминают черные точки, так называемые комедоны.

Диагностика:

С очагов поверхностной и хронической трихофитии на гладкой коже соскабливают тупым скальпелем чешуйки и "пеньки" обломанных пушковых волос. При поражении волосистой части головы предпочтительно производить забор патологического материала в периферических зонах очагов, так как здесь больше элементов гриба. Обломанные волосы удаляют пинцетом.

Лечение:

При лечении трихофитии гладкой кожи без поражения пушковых волос применяют наружные антимикотические препараты. На очаги микоза утром наносят 2-5-проц. настойку йода, а вечером смазывают противогрибковой мазью.

Профилактика трихофитии, так же как микроспории, заключается в своевременном выявлении, изоляции и лечении больных этим заболеванием. Необходимы периодические медосмотры в детских учреждениях. Обязательно обследуются родственники и контактировавшие с больным лица. При зоонозной трихофитии особое внимание следует уделять домашним животным (коровы, телята), поскольку именно они часто служат источником инфекции.

16. Инфильтративно-нагноительная трихофития, паразитарный сикоз. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Инкубационный период инфильтративно-нагноительной трихофитии составляет от 1-2 недель до 1-2 месяцев. Она начинается с появления одного или нескольких бледно-розовых шелушащихся пятен с округлыми очертаниями и четкими границами. Краевой валик выполнен бляшками, мелкими пузырьками, ссыхающимися в корочки. В дальнейшем очаги увеличиваются в размерах, нарастает воспаление, они возвышаются над уровнем здоровой кожи. При слиянии очаги формируют причудливые фигуры, поверхность их покрыта бляшками, пузырьками, гнойничками и корочками.
Весьма характерным признаком являются резко расширенные устья волосяных фолликулов, выполненные гноем, выделяющимся при надавливании в виде обильных капель и даже струек.. Корни волос расплавляются и выпадают вместе с гнойным субстратом. Процесс разрешается рубцовой атрофией.
При инфильтративно-нагноительной трихофитии нередко наблюдается увеличение лимфатических узлов.
Диагностика
Эпидемиологический анамнез
Клиническая картина
Микроскопического исследования
Бактериологического исследования
Лечение:
При инфильтративно-нагноительной трихофитии проводится удаление корок при помощи 2-3-проц. салициловой мази. Используются дезинфицирующие растворы (фурацилин, риванол, калия перманганат, раствор ихтиола
Профилактика трихофитии, так же как микроспории, заключается в своевременном выявлении, изоляции и лечении больных этим заболеванием. Необходимы периодические медосмотры в детских учреждениях. Обязательно обследуются родственники и контактировавшие с больным лица. При зоонозной трихофитии особое внимание следует уделять домашним животным (коровы, телята), поскольку именно они часто служат источником инфекции.
Сикоз – это гнойничковое заболевание кожи, вызываемое золотистым стафилококком. В основе развития сикоза лежат нейро-эндокринные нарушения, которые изменяют чувствительность фолликулов.
Клиника:

Сикоз возникает на волосистой части лица, поражается область усов и бороды. Сикоз начинается с образования поверхностных фолликулитов, которые располагаются группами в виде дисков. По мере роста фолликулитов в процесс вовлекаются соседние участки кожных покровов, и в итоге сикозом поражается большая часть кожи.
Пораженная сикозом кожа резко воспалена, гиперемирована и отечна. Нарастает болезненность при прикосновении и гиперчувствительность пораженного участка. При сикозе кожа покрывается большим количеством гнойничков, которые очень близко расположены друг к другу, их основание уплотнено и имеет ярко-красный цвет.

Диагностика:
По результатам микроскопии исключается или подтверждается микотическая флора. Посев и культуральное обследование гнойного отделяемого и корочек проводят до назначения антибиотикотерапии, так как в противном случае выделить возбудителя гораздо сложнее
Лечение:
Заключается в местном применении антимикробных мазей и в приеме антибиотиков во внутрь
Профилактикой сикозов является соблюдение гигиены, аккуратность во время бритья и обработка антисептиками мелких травм, чтобы не допустить их инфицирования.

17. Микроспория (зоофильная). Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, диспансеризация, профилактика.

Микроспория «стригущий лишай»— заразная болезнь животных, вызываемая грибами рода Microsporum, характеризующаяся поражением кожи и её производных. Болеет микроспорией и человек.

Зоофильная микроспория

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Вид грибов возбудителей: Microsporum canis, Microsporum lanosum

Болеют: дети и взрослые (преимущественно молодые женщины)

Источник заражения: хомяки, обезьяны, лошади, котята (реже кошки), собаки

Путь передачи:

1.прямой путь (контакт с животными)

2.непрямой путь (при контакте с предметами, инфицированными шерстью и чешуйками кожи животных)

Инкубационный период: 2-4 дня

Клинические формы

Микроспория волосистой части головы (1-2 крупных отечно инфильтративных очага правильных очертаний с четкими границами муковидным шелушением , .

(Микроспория гладкой кожи эритематозно сквамозные высыпания округлой или овальной формы с четкими границами ,валикообразно приподнятые отечные края , на них папуловезикулы пустулы серозно -гнойные корки чешуйки Центр в стадии , . разрешения)

Диагностика микроспории

1. Клиническая картина .
2. Люминесцентное исследование лампа Вуда для исследования.
3. Микроскопическое исследование
4. Бактериологическое исследование (посев).

Лечение микроспории гладкой кожи

При лечении микроспории гладкой кожи без поражения волос применяют наружные противогрибковые препараты. На очаги поражения утром наносят 2–5% настойку йода, а вечером смазывают противогрибковой мазью. Дважды в день применяются современные мази:

клотримазол,

циклопирокс,

Лечение микроспории волосистой части головы

При лечении этой формы заболевания до сих пор препаратом выбора остается гризеофульвин – антибиотик, продуцируемый плесневым грибом. Г

Профилактика

Профилактика микроспории заключается в своевременном выявлении, изоляции и лечении больных микроспорией. В детских учреждениях следует проводить периодические медицинские осмотры. Выявленного больного микроспорией ребенка необходимо изолировать от других детей и направить на лечение в специализированный стационар. Вещи, принадлежащие больному, подлежат дезинфекции.

Обязательно обследуются родственники и контактировавшие с больным лица. Особое внимание следует уделять домашним животным, поскольку именно они часто служат источником инфекции.

Диф диагностика: трихофития, фавус, рубромикоз.

18. Руброфития (рубромикоз). Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Эпидемиология:

Вид грибов возбудителей : Trichophyton rubrum

Болеют: пловцы,работники бань, душевых ,спортсмены, солдаты, рабочие горячих цехов и , угольных шахт

Источник заражения : больной человек

Путь передачи :

1. Прямой путь контакт с больным (общая постель
2. Непрямой путь контакт с предметами содержащими элементы гриба,в банях душах на пляжах в бассейнах спортивных залах

Инкубационный период : не установлен

Клинические формы :

1. Рубромикоз стоп
2. Рубромикоз стоп и кистей
3. Рубромикоз ногтевых пластинок

Типы:

- нормотрофический .
- гипертрофический .
- атрофический .

4. Генерализованный рубромикоз

Разновидности: а эритемно сквамозная . – б фолликулярно узловатая . – в экссудативная . г рубромикозная эритродермия .

5. Поражение пушковых волос

Клиника: рубромикоз ладоней и подошв проявляется сухостью кожного покрова, явлениями гиперкератоза, появлением трещин. Кожный рисунок в очагах поражения выраженый. Как правило поражаются все межпальцевые складки на стопах. При поражениях гладкой кожи отмечается покрснение кожи с явлениями шелушения и фолликулярные папулезные элементы. Рубромикоз ногтей поражаются все ногтевые пластинки на кистях и стопах. При гипертрофической форме они утолщаются за счет ногтевого гиперкератоза.ю становятся ломкими. При атрофическом типе ногтевая пластинка истончается и происходит ее отделение от ногтевого ложа.При нормотрофическом типе ноготь сохраняет блеск, поражается свободный край с боявление желто-белых пятен.

Диагностика:

Клиническая картина

Микроскопическое исследование

Бактериологическое исследование

Диф диагностика: кандидоз, нейродермит, псориаз.

Принципы **лечения** рубромикозов

А Общее . :

Системные антимикотики

Иммуномодуляторы

Биостимуляторы

Пирогенные препараты

Сосудорасширяющие средства

Аутогемотерапия

Витаминотерапия

Б Местное

Профилактике рубромикоза уделяется особое внимание ввиду распространенности этого заболевания среди городского населения. Обязательному осмотру подлежат работники бань, саун, спортивных комплексов и бассейнов. Индивидуальные банные принадлежности, отказ от совместного ношения одежды внутри семьи снижает риск внутрисемейных очагов рубромикоза и других инфекционных заболеваний.

19. Эпидермофития стоп. Эпидемиология, клинические разновидности, диагностика, лечение, профилактика.

Эпидемиология:

Вид грибов возбудителей: Epidermophyton mentagrophytes вариант interdigitale

Болеют: пловцы, работники бань, душевых, спортсмены, солдаты, рабочие горячих цехов и угольных шахт Источник заражения: больной человек

Путь передачи:

1.Прямой путь – контакт с больным (общая постель)

2.Непрямой путь – контакт с предметами, содержащими элементы гриба (в банях, душах, на пляжах)

Инкубационный период: не установлен

Клинические разновидности эпидермофитии стоп :

Сквамозная

Интертригинозная

Дисгидротическая

Ногтей (онихомикоз)

Сквамозная форма

самая частая у детей характеризуется эритематозными очагами с поверхностным отрубевидным шелушением в III – IV межпальцевых промежутках и на своде стопы . Участки поражения бывают ограниченными или распространенными сливными

Интертригинозная форма

При отторжении мацерированного эпителия образуются поверхностные мокнущие эрозии трещины Так возникает интертригинозная форма эпидермофитии трансформирующаяся , из сквамозной . поражаются межпальцевые складки между 4-5 пальцами стоп, тыл стопы.

Дисгидрот ическая эпидермофития

Может сформироваться первично или как следствие прогрессирования обостренной сквамозной формы На обширных участках свода стоп и меж пальцевых складок с переходом на тыльную поверхность стоп появляются диффузные сливные очаги , отечной интенсивности эритемы и множественные склонные к слиянию , многокамерные пузырьки с плотной покрышкой напоминающие саговые зерна.

Эпидермофития ногтей (онихомикоз) поражаются преимущественно I и V пальцы , за счет постоянной травматизации .Ногтевые пластинки грязно желтого цвета деформируются утончаются крошатся Ногтевое ложе гипертрофируется за счет избыточного ороговения под ногтевой пластинок напоминает коготь хищной птицы или может быть атрофия ногтевых пластинок

Диагностика:

Клиническая картина, локализация, микроскопическое исследование, бактериологическое исследование.

Диф диагностика: рубромикоз, дистрофическая экзема.

Лечение:

Противогрибковыми препаратами, которые продаются без рецепта, являются тербинафин (Ламизил), миконазол (Микатин), клотримазол (Лотримин) и толнафтат (Тинактин). Лечение должно длиться от 1 до 6 недель.**Уход за стопами**

Профилактика:

Поддерживайте свою стопу в чистом и сухом состоянии.

В общественных бассейнах и душевых носите шлепанцы для душа.

20. Эпидермофития крупных складок. Этиопатогенез, диагностика, лечение.

Вид грибов возбудителей: Epidermophyton inguinale

Болеют: дети в период полового созревания

Источник заражения: больной человек

Пути передачи:

1. Прямой путь- контакт с больным
2. Непрямой путь- через предметы обихода (мочалка,)

Факторы способствующие заболеванию: повышенная потливость, опрелость кожи, избыток массы тела, нарушение обменя веществ.

Клиническая картина: заболевание развивается в области крупных складок, чаще паховых, реже межъягодичных , под молочными железами, в подмышечных впадинах. Очаги поражения в виде пятен ярко-красного цвета, с четкими границами, отечным валиком по перефирии, сотоящим из пузырьков, пустул и корочек. Течение острое, сопровождаетсясильным зудом, жжением и болезненностью.

Диагностика :

1. Клиническая картина
2. Локализация
3. Микроскопическое исследование- обнаружение в чешуйках кожи из очагов поражения ветвящегося мицелия.
4. Бактериологическое исследование – выделение культуры гриба.

Лечение: при отсутствии островоспалительных явлений серно-салициловая мазь, клотримазол, 2 % настойка йода.противогрибковые кремы и мази с противовоспалительным действием – тридерм.

Профилактика: дезинфекция предметов личного использования. После разрешения болезни профилактически в течении 2-3 недель следует продолжить лечение.

21. Фавус. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика.

По отношению к волосу- Trichophyton endothrix

Болеют: дети с различными хроническими заболеваниями

Источник заражения- больной человек

Пути передачи:

1. Прямой буть- контакт с больными
2. Непрямой путь- через предметы обихода(расчески, головные уборы).

Фавус волосистой части головы

Формы:

1. **Скутулярная –** пятна , на которых образуются желтые блюдцеподобные плотные сухие корочки- скутулы. Волосы не обламываются, теряют блеск и легко выдергиваются. Заканчивается рубцовой атрофией и облысением.
2. **Сквамозная-** крупнопластинчатое шелушение на слегка гиперемированной коже, заканчивается атрофией.
3. **Импетигинозная-** в устьях фолликулов рустулы, образуются грязно-желтого цвета корки, заканчиваются атрофией.

Фавус ногтей , чаще пальцев рук. В толще ногтевой пластинки пятна желтого цвета, утолщения, норвоности и наличие бороздок.

Диагностика:

1. Эпидемиологический анамнез
2. Клиническая картина
3. Микроскопическое исследование
4. Бактериологическое исследование

Лечение: проводят гризеофульвином в сочетании с местными фунгицидными препаратами.

22. Общее и местное лечение грибковых заболеваний кожи и придатков кожи. Профилактика грибковых поражений кожи и придатков кожи.

Общее лечение заключается в назначении внутрь противомикробных антибиотиков:

- Гризеофульвин в таблетках для лечения микроспории, трихофитии и фавуса.
- Низорал в таблетках в течении 2-8 недель
- Орунгал в течении 30 дней
- Ламизил

Комплексная терапия кроме приема противогрибковых антибиотиков включает:

- Поливитамины В1,В6,В12, С 3 раза в день во время еды в виде лражже
- Глюконат кальция перед едой
- Гепатопротекторы
- Биогенные стимуляторы
- Иммуномодуляторы

Местное лечение:

- При островоспалительных процессахи явлениях мокнутия назначают примочки(2%борной кислоты)
- Антипаразитарная терапия (серно-дегтярная мазь, настойка йода) при поражении ногтей- удаление ногтевой пластинки, а затем назначают фунгицидные препараты
- Микоспор- крем для ногтей , одновременно происходит удаление размягченной ногтевой пластинки и противогрибковое лечение.

Профилактика:

- Санитарный надзор за уборкой и дезинфекцией помещений и инвентаря в банях, душевых, плаватеьных бассейнах
- Соблюдение санитарно-гигиенических правил в детских садах
- Проведение диспансерного наблюдения за больными после лечения в течение года с контроольными явками 1 раз в квартал
- Правильный уход за кожей рук и ног, за волосами и ногтями, борьба с повышенным потоотделением
- Санитарно- просветительная работа с населением

23. Кандидоз кожи и слизистых оболочек. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

КАНДИДОЗ (синоним: кандидамикоз) - заболевание кожи, слизистых оболочек и внутренних органов, обусловленное патогенным воздействием дрожжеподобных грибов рода Candida, относящихся к аэробным условно-патогенным микроорганизмам.

Экзогенные факторы, способсвующие кандидозу:

- Повышенная потливость, мацерация кожи и слизистых,Травмы кожи и слизистых оболочек, Перегревание, условия работы

Эндогенные :

- Иммунодифецит,Сахарный диабет,Заболевания крови,дисбактериоз

Различают кандидоз:

- кандидоз кожи, кандидоз видимых слизистых оболочек, висцеральный кандидоз

Клиника:

Различают поверхностный, висцеральный (системный) и хронический генерализованный кандидоз. Как промежуточную форму между поверхностным и висцеральным кандидозами отдельно выделяют кандидомикиды или аллергиды.

Кандидоз полости рта (стоматит кандидозный, молочница) часто встречается у детей грудного возраста. Заболевание возникает в первые недели жизни, как правило, у ослабленных детей. Заражение новорожденных часто происходит от больной матери.

На фоне гиперемии и отёчности слизистой оболочки полости рта появляются величиной от точки до булавочной головки изолированно расположенные налеты беловатого цвета, состоящие из вегетаций грибов, постепенно увеличивающиеся в размерах и образующие пленки блеснящего белого, сероватого или желтоватого цвета, легко удалимые без повреждения подлежащей слизистой оболочки.

Кандидоз слизистой оболочки половых органов (Баланит. Вульвовагинит).-довольно распространненое заболевание, относящиеся к заболеваниям передающихся половым путем

Кандидоз углов рта (заеда каидидозная) возникает главным образом у детей в результате распространения заболевания со слизистой оболочки рта, однако может быть изолированным. Поражаются, как правило, оба угла рта; По периферии очага проходит бахрома отслаивающегося рогового слоя.

Хейлит кандидозный нередко сочетается с заедами; характеризуется отёчностью и синюшностью красной каймы губ и скудным её шелушением тонкими пластинчатыми чешуйками сероватого цвета.

Клиническая картина **кандидоза складок** весьма своеобразна и типична: обширные эрозивные участки имеют малиновый цвет с фиолетовым, синюшным или ливидным оттенком; их влажная поверхность имеет характерный лаковый блеск. Чаще всего поражаются межпальцевые складки кистей, крупные складки.

Паронихия и онихия кандидозная, кандидоз ногтевых валиков и ногтей возникает в результате местной травматизации, влажности и мацерации. Край ногтевого валика становится отёчным, гиперемированным, на ощупь пастозным и болезненным.

Диагноз кандидоза ставят на основании:

клинических данных,

микроскопии патологического материала,

посевов

серологических исследований.

Лечение кандидоза:

устранение факторов, способствующих развитию кандидоза;

диета с ограничением углеводов.

При лёгких вариантах ограничиваются местным лечением:

Общая противокандидозная терапия- нистатин, флуконазол,десенсибилизирующая терапия, витаминотерапия

«Пимафуцин» крем, суспензия и вагинальные таблетки,«Микозолон»,

24. Чесотка. Этиология, клиника, диагностика, осложнения, лечение, профилактика, диспансеризация.

Чесотка – это заразное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом.

Чесоточный клещ: постоянный паразит, только самка и личинки участвуют в заражении, питаютсячешуйками эпидермиса, характерен строгий суточный ритм активности, плодовитость колеблется посезонно.

Источник заражения

Пути заражения. В 95 % случаев заражение чесоткой происходит при непосредственном контакте с больным, однако можно заразиться через постельное белье, одежду больного, в банях, через игрушки.

Основные клинические симптомы типичной чесотки:

- Зуд, усиливающийся в вечернее и ночное время суток
- Наличие чесоточных ходов
- Характерная локализация высыпаний
- Полиморфизм высыпаний

Механизм зуда при чесотке:

- Раздражение нервных окончаний при движении клеща.
- Развития сенсибилизации организма больного к продуктам жизнедеятельности клеща
- Из-за выделения клещом слюны и веществ, находящихся в экскрементах.

Локализация: межпальцевые складки кистей, боковые поверхности пальцев рук, переднебоковые поверхности туловища, область молочных желез, область живота, область ягодиц, бедер ,голеней.

Клиника:Скрытый период от момента попадания клеща на кожу ребенка и до клинических симптомов болезни может быть от 7-10 дней до 4-6 недель. Его продолжительность зависит от массивности первичного заражения. Ведущим клиническим симптомом чесотки является зуд кожных покровов, особенно по ночам, когда больной согревается. Самка чесоточного клеща проделывает ходы в коже в виде продольных или извилистых серовато-белых линий с двумя черными точками в месте входа и выхода чесоточного клеща. При расчесах занесении вторичной инфекции появляются гнойничковые высыпания.

Характеристика высыпаний при чесотке:

- Первичные морфологические элементы: парные узелки и пузырьки, возникающие на месте внедрения клещей.
- Вторичные морфологические элементы: линейные расчесы, кровянистые корочки, эрозии, возникающие вследствие расчесов.

Симптомы характерные для чесотки:

- Арди- пустулы и гнойные корочки в области локтевых суставов
- Горчакова- кровянистые корочки в области локтевых суставов
- Михаэлиса- кровянистые корочки и импетигинозные высыпания в межягодичной складке с переходом на крестец
- Сезари обнаружение чесоточных ходов в виде возвышения при их пальпации.

Клинические разновидности чесотки: типичная, детская, чесотка без ходов, норвежская, осложненная, псевдочесотка.

Диагностика:

Жалобы, эпидаанамнез, клиническая картина, лабораторная диагностика. При подтверждение диагноза обязательно заполнить экстренное извещение и отправить в СЭС

Лечение: Широкое распространение в лечении чесотки получил *бензилбензоат* в виде 20% водно-мыльного раствора или мази, для детей до 3-х лет - 10%. Перед смазыванием больной принимает душ, затем втирает бензилбензоат двукратно с 10 минутным перерывом, одевает чистое белье. Лечение проводят в течение 3- х дней, после чего больной принимает душ и меняет нательное и постельное белье.

Профилактика Необходимо выделять личную и общественную профилактику инвазии. Личная предусматривает соблюдение гигиенических правил при общении с животными и больными людьми, а также соблюдение личной гигиены при посещении общественных мест. Общественная профилактика заключается в своевременном выявлении и эффективном лечении больных, противоэпидемических мероприятиях в банях, общежитиях, детских садах, а также санитарно-просветительная работа. Белье больных нужно кипятить, а одежду и постельные принадлежности обрабатываются в дезинфекционных камерах.

25. Атипичные формы чесотки. Клиника, диагностика, лечение.

Чесотка –это заразное паразитарное заболевание, вызываемое чесоточным клещом

Выделяют следующие формы атипичные формы чесотки:

- **Стертая(** малосимптомная)- возникает у чистоплотных людей. Чесоточные ходы отсутствуют. Отмечается сильный зуд, единичные узелковые элементыи экскориации.
- **Нодозная** – диссеминированные длительно существующие зудящие узелки, развивающиеся как следствие аллергической реакции на продукты жизнедеятельности клеща
- **Норвежская чесотка**— у ослабленных лиц, при заболеваниях цнс, протекает хронически с увеличением очегов, покрытых массивными грязно- бурыми слоистыми корками. Зуд отсутствует
- **Зерновая** – вызывается клещом, который в соломе и на зернах. Заражение происходит при попадании клеща на кожу человека из соломенных матрасов с пылью. На месте укусов клещей появляются волдыри, гиперемия, пузырьки, беспокоит сильный зуд.
- **Псевдочесотка**— при заражении чесоточными клещами животных чаще источником являются собаки. Клещи не проникают в эпидермис , а кусают вызывая сильный зуд, волдыри, папулы. От человека к человеку не передается.
- **Грудничковая**— чесотка напоминает клинику крапивницы с расчесами и волдырями. Локализуется чаще на мошонке, в области промежности, в подмышечных впадинах, на лице.

Диагностика:

- анамнез(эпиданамнез)
- клиническая картина
- осмотр контактов
- лабораторное исследование на чесоточный клещ

Диф диагностика:

- Вшивость
- Кожный зуд
- Почесуха
- Нейродермит

Лечение:

33% серная мазь , полисульфидный линимент,спрегаль,

Диспансерное наблюдение- после выписки из стационара повторный осмотр больного проводится через 2 недели. Если проявлений болезни нет и все контакты осмотрены и пролечены- снимаются с диспансерного учета.

Профилактика:

- Ранняя диагностика, изоляция и лечение больных.
- Дезинфекция нательного и постельного белья больного
- Профлечение лиц, бывших в тесном бытовом и половом контакте
- Профилактические осмотры по выявлению чесотки особенно в молодежные коллективах
- Санитарно-просветительная работа среди населения.

26. Педикулез. Эпидемиология. Клиника. Лечение.

Педикулез – это широко распространенное паразитарное заболевание, поражающее кожу и волосы человека.

Возбудителями педикулеза являются вши – небольшие облигатные эктопаразиты, принадлежащие к отряду пухоедовых.

На человеческом теле могут паразитировать только три вида вшей:

платяные,

головные

лобковые.

Пути заражения :

1. Тесный контакт с больным
2. Через белье и одежду, расчески
3. В душевых , банях
4. При половом акте

Характерные признаки:

- Зуд, рассчесы
- На месте укусов – волдыри, пятна синеватого цвета
- Присоединение вторичной инфекции
- Увеличение лимфатических узлов.

В зависимости от типа возбудителя различают платяной, головной, лобковый и смешанный педикулез.

Головные вши передаются от больного человека здоровому контактно-бытовым путем (при ношении общих головных уборов, при использовании чужих расчесок, подушек, постельного белья).

Платяные вши намного крупнее головных. Эти насекомые селятся и откладывают гниды в швах и складках одежды. В свою очередь **лобковые вши** внешне напоминают миниатюрных крабов, прикрепляющихся к коже своеобразными клешнями. Этих насекомых также достаточно легко обнаружить при простом визуальном осмотре пациента. Передается лобковый педикулез при половых контактах и при использовании общих комплектов постельного белья.

Общими для всех разновидностей педикулеза **симптомами** являются:

сильнейший зуд, вызванный попаданием в ранку от укуса вши ферментов слюны насекомого;

появление на теле больного следов от расчесов пораженных болезнью участков и геморрагических пятен;

сухость и шелушение кожи, образование на ней участков гиперпигментации;

наличие гнид на волосах, в складках и швах одежды пациента.

Диагностика:

- Анамнез
- Клиническая картина
- Осмтор контактов
- Обнаружение вшей и гнид

Диф диагностика: чесотка, кожный зуд, почесуха, крапивница.

Лечение

Современные методы терапии педикулеза основываются на применении препаратов, содержащих в качестве основного действующего вещества фенотрин, пиретрин, малатион или перметрин.

20% - 25% мазь бензилбензоата или ниттифор, шампуни педилин, рид, сифакс.

дновременно с лечением производится дезинфицирование личных вещей больного.

Профилактика

Профилактика развития педикулеза сводится, в основном, к соблюдению мер личной гигиены. К числу наиболее эффективных мер, направленных на предупреждение этого недуга, относятся:

регулярная смена постельного и нижнего белья;

поддержание тела в чистоте;

стирка белья при высокой температуре, регулярное проглаживание его горячим утюгом;

27. Вирусные дерматозы: простой герпес, опоясывающий лишай и генитальный герпес. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Простой пузырьковый лишай. Возбудитель – вирус простого герпеса.Пути передачи- при поцелуях, половых актах. Первичный элемент- пузырек.. Локализация- красная кайма губ , вокруг рта, слизистая полость рта, носа, глаз, половых органов

Клинические разновидности:

- **Абортивная**
- **Отечная**
- **Зостериформная**
- **Часто рецидивирующая**

Первичный герпес возникает после первого контакта с вирусом в детском возрасте при отсутствии специфических антител. Наиболее тяжело протекает у новорожденных. Одним из наиболее часто встречающихся проявлений первичной инфекции является острый герпетический стоматит.

После инкубационного периода развиваются клинические симптомы:

Общие проявления: озноб с повышением температуры до 38-39 "С, головная боль, сонливость, общее недомогание.**Местные проявления** возникают в полости рта. На слизистой языка, щек, десен, внутренней поверхности губ, реже на мягком и твёрдом нёбе появляются болезненные сгруппированные пузырьки. Пузырьки сразу вскрываются, образуя эрозии. Регионарный лимфаденит подчелюстных лимфатических узлов

Простой пузырьковый лишай встречается чаще как **рецидивирующая форма** заболевания. При этом по сравнению с первичной формой интенсивность и продолжительность клинических проявлений выражена меньше.

Диф диагноз твердый шанкр

Лечение герпеса проводят с помощью трех групп препаратов:

- антивирусная терапия- ацикловир, виролекс
- интерферон, циклоферон, пирогенал
- специфическая вакцинация- инактивированная герпетическая поливакцина.

Опоясывающий лишай- это **вирусная инфекция,** проявляющаяся болью и кожными высыпаниями. Возникает чаще осенью и зимой, преимущественно у пожилых людей. Болезнь вызывается тем же самым вирусом герпеса (herpes zoster), который является возбудителем ветряной оспы (ветрянки).

Локализация – любая , по ходу нервных стволов.

Клиника:

За несколько дней до начала болезни может возникнуть состояние, напоминающее грипп: головная боль, повышение температуры, познабливание, вялость. Одновременно могут возникать боли, жжение и зуд, а также онемение и покалывание в зоне будущих высыпаний.

Сыпь имеет вид розоватых пятен, которые в тот же или на следующий день преобразуются в мелкие пузырьки с прозрачным содержимым. Наиболее часто они возникают в области грудной клетки (в межреберьях), на лице, реже по ходу нервов конечностей.

В дальнейшем жидкость, содержащаяся в них, мутнеет, пузырьки усыхают, втягиваются внутрь и покрываются корочкой. Подсохнув, они образуют выступающие над кожей бляшки. На месте поражения остается более светлый по цвету участок кожи или рубец.

Клинические разновидности – генерализованный, геморрагический, гангренозный, абортивный, буллезный.

Диф диагностика : простой пузырьковый лишай, рожистое воспаление, спид

Лечение:

При лечении опоясывающего герпеса обычно применяют анальгетики, седативные средства и снотворные. Также обязательно назначаются противовирусные препараты: ацикловир, валацикловир или фамцикловир

Генитальный герпис

Клинические формы- острый, хронический, рецидивирующий

Локализация- кожа больших ималых половых губ, промежность, слизистая влагалища, шейка матки, слизистая уретры.Клиническим проявлением могут прдшествовать плохое самочувствие, повышение температуры, лимфоаденопатия, затем наотченой и гиперемировной коже или на слизистой появляются пузырьки с серозной жидкостью, вскрывает с образованием эрозий, с последующейэпителизации.

Течение:

- Легкое(1-3 рецидива)
- Средней тяжести(4-6 рецидивов)
- Тяжелое(больше 6 рецидивов)

Диф диагностика: первичный период сифилиса, спид, рак, кондидоз

Лечение В острую стадию целесообразно назначать противовирусные препараты: ременадин, лейкоцитарный интерферон.

28. Контагиозный моллюск, остроконечные кондиломы, бородавки. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Контагиозный моллюск вызывается вирусом- Molitor hominis. Заражение происходит при контакте кожи с инфицированными предметами (полотенцем, мягкими игрушками и т.д.).

Локализация контагиозного моллюска: наружные половые органы, бедра, ягодицы , кожа лица, шея.

Первичный элемент-узелок

Клиника:

На неизмененной коже появляются приподнятые узелки. Они имеют полушаровидную форму. По цвету совпадают с нормальной окраской кожи или слегка розовее ее, единичные или множественные. В середине полусферы имеется вдавление, чем - то напоминающее человеческий пупок. При надавливании на узелок из него, как из угря, выделяется творожистая пробка.

Клинические формы- в виде множества высыпаний, моллюсковые узелки сидящие на ножке,
Гигантские моллюски**.**

Диф диагностика: спид,бородавки, сифилитические папулы

Выделяют четыре основных метода лечения контагиозного моллюска. Конкретный метод может выбрать лишь врач в конкретном случае:

1. Механическое выдавливание узелков (выскабливания острой ложкой) с последующей обработкой пораженной поверхности 5% спиртовым раствором йода;
2.Диатермокоагуляция или прижигание;
3. Обработка противовирусными мазями и иммуномодуляторами.
4. При наличии очень большого количества узелков следует назначать антибиотики тетрациклинового ряда (тетрациклин, олететрин, метациклин, доксициклин, хлортетрациклин).

Остроконечные кондиломы – это бородавчатые образования на коже и слизистых оболочках характерного вида «цветной капусты». Они имеют остроконечные верхушки и похожи на петушиные гребни.

Клиника: ***Заражение*** происходит контактным путем (половой путь - это такой же контактный путь заражения).Источник заражения - видеизмененные клетки кожи или слизистой оболочки, в которых развивается вирус.

Начало:

небольшие пузырьки и бугорки на коже и слизистой ,небольшое покраснение вокруг, незначительный зуд.

Развитие болезни: образования растут в размерах до 1-1,5 см, внешний вид "цветной капусты" или "петушиного гребня", зуд усиливается, рядом появляются новые пузырьки.

Расположение:

гениталии: пах, лобок, половые органы у мужчины и у женщины (головка полового члена, крайняя плоть, вульва, влагалище, малые половые губы),
анус (задний проход). Такое расположение дало второе название: аногенитальные бородавки.

Основное лечение - удаление.

Бородавками называются возвышения на кожном покрове округлой формы, сформированные по причине усиленного разращения верхних слоев эпителиальной ткани и лежащего снизу сосочкового слоя кожного покрова. Бородавки представляются доброкачественными новообразованиями на кожке, развивающиеся из-за проникновения вируса папилломы человека.

Существует несколько основных разновидностей бородавок:

Простые бородавки (обычные) – это плотные эпидермальные папулы с неровной поверхностью, покрытых ровными чешуйками , размера от одного до десяти мм, которые чаще всего формируются на тыле кистей, стоп, ногтевых валиках.

Подошвенные бородавки – это вид простых бородавок, которые формируются в зонах сильного сдавливания стопы обувью, в особенности на ногах с обильным потоотделением., на подошвенных поверхностях, в центре видны сосочковые разрастания.

Плоские бородавки(юношеские) – это ярко выраженные гладкие папулы с четкими границами размером от 1 до 5 мм, которые приблизительно на 1 – 2 мм возвышаются над кожным покровом, натыле кистей и пальцев, подбородке и лбу. Папулы цвета нормальной кожи.

Остроконечные бородавки – это маленькие узелки розового оттенка, которые при слиянии преобразуются в сосочкообразное разрастание в форме ножки.

Старческие бородавки – это самая доброкачественная опухоль кожного покрова из всех известных в медицине, обычно она формируется в пожилом возрасте из ткани эпидермиса.

Профилактика: соблюдение правил личной гигиены.

Лечение. Дерматокоагуляция, криотерапия жидким азотом, прижигание укскcной кислотой, 5% мазь ацикловира,, солкодерм.

29. Многоформная экссудативная эритема, этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика. Синдром Стивенса-Джонсона. Диагностика, лечение.

Многоформная экссудативная эритема— острый полиморфный дерматоз преимущественно инфекционно-аллергической природы. Инфекционно-аллергической эритемой страдает много населения.

Этиология и патогенез

1. Основной правоцирующий фактор- герпетическая, микоплазменная, стафилококковая, стрептококковая инфекция.
2. Наличие очагов инфекции в челюстно-лицевой области . У этих пациентов повышена чувствительность к различным бактериальным аллергенам, снижение фактором гуморального и клеточного иммунитета.
3. При токсико-аллергической форме эритемы выявляется гиперчувствительность к различным медикаментам

Рецидивы правоцируют переохлаждение, перегревание,

У некоторых лиц удается выявить возниктовение эритемы постле употребления некоторых продуктов питания.

Характер высыпаний: вначале появляются участки ограниченной эритемы , на фоне которой через несколько дней образуются утолщенные миллиарные папулы синюшно-красного цвета с западанием в центре(напоминают мишень или радужку). На их поверхности формируются пузырьки и пузыри, эрозии, кровянистые корки. При поражении слизистых возникают эрозии с фибринозным налетом. В процесс могут вовлекаться трахея, бронхи, глаза. Мозговые оболочки, почки.

Клинические формы:

- Простая или легкая форма(папулезная, обычно протекает без поражения слизистых)
- Везикуло-булезная(среднетяжелая)
- Буллезная(тяжелая форма), включая синдром стивена-джонсона
- Крайнетяжелая форма заболевания(синдром лайелла)

Локализация : разгибательные поверхности конечностей, часто кисти и стопы, область локтевых и коленных суставов, лицо, наружные половые органы, слизистаяя оболочка рта, полость носа.

Сыпь может носить ограниченый, диссеминированный и генерализованный характер.

Буллезная форма –Синдром Стивена-джонсона

Является тяжелой разновидностью многоформной экссудативной эритемы или токсико-аллергической реакцией на прием лекарственных средств. На слизистой рта возникают обширные пузыри кровоточащие эрозии, массивные геморрагические корки. Симптомы хейлита и стоматита затрудняют прием пищи из-за резкой болезненоость. Возможно развитие катарального или гнойного конъюнктивита , изъязвлений роговицы, поражение слизистых гениталий с вовлечением мочевого пузыря и нарушением мочеиспускания. На коже обнаруживаются множественные пятнисто-папулезные высыпания, пузыри с положительным симптомом никольского, реже пустулы. Характерна длительная лихорадка, возможно развитие пневмонии, нефрита, диареи, полиартрита, отита. Данные проявления необходимо дифференцировать с симптомами лайелла.

Диф диагностика : вульгарная пузырчатка, дерматоз дюринга

Лечение:

Начальная доза преднизолона 60-80 мг. Гемодез(полиглюкин) в\в капельно.тиосульфат натрия в\в, антигистаминные препараты.

30. Розовый лишай. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика.

Розовый лишай- заболевание с невыясненной этиологией и патогенезом. Возникает чаще в холодное время года или после переохлаждения. Болеют чаще взрослые. Предполагается **инфекционная природа** заболевания, но сам розовый лишай не заразен.

Длительность – 4-8 недель. Через некоторое время может наступить самоизлечение!
Иммунитет 7-10 лет после перенесённого заболевания.

КЛИНИКА:

- Субфебрилитет перед высыпаниями, недомогание, боли в суставах,иногда увеличение лимфоузлов
- Высыпания симметричные, поражается кожа туловища, конечностей, за исключение ладоней и подошв.
- округлое/овальное пятно розово-желтого цвета («материнская» бляшка)
- через несколько дней в центре пятна кожа приобретает бурый оттенок
- центр запавший с шелушением по типу «смятой папиросной бумаги»
- высыпания появляются приступообразно по боковым сторонам туловища по линиям Лангера
- новые высыпания чаще появляются после водных процедур, может развиться эритродермия
- зуд различной интенсивности
- разновидности розового лишая: уртикарная папулезная, везикулезная, фолликулярная

Диф диагностика: сифилитическая розеола, отрубевидный лишай, токсикодермия.

ЛЕЧЕНИЕ:
1) запретить мытье в течение первых 4-6 недель
2) гипосенсибилизирующие, антигистаминные средства
3) витамины В и С
4) антибиотики широкого спектра действия
5) местно – взбалтываемые взвеси, пасты, мази
6) запретить ношение синтетической и шерстяной одежды
7) исключить из питания острые, соленые и копченые продукты

31. Псориаз (чешуйчатый лишай). Этиопатогенез, клинические формы и их проявления, течение, диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения, профилактика рецидивов.

ПСОРИАЗ (ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛИШАЙ) – аутоиммунный , генетически детерминированный эритематозно-сквамозный дерматоз. « розы дьявола» так в средневековье называли псориаз, а также « императорской болезнью» **ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ** окончательно не выяснены. Теории происхождения псориаза: генетическая, паразитарная, вирусная, инфекционно-аллергическая, нейрогенная, эндокринных нарушений, обменная. Ведущую роль играет **наследственный фактор**, генетически обусловленная предрасположенность.

Типы псориаза: 1-ый тип- приемущественно у молодых людей(до 25 лет), прослеживается наследственный характер заболеваания, склонность к тяжелому течению**.,** 2-ой тип- начало в возрасте страше 50 лет, течение более легкое.

Сезонность псориаза: Летняя форма(обострение летом), Зимняя форма(обострение зимой), Внесезонная(нет связи с сезоном)

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ: вульгарный, экссудативный, артропатический, псориатическая эритродермия (тотальная и частичная), пустулезный псориаз., псориаз волосистой части головы, себорейный псориаз, инверсный псориаз(локализация на складках), псориаз ногтей, ладоней и подошв, токсико-аллергическая форма псориаза.

ВУЛЬГАРНЫЙ ПСОРИАЗ:

- Первичным морфологическим элементом сыпи являетсяя шелушащаяся эпидермальная папула розового цвета, округлыйх очертаний, размером от просяного зерна- увеличиваясь папулы достигают больших размеров и могут образовывать сплошные очаги папулезной инфильтрации. Слившиеся паппулы называют бляшками. Вторичные морфолочические элементы псориаза- чешуйки, чешуйко-корки, депигментированные или гиперпигментированные пятна.
- Располодение элементов может быть в любых местах, чаще в местах подвергшихся механическим раздражениям. На разгибательный поверхностях верхних и нижних конечностей, волосистой части головы, туловище, ладонях и подошвах.
- Разновидности псориатических папул: точечные, каплевидные, монетовидные, кольцевидные, папулы напоминающие дуги и гирлянды, географические папулы, линейный.
- Псориатическая триада:
  1. феномен стеаринового пятна(дробление чешуек, сходство с каплей стеарина)
  2. феномен терминальной пленки(красная блестящая пленка на месте снятых чешуек)
  3. феномен "кровяной росы"(при поскабливании сосчков дермы точечное кровотечение)
- деформация ногтевых пластинок с точечными вдавлениями (симптом Геллера), цвет ногтей становится желтовато-коричневым, пластинки истончаются/утолщаются
  4. **Прогрессирующая стадия** – мелкие папулы ярко - розового цвета, шелушение в центре.
  5. **Стационарная стадия** - отрицательный феномен Кебнера, бледный цветом элементов, шелушение занимает всю поверхность папулы, вокруг папул воротничок Воронова.
  6. **Стадия регресса** - разрешение элементов с центра/периферии, пятна гипо- или гиперпигментации

АРТРОПАТИЧЕСКИЙ ПСОРИАЗ:

- Хроническое прогресирующее течение, начинается как вульгарный, боли и припухание мелких суставов , тяжелые деформирующие артриты, анкилозы, ведущие к инвалидности

ПСОРИАТИЧЕСКАЯ ЭРИТРОДЕРМИЯ (возникает спонтанно/после инфекции):

- бляшки сливаются в одну общую эритему, может возникнуть прсле прогресирующего течения обычного псориаза, кожа кирпично-красного цвета, отечная, может присоединиться вторичная инфекция

ЭКССУДАТИВНЫЙ ПСОРИАЗ:

- Эпидермально-дермальные папулы, Поражение различных участков кожи, крупные пластинчатые чешуйки/корки

ПУСТУЛЕЗНЫЙ ПСОРИАЗ:

- высыпания на неизмененной коже стерильных пустулезных элементов **Диф диагностика**: папулезный сифилид, себорея, красный плоский лишай. **Диагностика псориаза:** диагноз ставится на основании наличия мономорфной папулезной сыпи с явлениями шелушения, типичной локализацией , наличием феномена кебнера (появление типичных псориатических высыпаний на месте повреждения кожи в среднем через 10-14 дней), положительной триады феноменов. Патогистология(биорсия), индекс тяжести пораженти.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1) седативные, антигистаминные, гипосенсибилизирующие средства,нпвс
2) препараты неспецифической иммунотерапии (алоэ, пирогенал)
3) витамины А, В, С
4) гемодез в/в капельно
5) лидаза
6) иммуномодуляторы (тактивин, спленин)
7) кортикостероиды
8) местно – кератопластические мази и кремы (2%-5% салициловая мазь), глюкокортикоидные мази
9) физиотерапия – УФО, гидротерапия
10) санаторно-курортное лечение

32. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, лечение.

Красный плоский лишай- хронический дерматоз, характерезующийся появлением на коже, реже на слистой оболочке полости рта и гениталий папул лилового цвета с восковидным блеском.

ЭТИОЛОГИЯ – неизвестна. Существуют вирусная, нейрогенная, инфекционно-аллергическая, эндокринно-обменная, наследственная теории развития болезни.

Правоцирующие факторы: стрессовые ситуации, нейроэндокринные растройства, заболевания ЖКТ, печени поджелудочной железы, гипертония, сахарный диабет, очаги фокальной инфекции,медикаменты(стрептомицин).

Локализация – сгибательная поверхность предплечий, туловище, передняя поверхность голеней, слизистая полости рта, половые органы.

КЛИНИКА:

- первичный морфологический элемент- плоская, с синюшним оттенком, полигональной формы папула, в центре ее имеется пупкообразное вдавление, с восковидным блеском.
- Высыпания склонны к группировкам, сопросвождаютя интенсивным зудом.
- сетка Уикхема
- положительный феномен Кебнера(появление типичных псориатических высыпаний на месте повреждения кожи через 10-14 дней)
- патогистологические изменения- акантоз, гиперкератоз, гипергранулез, папилломатоз, лимфоцитарный инфильтрат.

Основные клинические формы

- на коже: типичная, бородавчатая, эритематозная, эрозивно-язвенная, атрофическая, пузырная, остроконечная, линейная.
- На слизистой оболочке ротоглотки и гениталий: тпичная, экссудативно- гиперемическая, эрозивно-язвенная
- Поражение ногтей: онихогрифоз, онихолизис, деструкция ногтевого валика.
- По распространенности высыпаний: локазизованная(ограниченая) или распространенная.

Типичная форма- на коже папулы милиарного или лентикулярного характера розовато-фиолетового цвета, плоскиес полигональными очертаниями и восковидным блеском, на поверхности отдельных папул виден сетчатый рисунок напоминающий листья папоротника- сетка Уикхема.

Гипертрофическая (бородавчатая форма) – фиолетово-красные бляшки с неравномерными роговыми наслоениями, резкими границами, различной формы , в виде бляшечных элементов.

Атрофическая форма – рубчики на месте бывших папул.

Буллезная (пемфигоидная) форма – пузыри на бляшках и папулах , на воспаленных участках кожи, сопровождается сильным зудом.

Пигментный красный плоский лишай – множественные буроватые пятнистые высыпания.

Зостериформный красный плоский лишай – типичные папулы по ходу нерва.

Диф диагностика: псориаз, почесуха, нейродермит

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1) гипосенсибилизирующие средства
2) антигистаминные (Н1–блокаторы)
2) витамины А, Е
3) производные хинолина (делагил)
4) кортикостероиды
5) седативные средства
6) иммунотерапия
7) местно - глюкокортикоидные мази, орошение хлорэтилом, обкалывание суспензией гидрокортизона, диатермокоагуляция
8) санаторно – курортное лечение

33. Токсикодермии. Этиология. Клиническая картина, лечение.

Токсикодермия (токсидермия) — острое токсико-аллергическое воспалительное поражение кожных покровов, возникающее как реакция на прием внутрь, вдыхание или парентеральное введение веществ, являющихся аллергенами и одновременно обладающих токсическими действием

Причины развития лекарственный токсикодермий:

- Антибиотики(пенициллины), сульфаниламиды, снотворные средства, транквилизаторы, антималярийные препараты, витамины, гормоны(особенно инсулин), антигистаминные средсства

Причины возникновения пищевых токсикодермий:

- Сам пищевой продукт, вещества образующиеся при длительном хранении продуктов, при кулинарной обработке, консерванты, красители

Пути воздействия на кожу лек препаратов:

- Прямое повреждающее действие (барбитураты), куммулятивное действие(накопление брома, йода), неперносимость лек средств, идиосинкразия(дефект ферментных систем), аллергические и аутоиммунные реакции, лекарственная сенсибилизация.

Клиническая картина проявления разнообразны, причем одно и тоже вещество может вызывать у одного и того же человека различные проявления в разное время, а однаи та же клиническая картина может быть следствием действия различных хим в-в.

Возникает обычно остро, или через несколько часов, или через 2-3 дня после воздействия этиологического фактора. Сыпь может быть пятнистой, папулезной, узловатой, везикулярной, буллезной, пустулезной. Характер располодения высыпанных элементов диссеменированный, симметричный, расположения их может быть как на коже, так и на слизистых. Часто нарушается общее состояние.

Диагностика: анамнез, кожные диагностические пробы,провокационные пробы с пероральным приемом подозреваемого препарата, пробы in vitro

Лечение:

Первостепенное значение в лечении токсикодермии имеет предупреждение дальнейшего воздействия вызвавшего ее вещества. С этой целью при алиментарных и аутотоксических вариантах токсикодермии применяют слабительные и мочегонные средства, очистительные клизмы, внутривенное введение десенсибилизирующих растворов тиосульфата натрия и хлорида кальция, антигистаминные препараты (кларитин и др.). при тяжелых случаях глюкокортикостероиды гемодез гемосорбция, наружная терапия проводится с учетом стадии процесса.

34. Синдром Лайелла, клиника, лечение, профилактика.

Синдром Лайелла (острый или токсический эпидермальный некролиз) — тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы, характеризующееся острым нарушением общего состояния пациента, буллезным поражением всего кожного покрова и слизистых.

Клиника. Заболевание начинается внезапно с повышения температуры тела до 38° - 41°С, Токсико-аллергическая реакция начинается с поражения лица и конечностей в виде эритемы, пятнисто-папулезной сыпи . В течении нескольких часов-дней отдельные элементы постепенно сливаются , появляются везикулы и занимают весь кожный покров. Далее происходит образование тонкостенных пузырей, которые быстро сливаются и выглядят как беловатые участки, напоминающие папиросную бумагу. Определяется положительный симптом Никольского. Происходит отслоение эпидермиса, который легко отторгается с образованием обширных кровоточащих и резко болезненных эрозий щек, губ, конъюнктивы, половых органов и преанальной области. В стадию выздоровления наблюдается обильное шелушение и слущивание не отторгшегося некротизированного эпителия. Нередко развивается почечная недостаточность, язвенно-некротические изменения ЖКТ, трахеи и бронхов.

Диагностика: ОАК- повышение СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг формулы влево.

Биопсия кожи и гистологическое изучение- полная гибель клеток поверзностного слоя эпидермиса

Диф диагностика: пузырчатка, синдром стивена-джонсона, дерматит, простой герпес.

Лечение:

Лечение пациентов с синдромом Лайелла проводится в реанимационном отделении и включает целый комплекс неотложных мероприятий.

Терапия синдрома Лайелла осуществляется инъекционным введением больших доз кортикостероидов (преднизолон). Применение методов экстракорпоральной гемокоррекции (плазмаферез, гемосорбция) позволяет производить очищение крови от образующихся при синдроме Лайелла токсических веществ. Постоянная инфузионная терапия.

В комплексной терапии синдрома Лайелла применяют медикаменты, поддерживающие работоспособность почек и печени; ингибиторы ферментов, участвующих в разрушении тканей;

35. Дерматиты (простой контактный и аллергический). Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика.

Дерматит-это воспаление кожи, обусловленное раздражающим или сенсибилизирующим действие экзогенных факторов.

Простой контактный дерматит — воспалительная реакция кожи, возникающая в ответ на прямое воздействие раздражающих веществ (щелочей, кислот, моющих средств, растворителей, хлорной извести и т. п.).

Клиника:

- Очаг поражения возникает исключительно в месте воздействия раздражающего фактора
- Отсутствует сенсибилизация
- Отсутствует тенденция к диссеминации и распространению процесса по периферии очага
- Чаще возникает остро, вскоре после воздействия
- После прекращения действия раздражителя дерматит быстро регресирует
- Новое воздействие может вызвать повторное возникновение дерматиа.

Факторы вызывающие простой дерматит: механические(тесная одежда) , физические(отморожения) , химические(кислоты и щелочи), биологические(борщевик)

Клинические проявления: при остром течении появляется гиперемия и отечность, а внекоторых случаях пузыри с серозным или геморрагическим содержимым, после вскрытия которых при травмировании образуются эрозивные участки. При хроническом – пораженные участки кожи уплотняются, появляется лихенизация и инфильтрация, утолщение эпидермиса и гиперкератоз.

Лечение:

Основной принцип лечения — это определение и устранение причины появления простого контактного дерматита.

Для уменьшения симптомов воспаления возможно применение противовоспалительных присыпок или кремов. , при резкои гиперемии , при отеке примочки или водные болтушки, а затем кортикостероидные маази.

Аллергический дерматит – это кожное воспаление, проявляющееся реакцией на определенное вещество.

риггеры аллергического дерматита – пыль, пыльца, перо, шерсть животных, различные запахи (духи, парфюмерные композиции), лекарственные инъекции, пища. Поэтому нередко аллергический дерматит носит сезонный характер, например, в период цветения.

Локализуется дерматит на открытыхучастках кожи(дицо, шея, кисти), Наличие определенного экзогенного аллергена, наличие диссеминированных высыпаний – аллергидом, положительные пробы с выявленные аллергеном.

Клиника:

- Характерен истинный полиморфизм
- Отмечаются признаки , характерные для экземы, но враженные слабее(везикуляция, мокнутие, склонность к рецидивам)
- Эритема, отечность, папулезные и везикулярные элементы локализуются на участках подвергшихся воздействию аллергена(тыльная поверхность кистей рук, лицо, шея) Многие папулы и везикулы быстро подсыхают в серозные тонкие корочки
- Аллергиды представлены островоспалительными высыпаниями без четких контуров.
- Субъективные ощущения зуд жжение чувство жара

Диагностика: аллергический дерматит сходен по клиническим картине с экземой, особенно в случаях рецидивирующего течения. Локализация дерматита на открытых участках кожного покрова, наличие определенного экзогенного раздражителя, разрешение дерматита при устранении действии аллергена, положительные кожные пробы с выявленным аллергеном.

Лечение:

Основной метод лечения аллергического дерматита – прием **антигистаминных и десенсибилизирующих препаратов**, которые в первую очередь направлены на устранение симптомов основного заболевания. **Препараты первого поколения** способны снять отек и воспаление очень быстро.

36. Аллергические васкулиты кожи (болезнь Шенлейн-Геноха, острая и хроническая узловатая эритема). Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Аллергические васкулиты- группа дерматозов, при которых воспалительное поражение сосудов возникает первично и нуждается в патогенетической терапии

На патогенез влияют: общие и фокальные инфекции, травмы, гиповитаминоз, вирусы, вакцины и сыворотки, наследственность, аутоиммунные и аутоаллергические процессы.

Классификация аллергических васкулитов:

1. Поверхностные васкулиты:
    - Гемосидерозы
    - Геморрагический васкулит(болезнь Шенлейн-геноха)
    - Аллергический артериолит
    - Узелковый некротический васкулит
    - Лихеноидный парапсориаз
2. Глубокие васкулиты:
    - Кожная форма узелкового или узловатого перартериита
    - Острая узловатая эритема
    - Хроническая узловатая эритема

Общая симптоматика для аллергических васкулитов:

- Острое начало, ухудшение общего состояния- слабость , головныя боль, артралгии, боль в месты высыпания, субфебрильная температура, полиморфизм высыпаний- эритематозные пятна, папулы, везикулы, волдыри, пузыри, язвы, корки, рубцы, геморрагические пятна, геморрагический выпот в полостях, гемосидероз, изменения со стороны ОАК

<u>Геморрагический васкулит (Болезнь Шенлейн- Геноха)</u>

В основе болезни лежит асептическое воспаление, дезорганизация стенок сосудов кожи и внутренних органов с микротромбообразованием.

Клинические формы: кожно-суставная, абдоминальная, почечная, некротическая, смешанная.

<u>Кожно-суставная</u> форма развивается внезапно, на фоне общего недомагания появляются геморрагические эритематозно-пурпурозные пятна, волдыри, отеки дермы и пжк. Поражаются голени, ягодицы, бедра, стопы, области около коленных и голеностопных суставов. В процесс могут вовлекаться слизистые оболочки рта. В тяжелых случаях может формироваться некротическая пурпура. Всуставах отмечается боль, отечность, припухлость, кажа над ними с геморрагическими высыпаниями.

<u>Абдоминальная форма</u> проявляется болями в животе за счет кровоизлияний в стенку кишечника и брыжейки,наличие крови в кале, кровавая рвота-мелена, ложные позывы к дефекации.

<u>Почечная форма</u> протекает по типу острого или хронического гломерулонефрита. Обычно почки поражаются через 1-4 недели после возникновения кожных проявлений.

Характер течения: острое (до 2 месяцев); затяжное (до 6 месяцев); хроническое.

<u>Диагностика:</u> на основании клинических данных, изменения в ОЭК, ОАМ,коагулограмма,своевременная диагностика осложнений абдоминального синдрома- аппендицит, инвагинации, перфорация кишечника и перитонит.

<u>Лечение:</u> обязательная госпитализация, избегать аллергизации, израциона исключить ригеры,

<u>Острая узловатая эритема</u>

<u>Сезонность</u>- весна, осень. **<u>Локализация</u>**- симметричные участки передней и наружной поверхности голени, бедер, ягодиц, предплечий**. Морфологические элементы-** узлы величиной до яйца, болезненные при пальпации. Цвет над ними изменяется как « цветение синяка».

Отмечается повышение температуры до 38-39 С., общая слабость, головнаяболь, артралгии. Заболеванию предшествует простуда, вспышка ангины. Узлы изчезают бесследно в течение 2-3 недель последовательно изменяя свою окраску. Изъязвления узлов не бывает. Рецидивов не наблюдается. **<u>Диф диагностика: лепра, липомы.</u>**

Хроническая узловатая эритема- отличается упорным рецидивирующим течением, возникает обычно у женщин среднего и пожилого возраста, нередко на фоне сосудистых и аллергических заболеваний, очагов фокальной инфекции. Обострения чаще всего возникают весной и осенью, характерезуются появлением небольного числа синюшно-розовых плотных болезненных узлов величиной с лесной орех. В начале своего развития узлы могут не изменять окраски кожи, не возвышаться над ней, а определяться только при пальпации. Исключительная локализация- голени. Отмечается умеренная отечность голеней и стоп. Общие явления непоятоянны и выражены слабо.

Лечение аллергических васкулитов:

1. Этиопатогенетическое(лечение предшеств и сопутств заболеваний)
2. Антибактериальная терапия
3. Кортикостероиды
4. Нпвс
5. Препараты улучшающие состояние сосудистой стенки
6. Местно зависит от формы : при узловатой тепло, УВЧ, ихтиоловая мазь, компресс с мазью вишенвского

Профилактика аалергаических васкулитов:

1. Своевременное лечение инфекционных заболеваний, санация очагов хрон инфекции, исключение переохлаждения.

37. Истинная экзема. Этиопатогенез. Клиника. Принципы лечения.

Экзема – это острое или хроническое незаразное воспалительное заболевание кожи, характерезующиеся истинным полиморфизмом кожной сыпи, чувством жжения, зудом и склонностью к рецидивам.

Теории этиопатогенеза экземы: нейрогенная, иммуноаллергическая, эндокринная, обменная.

Классификация экземы: истинная, микробная,. Себорейная, профессиональная, детская.

Стадии развития экзематозного процесса: эритематозная, папулезная, везикулярная, мокнутия, корковая, шелушения.

Клинические варианты истинной экземы: тилотическая и дисгидротическая

Клиника: характерен полиморфизм кожных высыпаний, обычно имеются вторичные элементы-корочки, эрозии, расчесы. Характерно чередование пораженных и непораженных участков кожи. Высыпания симметричные, могут распространяться на кожу тулуовища, конечночтей, лица Зуд различной интенсивности, на месте быстро вскрывшихся везикул становятся видны точечные эрозии «серозные колодцы», выделяющие серозный экссудат(мокнутие).

Тилотическая экзема: протекает в виде омозолелостей на ладонях и подошвах, возникающие трещины болезненны, зуд незначительный. Высыпания расположены вдоль борозд кожи, границы экземы незаметно переходят на здоровую кожу.

Дисгидротическая экзема: характеризуется появлением мелких пузырьков, величиной с булавочную головку, высыпания зинимают боковые поверхности пальцев, ладони и подпшвы. Могут встречаться многокамерные пузыри. Элементы заложены в эпидермисе и напоминают зерна вареного саго. Высыпания иногода применяют полиморфный характер, но без мокнутия, часто рецидивируют, всегда вызывают сильный зуд.

Диф диагностика: атопический дерматит, стрептодермия, псориаз.

Принципы лечения:

1. Диетотерапия
2. Гипосенсибилизирующая терапия
3. Антигистаминные препараты
4. Витаминотерапия
5. Седативная терапия
6. Абтибиотикотерапия
7. Глюкокортикоиды
8. Физиотерапия
9. Санаторно-курортное лечение
10. Местно в зависимости от стадии кожного процесса(примочки, кератопластические и противовоспалительные мази и пасты, кортикостероидные мази и кремы).

38. Микробная экзема. Этиопатогенез, клинические разновидности, лечение, профилактика.

МИКРОБНАЯ ЭКЗЕМА – развивается на фоне сенсибилизации организма к микробному фактору или продуктам его жизнедеятельности. Возбудителем воспаления чаще всего является **стафилококк** или **стрептококк**. Локализация – на нижних и верхних конечностях, на местах, подвергающихся постоянному трению.

- нуммулярная экзема – в виде округлых пятен, с четкими границами;
- варикозная - на фоне варикозного симптомокомплекса;
- паратравматическая - на месте травмы, раны, операции.
- Экзема сосков и пигментного кружка у женщин.

КЛИНИКА. Обычно вначале это ассиметричный процесс, развивается на месте хронических очагов пиодермии, вокруг ран, трофических язв, свищей, ссадин. Очаги поражения имеют четкие границы, нередко с бордюром отслаивающегося рогового слоя эпидермиса по периферии очага. Обилие папулезно-микровезикулярно-пустулезных корок по периферии очага. Очаги склонны к периферическому росту. Зуд менее интенсивен, чем при истинной экземе. Более чувствителен к лечению, позможно полное излечение. Очаги имеют сплошной характер мокнутия. Кожа в пределах поражения может иметь синюшно –красный цвет.

Диф диагностика: атопический дерматит, псориаз, стрептодермия.

Принципы лечения:

1. Диетотерапия
2. Гипосенсибилизирующая терапия
3. Антигистаминные препараты
4. Витаминотерапия
5. Седативная терапия
6. Абтибиотикотерапия
7. Глюкокортикоиды
8. Физиотерапия
9. Санаторно-курортное лечение
10. Местно в зависимости от стадии кожного процесса(примочки, кератопластические и противовоспалительные мази и пасты, кортикостероидные мази и кремы).

39. Ограниченный нейродермит. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика рецидивов.

Ограниченный нейродермит относится к группе зудящих дерматозов, основным симптомом которых является зуд.

Этиология- аллергическая, неврогенная, эндокринная, обменная, наследственная.

Элементы сыпи : папулы, чешуйки, корки, экскориации, лихенизация, пигментация.

Клинические формы:- ограниченный и диффузный.

Ограниченный нейродермит, или лишай Видаля

Локализация- задняя и боковая поверхности шеи, область затылка, локтевые и подколенные сгибы, внутренняя поверхность бедер.

Клинические проявления: первое высыпание представляет собой папулу, которая не претерпевает изменений , ее начальные размеры 1-3 мм. Папулы всегда четко ограничены, чаще круглые, плоские, с блестящей поверхностью. Цвет серый или коричнево-красноватый. Первоначально изолированные папулы собираются в очаги которые имеют округлую , лентообразную форму, а по краям вследствие трения очаги гиперпигментации.

Полностью сформированный очаг состоит из 3 зон:

1. В центре находится первичная плоская лихенификация с воспалительным утолщением кожи и огрублением кожных покровов.
2. Затем следует зона с лихеноидным папулами, которые расположены плотно рядом друг с другом и окрашены в цвет кожи
3. На периферии находится зона гиперпигментации шириной в несколько сантиметров, которая нечетко переходит в окружающую кожу.

Типичен сильный зуд различной интенсивности. Заболевание длится несколько месяцев или лет. **Диф диагностика: экзема, невус, псориаз.**

Лечение

1. Устранение психоэмоциональных факторов
2. Лечение сопутствующих заболеваний
3. Устранение зуда антигистаминными средствами
4. Глюкокортикоидные мази и кремы г=на очаги поражения.
5. Ихтиол и дегти
6. Мягкие рентгеновские лучи

40. Атопический дерматит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика рецидивов.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ возникает обычно у детей,проявляется как экссудативный диатез или детская экзема, переходящие в нейродермит. В основе болезни лежит врожденная предрасположенность к аллергии. Иногда заболевание сочетается с бронхиальной астмой, гельминтозами, эозинофилией**. Этиопатогенез:** В основе развития атопического дерматита лежит наследственно обусловленная дисфункция иммунной системы. Основную роль в патогенезе атопического дерматита играют реакции гиперчувствительности I типа.

- **острый** (острые воспалительные изменения)
- **подострый** (стихание воспаления)
- **ремиссия** (отсутствие острых проявлений, но сохранение лихенификации)

КЛИНИКА: Начальные признаки наблюдаются в первые полгода жизни. Это может быть спровоцировано введением прикормов или переводом на искусственные смеси.

Острая стадия:

- эритема
- папулы
- шелушение и припухлость кожи
- образование участков эрозий
- мокнутие и корочки
- присоединение вторичной инфекции →гнойничковые поражения

Хроническая стадия:

- утолщение кожи (лихенизация)
- выраженность кожного рисунка
- трещины на подошвах и ладонях
- расчесы
- Симптом Моргана – множественные глубокие морщинки у детей на нижних веках
- Симптом «меховой шапки» - ослабление и поредение волос на затылке
- Симптом «полированных ногтей» - блестящие ногти со сточенными краями из-за постоянных расчесов кожи
- Симптом «зимней стопы» - одутловатость и гиперемия подошв, трещины, шелушение.

Фазы развития АД: младенческая, детская, взрослая.
1) Младенческая и детская фазы – появлением на коже лица, конечностей, ягодиц участков эритемы ярко-розового цвета, на фоне которых возникают пузырьки и участки мокнутия с последующим образованием корочек и чешуек.
2) Взрослая фаза – очаги бледно-розового цвета с выраженным кожным рисунком и папулезными высыпаниями. Чаще в локтевых и подколенных сгибах, на лице и шее. Кожа сухая, грубая, с трещинами и участками шелушения.

ДИАГНОСТИКА:
1) Данные анамнеза
2) Клиническая картина
3) Лабораторные данные:

- Общий анализ крови (эозинофилия)
- Уровень IgE в сыворотке (повышен у 80% больных АД).
- Кожные пробы (положительны у большинства больных АД).
- Определение микрофлоры.

Главные диагностические критерии:

- кожный зуд
- типичные морфология (основной первичный элемент – папуло-везикула + вторичные элементы)
- хроническое рецидивирующее течение;
- начало заболевания в раннем детском возрасте (до 2-х лет);
- атопия в анамнезе.

ЛЕЧЕНИЕ:
1. Гипоаллергенная диета
2. Исключение домашних аллергенов
3. Гипосенсибилизирующая терапия
4. Антигистаминные препараты
5. Энтеросорбенты, Витаминотерапия, Седативные препараты, Иммуностимуляторы, . Физиотерапия
6.. Глюкокортикостероиды (в тяжелых случаях)
7. Антибиотики (при присоединении вторичной инфекции)
8. Местно-кератопластические, противозудные, противовоспалительные мази и кремы

41. Кожный зуд. Этиопатогенез, врачебная тактика. Принципы лечения.

Кожный зуд относится к группе зудящих дерматозов, ведущим симптомом которых является зуд.

Причины: сахарный диабет, заболевания печени и ЖКТ, желтухи, токсикоз, заболевания крови, злокачественные новообразования, глистные инвазии, алкоголизм, повышенная чувствительность к пищевым продуктам, медикаментозные средства, нарушение обменов, психо- эмоциональные нарушения, действие физических факторов.

Виды:
Первичный – у больных с желтухами, СД, болезнями крови, раковыми опухолями, с поражениями печени, почек, ЖКТ, поджелудочной железы, при нарушениях ЦНС.
Вторичный – почти при всех кожных заболеваниях.
Старческий зуд – из-за атеросклеротических изменений сосудов и внутренних органов, нарушений обмена.

От воздействия физ факторов- холодовой, тепловой, солнечный, высотный зуд.

По распространению:
- распространённый (генерализованный)
- ограниченный (локализованный)

Распространенный кожный зуд:
- первичные элементы отсутствуют
- множественные расчесы, экскориации, лихенизация
- линейные рубчики, пигментация
- «полированные» ногти
- мучительный зуд

Ограниченный кожный зуд:
- зуд анальной области (причины: геморрой, острицы, болезни толстого кишечника, трихомонады, климакс)
- зуд мошонки (причины те же)
- зуд вульвы (причины: нейродермит, болезни мочеполовых органов, нарушение обменов)
- зуд волосистой части головы (чаще при себорее)
- при длительном течении – инфильтрация и утолщение мест поражения, вторичная инфекция

Тактика врача: прежде всего тщательно собрать анамнез и попытаться найти причину – исключить диабет, заболевания крови, новообразования, провести исследование надрожжеподобные грибки, глисты, трихомонады.

<u>ЛЕЧЕНИЕ:</u>
1) выяснить причину и устраненить
2) антигистаминные и гипосенсибилизирующие средства
3) транквилизаторы
4) местно – кортикостероидные мази, противозудные взбалтываемые взвеси, кремы, пасты

42. Крапивница. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика.

КРАПИВНИЦА – заболевание токсико-аллергической природы., относящиеся к группе зудящих дерматозов, основным симптомом которых является зуд.

Причины: глисты, лямблии, нарушение функции пищеварительной системы, пищевые продукты, медикаменты, нарушения НС, синтетические ткани, растения, косметика, запахи цветов, укусы насекомых.

Классификация:

1. иммунологически обусловленная крапивница
2. неиммунологически обусловленная
3. пигментная крапивница

Клинические формы:

- острая (внезапное начало)
- хроническая
- рецидивирующая
- искусственная
- в ответ на механическое раздражение кожи
- стойкая папулезная
- отек Квинке
- холодовая
- тепловая
- солнечная (разновидностью фотодерматоза)

Острая форма:

- сильный зуд, жжение
- высыпания на всех участках кожи, даже на слизистых оболочках языка, гортани и губ
- волдыри различных размеров и формы, могут сливаться
- нарушение общего состояния организма

Хроническая рецидивирующая:

- сильный зуд
- нарушение сна
- расчесы
- лихенизация и кровянистые корки
- может осложняться вторичной инфекцией
- при поражении слизистых носа, рта, гортани в тяжелых случаях – удушье
- озноб, лихорадка, недомогание
- боли в суставах
- кишечные расстройства

ЛЕЧЕНИЕ:

1) слабительное, мочегонное (при попадании через ЖКТ)
2) антигистаминные препараты (кроме димедрола)
3) в/в 10% р-р хлорида кальция
4) в/м 10% р-р глюконата кальция
5) при отеках гортани немедленно 0,5 - 1,0 мл раствора адреналина подкожно
6) в тяжелых случаях – глюкокортикоидные гормоны
7) необходимо избегать приема острых блюд, консервов, сладостей, алкогольных напитков, следить за правильной работой кишечника

ОТЁК КВИНКЕ:

- отек кожи (слизистой)
- возможен отек подкожной жировой клетчатки лица и даже половых органов
- кожа плотноэластическая, чаще белого цвета
- держится от нескольких часов до 2 дней
- может сочетаться с обычной крапивницей
- во время отека в области гортани может проявиться стеноз и асфиксия

Профилактика: больному рекомендуют носить с собой всегда список препаратов на которых у него аллергия. Не рекомендуется использовать рентгеноконтрастные вещества. Н1-блокаторы и преднизон.

43. Почесуха взрослых. Этиопатогенез, клиника, течение, лечение.

ПОЧЕСУХА ВЗРОСЛЫХ (временная почесуха) – относится к группе зудящих дерматозов, чаще у женщин 20 - 40 лет; на разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей, ягодицах, туловище.

Причины: нервно-психические расстройства, аутоинтоксикации, болезни печени, ЖКТ, гормональные нарушения, неправильное питание.

Первичный элемент- везикула, волдырь.

Локализация- разгибательные поверхности предплечий, спина, живот , ягодицы.

Клиника:

- интенсивный зуд
- высыпания папуло-везикулярных элементов, волдырей
- геморрагические или серозные корочки
- белесоватые рубчики или пигментные пятна
- рецидивирующее течение, часто весноц и осенью, при смене климата.

Диагностика: типичный зуд в анамнезе, места предпочтительного расположения и экскориированные высыпания.

Диф диагностика с другими формами почесухи.

Лечение:

1) Рациональное питание и удаление причин.
2) Антигистаминные, гипосенсибилизирующие средства.
3) Местно – противозудные кремы и мази. , анестезирующие средства, ихтиол.

44. Хроническая красная волчанка. Этиопатогенез, клинические формы. Проявления дискоидной красной волчанки, лечение, профилактика.

Красная волчанка- является хроническим аутоиммунным заболевание с поражением соединительной ткани, при котором образуются аутоантитела и иммунные комплексы , откладывающиеся в стенках мелких сосудов под эпидермисом , характерезуется фоточувствительностью и эритематозными высыпаниями.

Этиология и патогенез данного заболевания до конца не изучены. Теории: аутоиммунная, генетическая, эндокринная, вирусная, воздействие повреждающих факторов, очаги фокальной инфекции.

4 клинические формы:

- дискоидная
- диссеминированная
- центробежная эритема Биетта
- глубокая красная волчанка Ирганга – Капоши

ДИСКОИДНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА –наиболее часто встречающаяся форма заболевания. Локализация- спинка носа, щеки, область лба, подбородок, волосистая часть головы, красная кайма губ. Характерна триада симптомов: эритема, гиперкератоз, атрофия.

Стадии течения процесса:

1. Эритематозная стадия: появляются мелкие, слегка отечные, растущие по периферии пятна. Цвет розовый с лиловым оттенком. Распростаняются и сливаются формирую очертания похожие на бабочку.
2. Гиперкератозно-инфильтративная стадия: основание очагов инфильтрируется, в центре появляются чешуйки. При снятии чешуйки с внутренней стороны видны чешуйки-шишки-симптом « дамского каблука»,
3. Атрофическая стадия: в центре очага формируется рубцовая атрофия. Кожа истончена, с множественными телеангиоэктазиями. По периферии сохраняется инфильтрация и гиперпигментация. На волосистой части головы остается стойкое облысение.

Диагностика:

- Клинические признаки: эритема, гиперкератоз, атрофия
- Лабораторные данные: ОАК, СОЭ, волчаночные клетки
- Гистологическое и иммунологическое исследование

Лечение:

- Антихинолиновые прпараты
- Иммуннокорригирующие средства
- Местно- активные кортикостероидные мази, обкалывание вокруг очагов гидрокортизоном, криотерапия жидким азотом, фротозащитные кремы.

45. Хроническая красная волчанка: диссеминированная форма и центробежная эритема Биетта. Клиника, течение, лечение, профилактика.

Красная волчанка- является хроническим аутоиммунным заболевание с поражением соединительной ткани, при котором образуются аутоантитела и иммунные комплексы , откладывающиеся в стенках мелких сосудов под эпидермисом , характерезуется фоточувствительностью и эритематозными высыпаниями.

Этиология и патогенез данного заболевания до конца не изучены. Теории: аутоиммунная, генетическая, эндокринная, вирусная, воздействие повреждающих факторов, очаги фокальной инфекции.

4 клинические формы:

- дискоидная
- диссеминированная
- центробежная эритема Биетта
- глубокая красная волчанка Ирганга – Капоши

Диссеминированная красная волчанка

Первичный элемент- эритема с инфильтрацией

Локализация- лицо, туловище, конечности и другие участки когжного покрова и волосистой части головы.

Клиника: Характерезуется наличием множественных очагов поражения, клинически не отличающихся от дискоидной формы. Моогут наблюдаться признаки поражения внутренних органов. Формы: центробежная, глубокая, гипсовидная, геморрагическая, себорейная, пигментная, опухолевая.

Стадии течения процесса:

1. **Эритематозная стадия:** появляются мелкие, слегка отечные, растущие по периферии пятна. Цвет розовый с лиловым оттенком. Распростаняются и сливаются формирую очертания похожие на бабочку.
2. **Гиперкератозно-инфильтративная стадия**: основание очагов инфильтрируется, в центре появляются чешуйки. При снятии чешуйки с внутренней стороны видны чешуйки-шишки- симптом « дамского каблука»,
3. **Атрофическая стадия:** в центре очага формируется рубцовая атрофия. Кожа истончена, с множественными телеангиоэктазиями. По периферии сохраняется инфильтрация и гиперпигментация. На волосистой части головы остается стойкое облысение.

Центробежная эритема Биетта

Первичный элемент- эритема.

Локализация- шея, , спинка носа, лицо

Клиника: характерезуется яркой, иногда отечной эритемой, резго ограничена,. Воспалительный процесс может сопровождаться нестойким повышением температуры, иногда болями в суставах, костях. Центробежная эритема чаще других форм трансформируется в системную красную волчанку.

Лечение:

- Антихинолиновые прпараты
- Иммуннокорригирующие средства
- Местно- активные кортикостероидные мази, обкалывание вокруг очагов гидрокортизоном, криотерапия жидким азотом, фротозащитные кремы.

ПРОФИЛАКТИКА. В весенне-летний период показан профилактический прием хинолиновых производных, препаратов, содержащих Р-каротин, никотиновой кислоты и цианокобаламина. Все больные должны работать в условиях, исключающих возможность воздействия на кожу солнечного света, лучистой энергии от искусственных источников света, химических раздражителей, холода, влаги, ветра, пыли.

46. Склеродермия, этиопатогенез, классификация. Клинические формы ограниченной склеродермии и их проявления. Диагностика, лечение.

Склеродермия – заболевание, в основе которого лежит дезорганизация соединительной ткани с поражением кожи, внутренних органов и других систем.

***Теории*:** генетическая, эндокринная, обменная, неврологическая, повреждающее воздействие экзогенных факторов (травма, охлаждение, радиация) и др.

Классификация:

- очаговая
- диффузная, или системная.

Очаговая склеродермия

Клинически*е* разновидности очаговой склеродермии**:**

Бляшечная форма:

Первичный элемент – пятно овальных или неправильных очертаний.

Локализация – туловище, конечности.

Клиник*а* протекает в 3 стадии:

- эритема, склонная к росту
- уплотнения и склероза (очаги цвета слоновой кости, деревянистой плотности с сиреневым ободком по периферии)
- атрофии кожи и гиперпигментации. Снижена секреция сальных и потовых желез.

Линейная, или полосовидная

Первичный элемент – пятно линейных очертаний.

Локализация – лоб, волосистая часть головы, по ходу нервных стволов, или в зонах Захарьина-Геда.

Клинические проявления как при бляшечной склеродермии. Заканчивается рубцами линейных очертаний как после удара острым предметом («сабельная»). Могут принимать вид *кольцевидных* перетяжек пальцев кистей и стоп, голеней (псевдоампутационная болезнь – айнъюм)

Болезнь белых пятен*,* или склероатрофический лихен, группа белесоватых слегка западающих мелких очагов склероза и атрофии кожи с перламутровым оттенком. Отдельные пятна окружены лиловым кольцом.

Локализаци*я* – кожа верхней части туловища, половых органов.

Гистопатология – в начальной стадии отмечается воспалительная реакция (отек и лимфоцитарная инфильтрация в дерме). В период инфильтрации эпидермис истончается, становится атрофичным; в дерме – склероз и фиброз. В заключительной стадии – атрофия и гиалиноз.

Ограниченная поверхностная склеродермия*,* проявляется слегка атрофичными пигментированными пятнами овальной или округлой формы, кожа слегка западает, уплотнение отсутствует. Эпидермис атрофирован с хорошо выраженной сосудистой сетью.

Прогрессирующая гемиатрофия лица проявляется атрофией подкожной жировой клетчатки, жевательных и мимических мышц, хрящевой и костной ткани на одной половине лица.

Дифференциальный диагноз – склередема взрослых, миопатия, склерема новорожденных, адипонекроз подкожный новорожденных, красная волчанка, парапсориаз.

Принципы лечения:

- пенициллин
- купренил (пеницилламин) – блокирует образование нерастворимого коллагена и оказывает противовоспалительное действие на систему соединительной ткани
- лидаза 64 ЕД п/к или в/м ежедневно или через день, на курс до 20-30 инъекций, повторные курсы проводят через 3-4 месяца
- лонгидаза
- сосудистые препараты - коринфар (нифедипин) по 20-50 мг в сутки (блокирует введение кальция в клетку)
- полиглюкин
- унитиол 5% р-р по 5 мл в/мышечно ежедневно до 15 инъекций на курс
- кортикостероидные препараты
- сосудорасширяющие средства – теоникол, компламин и др.
- биостимуляторы и иммуномодуляторы
- витамины группы В, А, Е и С

физиотерапевтические процедуры.

47. Себорея и угри. Клинические формы, диагностика, лечение, профилактика. **Себорея -** болезненное состояние кожи, связанное с выделением сальными железами, по сравнению с нормой, повышенного количества кожного сала, измененного химического состава. Изменение секреции кожного сала возникает вследствие нарушения физиологического равновесия между эстрогенными и андрогенными гормонами, что чаще наблюдается в возрасте от 14 до 25 лет. В патогенезе себореи определенную роль играют также вегетативные расстройства, фокальная инфекция, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. **При жирной себорее** увеличивается количество секретируемого жидкого кожного сала ***(жидкая себорея).*** На коже заметны расширенные устья волосяных фолликулов. При *густой себорее* появляются камедоны-сальные пробки в устье волосяного фолликула и имеют вид черной точки.

- **Жирная себорея** наблюдается чаще у девочек. Волосы у больных сальные, слипаются, легко загрязняются. У мужчин волосы выпадают, чаще в возрасте 20-24 лет, у женщин отмечается более или менее выраженное поредение волос. На коже волосистой части головы обильные серовато – желтые чешуйки. На фоне жирной себореи могут развиваться себорейная экзема, угревая сыпь, атеромы, алопеция.
- **Сухая себорея** – наблюдается чаще у мужчин, начинается в 16-20 -летнем возрасте. Проявляется сухостью кожи, шелушением, эритематозными очагами. На волосистой части головы обильное шелушение (перхоть), сухость волос, их истончение. Могут развиваться экзематизация и алопеция.
- **Смешанная себорея** – процесс начинается с явления жирной себореи на лице и волосистой части головы, впоследствии присоединяются симптомы сухой себореи на спине и груди.

Принципы лечения:

- витамин А в сочетании с витамином У, С и группы В
- препараты мышьяка, железа; фитин, глицерофосфат и другие общеукрепляющие средства
- диетотерапия с ограничением количества жиров, острых пряных блюд, особенно углеводов, поваренной соли
- нормализация функции желудочно-кишечного тракта
- местное лечение (препараты серы, салициловой кислоты, резорцина и др.), противосеборейные шампуни.

УГРИ

Вульгарные угри развиваются на фоне густой формы жирной себореи. Отмечается воспаление сальной железы и окружающих ее тканей. Заболеванию способствуют эндокринные и желудочно – кишечные нарушения, прием глюкокортикоидов, жирная пища. Нарушение функции вегетативной нервной системы, гиповитаминоз и др. Гиперплазия сальных желез, повышенное выделение кожного сала, его качественное изменение, приводящее к ощелачиванию среды и усиленному размножению микробов – стафилококков, коринебактерий, пропионбактерий, которые вызывают воспаление протока сальной железы. Сыпь появляется в период полового созревания и постепенно регрессирует у лиц старше 30 лет. **Локализация** – лицо, плечи, грудь, спина.

- **Черные угри** – (комедоны, точечные угри). На лице (крыльях носа, щеки, подбородок, лоб), груди, спине и плечах определяются «черные точки» – скопление ороговевших клеток, загустевшего кожного сала и частиц пыли в устьях протоков сальных желез. При надавливании выделяется беловатая масса в виде «червячка с черной головкой».
- **Папулезные угри** – в основании комедонов образуется инфильтрат и синюшно – розовые полушаровидные или конусовидные узелки.
- **Пустулезные угри** – воспалительная реакция интенсивная. Узелки ярко – красного цвета, болезненные, в центральной части образуются пустулы. При вскрытии их, отделяемое ссыхается в корочки, под которыми образуются рубчики.
- **Индуративные угри** – инфильтрат увеличивается в размере, достигая вишневой косточки, отмечается болезненность. Глубокие пустулы оставляют рубцы.
- **Некротические угри** – на лице (лоб, виски) располагаются узелки и пустулы с гнойно – геморрагическим содержимым, ссыхающиеся в грязно – бурые некротические корки. После их отторжения остаются штампованные рубчики.
- **Конглобатные угри** – на лице, верхней части туловища появляются множественные узелки, комедоны, нагнаивающиеся атеромы, абсцессы, при вскрытии которых образуются свищевые ходы. Заживление медленное, формируются келлоидные рубцы.

ЛЕЧЕНИЕ:

1) легкая форма – наружные средства (эритромициновая мазь), бензил пероксид, среднетяжелая форма – местно + антибиотики (доксициклин), 3) тяжелое течение –роаккутан по 0,5-1,0 мг/кг веса , 4) иммномодуляторы, витамины, 5) лечение сопутствующих заболеваний.

48. Акантолитическая пузырчатка. Клинические формы. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.

Пузырчатка – наиболее тяжелый и злокачественно протекающий дерматоз, характеризующийся появлением на видимо неизмененной коже и слизистых внутриэпидермальных пузырей.

Теории происхождения *:*инфекционная*,* вирусная*,* энзимная*,* нейрогенная*,* наследственная*,* теория задержки солей.

Клинические разновидности:

- вульгарная
- листовидная
- вегетирующая
- себорейная (эритематозная)

Общий признак для всех разновидностей – акантолиз с образованием интерэпителиальных пузырей.

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ:

1) ВУЛЬГАРНАЯ:

- внутриэпидермальный вялый пузырь на неизмененной слизистой (рта и красной каймы губ) или коже, имеют тенденцию у перефирическому росту и слиянию между собой, вскрытие пузыря → эрозии,на них формируются корки, пигментные пятна после заживления, пузыри под тяжестью экссудата могут принимать грушевидную форму - симптом груши, положительный симптом Никольского и Асбо-Хансена, слабость, повышается температура, присоединяется вторичная инфекция, без адекватного лечения гибель через 1-2 года

1-я фаза начало заболевания, на слизистой рта, глотки, носа, высвпания ограничены протекает несколько месяцев.

2-я фаза- появление высыпаний на коже и постепенное их расрастание

3-я фаза распространение пузырей и эрозий на коже и видимые слизистые.

2) ЛИСТОВИДНАЯ:

- плоские вялые пузыри на неизмененной/слабо гиперемированной коже, быстро трансформируются в чешуйко-корки (похожи на слоёное тесто), образование на местах прежних эрозий под корками новых поверхностных пузырей, симптом Никольского резко выражен в очаге и на неизмененной коже вблизи от него, постоянное жжение, зуд, боль в пораженной коже, зябкость, повышается температура тела, ухудшается общее состояние, при длительном течении – дистрофические изменения ногтей, частично выпадают волосы

3) ВЕГЕТИРУЮЩАЯ:

- вегетации в очагах поражения, вялые плоские пузыри на неизмененной слизистой оболочке и коже, экссудат серозно-гнойный со зловонным запахом , впервые на слизистой оболочке рта, а затем в местах перехода ее в кожу, высыпания вокруг естественных отверстий и в складках кожи на соприкасающихся поверхностях

4) СЕБОРЕЙНАЯ:

- на себорейных участках, симметричные эритематозные очаги круглой/овальной формы, разной величины, покрытые наслоением чешуек и плоских корок, повыш. температура ухудшается общее самочувствие больного, сочетание симптомов, типичных для себорейного дерматита + дискоидной красной волчанки + пузырчатки

Диагностика: симптом никольского краевой(при потягивании пинцетом за обравок покрышки пузыря происходит отслойка эпидермиса на видимо здоровой коже), очаговый(при трении на вид здоровой кожи между пузырями, наблюдается ооторжение верхних слоев эпидермиса), симптом асбо-ханзена- при давлении пальцем или покровным стеклом сверху на пузырь площадь его основания увеличивается, характерная клиническая картина, цитологический метод9акантолитические клетки), гистологический метод, иммунноморфологические методы

ЛЕЧЕНИЕ: 1) кортикостероиды (по жизненным показаниям) – преднизалон в ударных дозах (50-80 мг в сутки) цитостатики (метотрексат, азатиоприн), препараты калия, анаболические гормоны (нерабол, фенаболил) антибиотик, регулярный контроль уровня глюкозы в крови, местно – полоскания дез. средствами, смазывание эрозий растворами анилиновых красителей, мази с антибиотиками и кортикостероидами, витамины В

49. Принципы лечения больных акантолитической пузырчаткой.

- Этиология истинной пузырчатки неизвестна, поэтому лечение это группы заболеваний остается патогенетическим, направленым на подавление синтеза аутоантител к белкам десмосомных связей шиповатых клеток эпидермиса.
- Главным средством лечения больных является глюкокортикостероиды.
- Не существует абсолютных протипопоказаний к лечению пузырчатки ГК, т к только ГК предотвращают смерть больных
- ГК назначают самомтоятельно или в сочетании с цитостатиками
- Цитостатики не могут полностью заменить ГК и с их помощью удается лишь снизить дозу ГК
- **Начинать лечение нужно с ударных доз ГК, лучше преднизолона**
- Ударная доза 90-120 мг в сутки и выше
- Если в течении недели не удается подавить образование пузырей и не наступает эпителизация эрозий, суточную дозу ГК увеличивают на 1\3, а при необходимости можно удвоить
- Местная терапия- краски, аэрозоли состоящие из антибиотика и ГК, трехкомпанентные препараты(антибиотик+ГК+противогрибковый препарат)

Этапы лечения больных пузырчаткой:

1. Назначение « ударных доз» ГКв течение 3-6 недель(прекращение появления новых пузырей и эпителизация эрозий на коже)
2. Постепенное медленное снижение суточной дозы ГК(сдерживающая образование рузырей), около 4 месяцев
3. Длительное (пожизненное) амбулаторное лечение больного поддерживающими дозами ГК при диспансерном наблюдении.

50. Пемфигоид. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

Пемфигоид (неакантолитическая пузырчатка)

Этиология заболевания неизвестна. В патогенезе дерматоза играют роль аутоиммунные процессы.

Клинические разновидности:

- буллезный пемфигоид (поражаются кожа и слизистые)
- рубцующийся пемфигоид (поражаются слизистые оболочки и кожа, вследствие чего образуются рубцы на местах высыпаний, особенно конъюнктиве глаз).

Буллезный пемфигоид – это редкий, обычно хронически протекающий, относительно доброкачественный буллезные дерматоз.

Первичные элементы- напряженные пузыри возникают под эпидермисом из-за расслоения базальной мембраны. Они возникают на видимо не измененной коже или на фоне отечной эритемы и сопровождаются выраженным зудом.

Локализация- боковые поверхности шеи, подмышечной области, паховые складки, сгибательные повехности конечностей и верхняя часть живота.

Может протекать хронически с обострениями и ремиссиями разной длительноти. Без лечения смертность меньше чем при вульгарной пузырчакте. Больные могут погибнуть от присоединения вторичной инфекции

Диагностика: краевой симптом никольского может быть слобоположительный, цитодиагностика \(в мазках-отпечатках много эозинофилов), акантолит клеток нет, гистологические изменения(субэпидермальная полость в которой много эозинофилов), иммунологические исследования

Диф диагностика: вульгарная пузырчатка, дерматоз Дюринга

Лечение: исключить сопутствующие заболевания, патогенетическая терапия (ГК+ цитостатики), преднизолон в средних дозировках (40-60 мг в день), новое в лечении ударные дозы никатинамида

Рубцующий пемфигоид – редкое хронически протекающее заболевание видимых слизистых оболочек, изредка кожи приводящее к рубцеванию, этиология неизвестна, патогенез-аутоиммунный.

Клиника: заболевание начинается с поражения конъюнктивы или слизистой оболочки рта,. Первичным элементом является небольшой напряженный пузырь спрозрачным содержимым. Чаще пузыри возникают на фоне небольшой гиперемии, При разрыке покрышки пузыря формируется мясо-краного цвета глубокие эрозии, могут повторно появляться на тех же местах после заживления. Это приводит к рубцовым изменениям с существенным нарушением пораженного органа.

Диагностика : симптом никольского всегда отрицательный., цитологическое исследование- в мазках-отпечатках акантоитические клетки отсутствуют, гистологическое исследование-субэпителиальная полость без признаков акантолиза, иммуннологические исследования

Диф диагностика: вульгарная пузырчатка, болезнь Бехчета, хроническая красная волчанка

Лнечение: системное применение ГК можно пробовать лечить антималярийными препаратми, в рубцовой стадии заболевания рационально оперативное вмешательство с последующей пластикой дефекта, на очаги поражения применяют ГК в форме и растворов.

51. Герпетиформный дерматит Дюринга. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

Герпетиформный дерматит Дюринга- это редкий доброкачественный, хронически рецидивирующий, полиморфный с образованием характерных герпетиформных пузырей дерматоз. Этиология неизвестна, патогенез- особая форма цилиакии с характерными кожными проявлениями.

КЛИНИКА:

- зуд, предшествующий высыпаниям, появляются коркии отдельные эрозии, возможны очаги лихенификации и развитие вторичной пиодермии.
- истинный полиморфизм (розеолы, пузыри, волдыри, папулы)
- группировка элементов
- при регрессе высыпаний на их месте остается стойкая пигментация
- высыпания появляются на гиперемированной и слегка отёчной коже
- пузыри напряженные, плотные
- после вскрытия – язвы, которые после заживления оставляют пигментные пятна
- симп. Никольского отрицательный
- располагаются на разгибательных поверхностях конечностей, верхней части спины, живвота, ягодицах.

ДИАГНОСТИКА – гистологическое исследование пузыря, исследование пузырной жидкости на эозинофилы (в крови и в костном мозге), постановка кожной пробы Ядассона (с 50% мазью йодистого калия)., биопсия тонкой кишки, такие же изменения как и при целиакии

Диф дигностика: чесотка, почесуха взрослых, атопический дерматит

ЛЕЧЕНИЕ:

1) препараты сульфонового ряда: димоцифон, промацетин, сульфетрон
2) возможно сочетание с глюкокортикоидами
3) местно – полоскания дез. средствами, смазывание эрозий растворами анилиновых красителей, мази с антибиотиками и кортикостероидами

52. Витилиго. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, принципы лечения.

Витилиго - обусловлено отсутствием в меланоцитах и меланосомах фермента тирозиназы, участвующего в процессе пигментообразования. В патогенезе болезни большую роль играет недостаточность гипофизарно-надпочечниковой системы, щитовидной железы, нервной системы и др. факторы.

Клинически проявляется в виде белых депигментированных пятен, на которых могут быть обесцвеченные волосы, с гиперпигментированной кожей вокруг. Пятна не шелушатся, возможно нарушение потоотделения, салоотделения, угасание мышечно-волоскового рефлекса. Иногда участки витилиго возникают вокруг небольших пигментных пятен - болезнь Сеттона

Дифференциальный диагноз проводится с сифилитической лейкодермой, лепрой, вторичной лейкодермой после псориаза, розового лишая, парапсориаза, отрубевидного лишая и других кожных болезней.

Лечение малоэффективно, назначаются препараты железа, цинка, меди, витамин B_6, B_{12}, PP, пувален, меладинин, мелагенин – плюс, экстракт плаценты с последующим облучением очагов лазерными лучами, УФО, ПУВА – терапия.

53. Бородавчатый туберкулез кожи. Клиника, диагностика, лечение.

Туберкулез кожи- это хроническое инфекционное заболевание , вызванное микобактериями туберкулеза, характерезующееся разнообразием клинических форм и образование специфических гранулем в коже.

Возбудитель- туберкулезная палочка или палочка коха

Свойства: не образует спор, не имеет капсулу, неподвижна, устойчива к кислотам, щелочам, спирту., аэроб.

Наблюдается реже других форм туберкулеза кожи. Чаще болеют мужчины.

Пути заражения:

- экзогенный. Болеют лица, соприкасающиеся с трупами людей и животных, пораженных туберкулезом
- аутоинокуляция у больных с открытыми формами туберкулеза легких или кишечника, попадая на кожу с мокротой или калом.

Локализация – тыл кистей, реже стоп.

Клиника – первичный элемент- плотная папула, синюшно-красного цвета, величиной с крупную горошину, которая постепенно разрастается, превращается в плотную плоскую бляшку, на поверхности которой начиная с центра образуются борадавчвтые разрастания с массивными роговыми наслоениями. При разрешении в центре роговые массы отпадают, инфильтрат уплощается, на месте поражения остается рубцовая атрофия , на которой никогда не появляются новые высыпания, в отличие от туберкулезной волчанки.

Дифференциальная диагностика – вульгарные бородавки, вегетирующая пиодермия, красный плоский лишай, вторичный сифилис.

В комплексном лечении туберкулеза кожи ведущая роль принадлежит специфическим противотуберкулезным препаратам. По степени антибактериальной активности они делятся на 3 группы:

1-я группа – высокой противотуберкулезной активности (изониазид, тубазид, ГИНК, метазид, рифампицин, тиоцетазон).

2-я группа – препараты средней терапевтической активности (стрептомицин, этамбутол, этионамид, максаквин, канамицин, циклосерин, виомицин, пиразинамид).

3-я группа - препараты умеренной эффективности (ПАСК, тибон).

- для достижения наилучшего терапевтического эффекта целесообразно назначение 2-3 препаратов

- параллельно со специфической проводится и неспецифическая терапия (иммунокорректоры, витамины, гипосенсибилизирующие средства)

- лечение должно быть курсовым и проводится до полного излечения

- профилактическое лечение проводится через 3-5 месяцев после завершения основного курса лечения.

54. Туберкулезная волчанка, клинические разновидности, диагностика.

Наиболее часто втречающающаяся клиническая форма туберкулеза кожи, составляет 50-7 % всех кожно- туберкулезных заболеваний, развивается чаще всего в детском или подростковом возрасте, характерезуется хроническим медленным прогресирующим течением и наклонностью к расплавлению тканей.

Локализация- чаще всего на лице, особенноо носу , коже щек, верхней губе, реже- шея, туловище, конечности

Клиника: Основной морфологический элемент- люпома-бугорок желтовато-красного или желтовато-коричневого цвета, мягкой консинстенции, с гладкой блестящей поверхностью. Бугорки постепенно увеличиваются сливаются и образуют бляшки. Медленный рост очага по периферии. Исход – рубцевания. Рубцы обычно тонкие, нежные, гладкие, напоминающие смятую папиросную бумагу.

Клинические формы туберкулезной волчанки: плоская, язвенная.

Разновидности плоской формы:

- **пятнистая плоска волчанка** – не возвышается над поверхностью кожи
- **Бугорковая плоская волчанка-** поверхность бляшек выспупает над поверхностью кожи
- **Опуходлевидная-** при которой редко разросшиеся бугорки представляют собой мягкие опухолевидные образования.
- **Чешуйчатая-** когда обычно гладкая поверхность бугорков покрывается чешуйками
- **Бородавчатая-** на поверхности бугорков появляются бородавчатые образования.

Язвенная форма туберкулезной волчанки: после появления типичных для волчанки люпом, последние подвергаются сравнительно быстрому изъязвлению Язвы поверхностные, края их мягкие, малоболезненные, легко кровоточат. Но иногла деструктивные язвенные изменения вовлекают в процесс глубоко подлежащие ткани, это мутилирующая форма волчанки, при этом происходит мутиляция- разрушение и отторжение хрящей носа, ушных раковин, пальцев.

Нередко поражаются и слизистые оболочки носа и полости рта.в полости рта- на слизистой десен и твердого неба, образуются язвы с фестончатыми краями с зернистым дном, покрытым желтым налетом

Диагностические симптомы туберкулезной волчанки

1. Симптом Поспелова или пуговчатого зонда: при надавливании зондом на бугорок он легко погружается в глубину ткани, что обусловлено разрушением колагенновых и эластических волокон.
2. Феномен « яблочного желе» при надавливании предметным стеклом на бугорок кожа обескроваливается и люпома просвечивается в виде пятна напоминающего яблочное желе.

Диф диагностика: лепра, лейшманиоз, дискоидная красна я волчанка

55. Папуло-некротический туберкулез кожи, клиника, диагностика.

Папуло - некротический туберкулез.

Заболевание обычно начинается в детском или юношеском возрасте.

Локализация чаще на коже разгибательной поверхности конечностей, ягодиц, туловища. Возникает чаще на фоне хронически текущего первичного туберкулеза. У больного можно обнаружить признаки нарушения кровообращения(акроцианоз), потливость кистей и стоп, эндокринные расстройства(щитовидных желез или половых желез).

Клинически проявляется плоскими или полушаровидными папулами, величиной от конопляного зерна до чечевицы, плонная на ощупь. в центре которых развивается некроз. На месте узелков формируются плотно сидящие корки грязно-серого цвета. Если снять корку, обнаруживается поверхностная язва округлой формы. После себя процесс оставляет «штампованные» рубчики., округлые, сначала гиперпигментированные, окруженные ободком фиолетового цвета, затем они обесцвечиваются.

Дифференциальная диагностика – почесуха взрослых, угри, вторичный сифилис, парапсориаз. В комплексном лечении туберкулеза кожи ведущая роль принадлежит специфическим противотуберкулезным препаратам.

Диагностика:

- Туберкулиновые пробы(манту) . Предполагается что у больных кожным туберкулезом обладает повышенной чувствительностью к туберкулину.
- Биопсия кожи из очагов (эпителиоидные клетки, клетки пирогова-лангханса)
- R- скокпии графическое исследование
- Клиническая картина

По степени антибактериальной активности они делятся на 3 группы:

1-я группа – высокой противотуберкулезной активности (изониазид, тубазид, ГИНК, метазид, рифампицин, тиоцетазон).

2-я группа – препараты средней терапевтической активности (стрептомицин, этамбутол, этионамид, максаквин, канамицин, циклосерин, виомицин, пиразинамид).

3-я группа - препараты умеренной эффективности (ПАСК, тибон).

- для достижения наилучшего терапевтического эффекта целесообразно назначение 2-3 препаратов

- параллельно со специфической проводится и неспецифическая терапия (иммунокорректоры, витамины, гипосенсибилизирующие средства)

- лечение должно быть курсовым и проводится до полного излечения

- профилактическое лечение проводится через 3-5 месяцев после завершения основного курса лечения.

56. Колликвативный туберкулез кожи, клиника, диагностика, лечение.

Скрофулодерма, или колликвативный туберкулез. Различают первичную и вторичную скрофулодерму, болеют чаще в детском возрасте.

Пути заноса инфекции в кожу:

- Лимфогенно-гематогенный (первичная скрофулодерма)
- С пораженные туберкулезом лимфатических узлов(вторичная скрофулодерма)

Первичная скрофулодерма

- Образуютсяузлы, расположенные в глубоких слоях дермы или пжк
- Узлы резко ограничены , вначале имеют плотную консинстенцию ислегка выступают над уровнем кожи.Затем они увеличиваются, постепенно размягчаются и расплавляются, спаиваются с кожей. Кожа над ними сюнишно-красного цвета, затем образуется язва с выделение небольшого количества гноя и крупинок некротической ткани.
- Язвы имеют неправильную форму, поверхностные с мягкими нависающими краями малоболезненные. Рубцы после скрофулодермы неровные, мостиковидные, с перемычками – мохнатые

<u>Вторичная скрофулодерма:</u>

- Процес на коже развивается вторично из пораженных лимфоузлов или же в коже вокруг свищевого поражения при костном или суставном туберкулезе. Язвы более глубокие, чем при первичной. Рубцы на месте язв втянуты и спаяны с подлежащими тканями, они неровные мостиковидные с сосчками

- Локализация : чаще на шее, под нижней челюстью,на щеках, в области грудины. Процесс чаще развивается у детей и подростков.

<u>Диф диагностика: гуммозный сифилис, лепра.</u>

<u>Лечение:</u> По степени антибактериальной активности они делятся на 3 группы:

1-я группа – высокой противотуберкулезной активности (изониазид, тубазид, ГИНК, метазид, рифампицин, тиоцетазон).

2-я группа – препараты средней терапевтической активности (стрептомицин, этамбутол, этионамид, максаквин, канамицин, циклосерин, виомицин, пиразинамид).

3-я группа - препараты умеренной эффективности (ПАСК, тибон).

- для достижения наилучшего терапевтического эффекта целесообразно назначение 2-3 препаратов
- параллельно со специфической проводится и неспецифическая терапия (иммунокорректоры, витамины, гипосенсибилизирующие средства)
- лечение должно быть курсовым и проводится до полного излечения
- специфическое лечение: витамины, десенсибилизирующие средства, лечебное питание

57. Новообразования кожи (базалиома и плоскоклеточный рак кожи). Клиническая картина. Базалиома, или базально- клеточный рак

В развитии базалиомы имют значение генетические факторы, иммунные процессы, влияние инсоляции, воздействие канцерогенных веществ и др. Может возникнуть на видимо неизмененной коже или как озлокачествление различных предраковых заболеваний. Чаще появляется у лиц старшего возраста.

Локализация – область верхней половины лица, верхняя губа, ушные раковины, нос, щеки, носогубные складки.

Особенности базалиомы – при всех формах нет склонности к метастазированию, медленный рост.

Клинические формы базалиом:

- **поверхностная базалиома** – вид бляшки, по периферии – валик «жемчужных» узелков, в центре корка, под ней – атрофия
- **плоская рубцовая базалиома** – плоская бляшка, серпигинозное распространение по периферии, рубцовая атрофия в центре
- **склеродермоподобная базалиома** – плотная бляшка, цвет слоновой кости
- **узловатая (нодулярная) базалиома** – плотные шаровидные узелки, изъязвление с глубоким некрозом, разрушение подлежащих костей и хрящей, болезненность и склонность язвы к кровоточивости.

Дифференциальный диагноз – твердый шанкр, шанкриформная пиодермия, красная волчанка, туберкулезная волчанка, липомы, кератомы.

Лечение – хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое.

Плоскоклеточный рак

Особенности – склонность к росту.

Локализация – любая, чаще открытые участки тела или около естественных отверстий.

Формы – язвенная, папиллярная.

Клиника язвенной формы – в начале желтовато – коричневая папула, покрытая чешуйками, легко кровоточащая, раннее изъязвление с кровянистым секретом, рост язвы в ширину и глубину с вовлечением подлежащих тканей – мышц, фасций, хрящей, костей.

Клиника папиллярной формы – разрастания, подобные цветной капусте, быстрый рост до величины куриного яйца, поверхность гладкая или бугристая, цвет ярко – красный, некротический распад с образованием глубокой язвы.

Лечение – хирургическое, лучевая терапия.

58. Предраковые заболевания кожи и слизистых (болезнь Боуена, гиперкератоз губ, хейлит, лейкоплакия, кожный рог, кератоакантомы). Клиническая картина.

Болезнь Боуена проявляется наличием темно-красного цвета бляшек, покрытых чешуйками и корками, напоминающими псориатические бляшки, с неправильными очертаниями.

Хейлит образивный проявляется единичными длительно не заживающими эрозиями ярко-красного цвета с гладкой поверхностью. По периферии эрозии умеренная гиперемия и инфильтрация.

Ограниченный предраковый гиперкератоз губ встречается чаще у мужчин старше 30 лет и локализуется на красной кайме нижней губы сбоку от центра. Поражение в виде ограниченного участка, покрытого плотно сидящими чешуйками серовато-белого цвета, возвышающееся над **окружающей красной каймой.**

Типичная кератоакантома проявляется узлом, в центре которого имеется кратерообразное углубление (псевдоязва) вокруг которой валик плотной консистенции. Частая локализация на лице, тыле кистей. Через 1-3 месяца кератоакантома самопроизвольно разрешается, оставляя поверхностный рубчик.

Атипичные формы кератоакантомы: гигантская, плоская (бляшковидная), центробежная, бородавчатая, узловато-вегетирующая.

Лечение. Криодеструкция, диатермокоагуляция, наблюдение онколога.

Кожный рог – ограниченное разрастание роговых масс (имеет сходство с рогом животного), может переходить в рак.

Локализация на открытых участках (губы, нос, щеки, ушные раковины).

Лечение – электрокоагуляция.

Лейкоплакия – преканкроз слизистых оболочек полости рта, красной каймы губ, половых органов. Причинами могут быть травматизация, курение, инсоляция и др. Различают лейкоплакию курильщиков, плоскую, бородавчатую и эрозивно-язвенную. Появляется воспалительный очаг, который уплотняется, возвышается, приобретает белесоватый или буровато-коричневый цвет.

59. Лепра. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения.

Лепра, или проказа, хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией лепры, открытой Ганзеном. Поражаются кожа, слизистые, периферическая нервная система, внутренние органы, кости, зрение.

Источник заражения - больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем, при тесном и длительном контакте с больным, через предметы обихода.

Инкубационный период от 2-3 месяцев до 10-20 и более лет.

- Лепроматозный тип самый заразный, так как протекает на фоне анергии. Поражается кожа лица, тыл кистей, предплечья, голени, бедра, проявляется инфильтратами, бугорками, узлами. Поражение лица придает вид «львиной морды». На месте лепром отсутствует температурная, болевая и тактильная чувствительности, повышенное салоотделение и выпадение волос. Поражения нервной системы проявляется невралгиями, полиневритами, психозами. Возможны мутиляции (отторжения) кистей и стоп.

- Туберкулоидный тип – протекает на фоне хорошей сопротивляемости организма. Поражается кожа, редко нервы. Появляются пятна или бляшки красно-синюшного цвета, по периферии которых определяется валик с четкими границами. Периферические нервы утолщены в виде тяжей или жгутов. Нарушается болевая, температурная и тактильная чувствительности.

- Недифференцированный тип проявляется эритематозными, гипохромными пятнами с четкими границами. В очагах выпадают пушковые волосы. Вначале исчезают температурная, а позднее болевая и тактильная чувствительности, отсутствует потоотделение. Развиваются моно – и полиневриты, атрофии мышц кистей, тенора, гипотенора, предплечий, голеней, стоп. Лицо приобретает маскообразное выражение (лицо «святого Антония»). Возможна мутиляция фаланг пальцев или рассасывание мелких костей на кистях и стопах.

Диагностика лепры основывается на:

- эпиданамнезе
- клинических проявлениях
- исследовании температурной, болевой и тактильной чувствительности
- поиске возбудителя
- проведении диагностических проб:
- лепроминовая – 0,1 мл лепромина внутримышечно в предплечье

Лечение комплексное, хроническое, одновременно назначается несколько препаратов. Основными являются сульфоновые препараты – лепросан, производные тиомочевины-рифампицин, биостимуляторы, иммунномодуляторы.

60. Кожный лейшманиоз. Эпидемиология, клинические формы, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Кожный лейшманиоз встречается в странах с тропическим климатом. Возбудитель – тельца Боровского.

Сельский тип – leischmania tropica major.

Городской – leischmania tropica minor.

Источники заражения для сельского типа – суслики, песчанки, собаки, ежи, человек; для городского типа – человек.

Переносчик болезни – москиты.

Показатели	Городской тип	Сельский тип
инкубация	6-8 мес. до 1-2 лет	2-4 недели, 2 мес.
источник	человек	грызуны
локализация	открытые участки кожи	чаще верхние и нижние конечности, лицо
первичный элемент	бугорок плотной консистенции	болезненный, фурункулоподобный инфильтрат тестообразной консистенции
клинические проявления	через 3-6 мес. появляются язвы с неровными, валикообразными краями, дно с зернистыми грануляциями (симптом «рыбьей икры»)	через 1-3 недели появляются глубокие язвы с подрытыми краями. По периферии - радиально идущие узелковые лимфангиты (по типу бус) и лимфадениты.
длительность процесса	год и более	3-6 месяцев

Диагностика – анамнез (пребывание в эндемических зонах), клинические проявления, обнаружение возбудителя в соскобах тканевой жидкости очага поражения.

Дифференциальная диагностика – туберкулезная волчанка, бугорковый сифилид, лепра.

Лечение – доксициклин (вибромицин) по 0,2 в сутки в течение 15 дней, метациклин 0,3 2 раза в день 15 дней.

Профилактика – уничтожение москитов, защита от них и ликвидация резервуаров инфекции.

61. Алопеция. Этиопатогенез, клиника, дифференциальный диагноз, принципы лечения.

Этиология не выяснена. В развитии болезни играют роль:

- очаги хронической инфекции
- нарушения эндокринной системы
- психотравмы
- состояние иммунной системы
- наследственный фактор и др.

Различают: очаговую, субтотальную, тотальную и универсальную алопеции.

Очаговая форма проявляется округлыми, различных размеров очагами поражения с отсутствием волос, возможно со слегка гиперемированной и отечной кожей. По периферии – зона расшатанных волос, которые легко удаляются при потягивании.

Субтотальная форма локализуется вдоль края роста волос, в затылочной и височно-теменных областях.

Тотальная алопеция проявляется отсутствием волос на всей поверхности волосистой части головы.

Универсальная форма характеризуется отсутствием волос, в том числе и пушковых, на всей поверхности кожи.

Дифференциальная диагностика проводится с:

- грибковыми инфекциями волосистой части головы (микроспория, поверхностная, хроническая и глубокая трихофития, фавус)
- сифилитической инфекцией
- травматической алопецией
- лепрозной и токсической алопецией
- болезнями соединительной ткани (склеродермия, хроническая красная волчанка).

Лечение:

- выявление возможных патогенетических механизмов болезни
- препараты, улучшающие микроциркуляцию (ксантинола никотинат, трентал и др.)**препараты меди, железа, цинка (0,5% р-р сульфата меди, цинктерал, лактат железа и др.)
- биогенные стимуляторы (алое, гумизоль, спленин и др.)
- адреноблокаторы (фентоламин)
- гормональная терапия
- иммуносупрессивные средства (циклоспорин А, такролимус)
- местная иммуносупрессивная терапия (дибутиловый эфир сквароновой кислоты, дифенилциклопропенан)
- местная раздражающая терапия (0,5-1% крем антралин, 2-5% раствор и мазь миноксидила.)
- физиотерапия

62. Саркома Капоши. Клинические формы.

Саркома Капоши - многоочаговое заболевание опухолевой природы, поражающее в основном кожу, слизистые оболочки полости рта, желудочно-кишечного тракта, лимфатические узлы.

На руках и ногах, чаще в области, стоп и голеней, появляются пятна синевато-фиолетового цвета, которые постепенно инфильтрируются, образуя круглые или овальные диски, узлы с шелушащейся поверхностью. Иногда в начале заболевания имеются папулы, напоминающие высыпания при красном плоском лишае. Постепенно опухоли достигают размеров лесного или грецкого ореха. Они плотноваты, эластичны или тестоваты, как правило, пронизаны телеангиэктазиями и могут сопровождаться болями (особенно при надавливании). Затем узлы могут рассосаться, оставляя пигментированные вдавления, напоминающие рубцы. Классификация саркомы Капоши:

*** Классический тип * Эндемический тип * Эпидемический тип**

*** Иммунно-супрессивный тип.**

Классический тип. Излюбленные локализации саркомы Капоши классического типа - это стопы, боковые поверхности голени, поверхности кистей. Очень редко на слизистых оболочках и веках. Очаги поражения обычно симметричны, асимптомны, но редко могут быть зуд и жжение. Границы очагов, как правило, чёткие.

Различают 3 клинические стадии:

1. Пятнистая. Самая ранняя стадия. Пятна на этой стадии красновато-синюшного или красновато-бурого цвета диаметром от 1мм до 5мм, неправильной формы. поверхность гладкая.

2. Папулезная. Элементы в эту стадию сферической или полусферической формы, плотно-эластической консистенции, от 2мм до 1см в диаметре. Чаще изолированные. При слиянии образуют бляшки уплощенной или полушаровидной формы. Поверхность бляшек гладкая или шероховатая (по типу апельсиновых корок).

3. Опухолевая. На этой стадии происходит образование единичных или множественных узлов. Диаметром от 1-5см, красно-синюшного или синюшно-бурого цвета. Мягкие или плотно-эластической консистенции, сливающиеся и изъязвляющиеся.

Эндемический тип. Распространён, в основном, у жителей Центральной Африки. Начинается преимущественно в детском возрасте, пик заболеваемости приходится на первый год жизни ребёнка. Как правило, поражаются внутренние органы и главные лимфоузлы. Кожные поражения редки и минимальны.

Эпидемический тип. Эта саркома Капоши, ассоциированная со СПИДом, является наиболее достоверным симптомом ВИЧ-инфекции. Характерен молодой (до 37 лет) возраст, яркость окраски и сочность высыпных элементов. Необычна и локализация опухолей: на кончике носа и слизистых оболочках, на твердом небе и верхних конечностях. Отмечается быстрое течение заболевания с обязательным вовлечением лимфоузлов и внутренних органов.

Иммунно-супрессивный тип. Протекает, как правило, хронически и доброкачественно. Развивается после пересадки почки, после которой назначаются особые типы иммунносупрессоров. При отмене препаратов наступает регресс заболевания. Внутренние органы вовлекаются редко.

Выделяют острую, подострую и хроническую формы саркомы Капоши. Острую форму саркомы Капоши отличает быстрая генерализация процессса. Нарастающие симптомы общей интоксикации и кахексия служат причиной смерти в течение 2 мес-2 лет. Подострая форма саркомы Капоши имеет менее быстрое и не столь злокачественное течение. Длительность болезни без лечения может достигать 2-3 лет. Относительно доброкачественным течением, постепенным прогрессированием процесса отличается хроническая форма саркомы Капоши, при которой длиительность заболевания может составлять 8-10 лет и более.

63. Лимфома кожи. Клинические разновидности.

В основе болезни лежит злокачественная пролиферация лимфоцитов и плазматических клеток.

- **медленно прогрессирующие мономорфные и полиморфмные лимфомы**
- **быстро прогрессирующие лимфомы.**

Медленно прогрессирующие мономорфные лимфомы в течение многих лет или десятилетий проявляются поражением только кожи в виде экземы, парапсориаза, нейродермита и других кожных болезней. Происходит пролиферация лимфоидных клеток, выявляются лимфоциты и гистиоциты, а в дальнейшем плазматические клетки и эозинофилы. В процесс вовлекаются лимфоузлы и внутренние органы.

Различают следующие формы мономорфных лимфом:

- **трехстадийна**я – пятнистая: появляются пятна на туловище и проксимальных отделов конечностей с четкими границами, бледно-розового или коричневатого цвета с фолликулярными узелками (ощущение терки). Волосы в очагах поражения отсутствуют.

- **пятнисто-бляшечная стадия** – в очагах формируются бляшки с наличием инфильтрации. Характеризуется длительным течением со спонтанными ремиссиями.

- опухолевая – формируются опухоли с преобладанием лимфобластов и пролимфоцитов

- **пойкилодермическая** - бледно-розовые с нечеткими границами, слабо шелушащиеся очаги. Затем наступает лихенификация, выпадение волос в очагах поражения. Через десятилетия в очагах возникают плотные узелки синюшно-красного цвета, некрозы.
- **эритродермическая форма** – вначале развивается как экзема или нейродермит. Затем появляется инфильтрация, сильный зуд, выпадение волос, увеличиваются лимфатические узлы, похудение, лихорадка
- **пятнисто-инфильтративная** – на коже груди и межлопаточной области округлые пятна застойного цвета. Появляется инфильтрация и кожа становится похожей на кожу апельсина
- **узелковая форма** – на коже туловища папулы плотной консистенции без субъективных ощущений.

Полиморфмные медленно прогрессирующие лимфомы:

- **трехстадийная форма** – эритематозная, бляшечная, опухолевая стадии
- **узелковая** - локализуется чаще на голенях, вначале плоские, затем полушаровидные высыпания
- **папулы** застойно-красного цвета, заканчиваются атрофией. Болезнь заканчивается летальным исходом.

***Быстропрогрессирующие лимфомы:**

- **узелково-бляшечная:** начинается остро с появлением розово-синюшных пятен или фолликулярных папул из которых образуются опухолевидные образования, склонные к распаду и образованию глубоких язв;
- **инфильтративно-узловатая** – вызывают опухоли, которые распадаются с образованием язв
- **лимфосаркома** – одиночный безболезненный узел, быстро распадается и метастазирует в регионарные лимфоузлы
- **эритродермическая** – начинается с появления на конечностях зудящих эритем, быстро распространяющихся по кожному покрову. Зуд усиливается, кожа лихенифицируется, шелушится, выпадают волосы, появляются бляшки и узлы. **Диагностика лимфом** подтверждается результатами гистологического исследования очагов поражения.

Лечение. Витаминотерапия, гипосенсибилизирующие и антигистаминные, кортикостероидные средства. При недостаточном действии кортикостероидов назначают цитостатики, иммуномодуляторы.

64. Генодерматозы (ихтиоз, врожденный буллезный эпидермолиз). Клиника. Принципы лечения.

Генодерматозы – наследственное заболевание кожи, характеризующиеся дефектами кератинизации.

Ихтиоз – заболевание с диффузным нарушением ороговения по типу гиперкератоза. Различают ихтиоз вульгарный, Х - сцепленный, эпидермолитический, иглистый, ихтиозоформная эритродермия и др.

Вульгарный ихтиоз (аутосомно-доминантный тип наследования) проявляется сухостью, серовато-грязной окраской кожи разгибательной поверхности верхних конечностей, бедер, туловища.

Клинические формы вульгарного ихтиоза:

Ксеродермия – легкая форма ихтиоза, характеризуется отрубевидным шелушением кожи разгибательной поверхности конечностей.

Простой ихтиоз проявляется пластинчатым шелушением.

Шиповидный ихтиоз – тяжелая форма, проявляется иглоподобными плотными роговыми чешуйками.

Вульгарный сцепленный с полом ихтиоз, или х-рецессивный (чернеющий ихтиоз) проявляется на первой неделе или на 4-6 месяце жизни, максимум к 10 годам. На коже голеней, бедер, шеи, лица толстые, темного цвета чешуйки

Врожденный ихтиоз (аутосомно-рецессивный тип).

Тяжелая форма – ребенок недоношенный, кожа покрыта роговыми наслоениями, гиперемирована.

Легкая форма – диффузная эритема с кератодермией ладоней и подошв, выворотом век, деформацией ушных раковин.

Ихтиозиформная эритродермия Брока, сухая и буллезные формы. Сухая форма, или не буллезная, или ламеллярный ихтиоз, наследуется ауторецессивно, кожа гиперемирована, сухая, обильно шелушится. Чешуйки крупные, толстые, коричневого цвета. Особенно много их на ладонях, подошвах, в складках.

Буллезная форма, или эпидермический ихтиоз, наследуется по аутосомно-доминантному типу и характеризуется наличием пузырей на фоне эритродермии с отслойкой эпидермиса.

Врожденный буллезный эпидермолиз, или наследственная пузырчатка. Различают простую форму – после травматизации на видимо неизмененной коже появляются пузырьки и пузыри, симптом Никольского отрицательный, общее состояние не нарушается. В период полового созревания болезнь может самопроизвольно исчезать.

При дистрофической форме (аутосомно-доминантной) уже при рождении или в первые дни жизни на конечностях появляются пузыри, которые после себя оставляют рубцы. Симптом Никольского отрицательный.

Полидиспластическая форма (аутосомно-рецессивный тип) проявляется сразу после рождения. На коже и слизистых образуются пузыри, отсутствуют ногтевые пластинки, атрофия концевых фаланг пальцев, умственная отсталость. Симптом Никольского положительный

65. Клинические проявления на коже и слизистых при ВИЧ-инфекции.

Кожные поражения в большинстве случаев возникают на стадии вторичных клинических проявлений СПИДа. Эти СПИД-ассоциированные заболевания кожи и слизистых оболочек весьма разнообразны. Нередко наблюдаются сочетания нескольких дерматозов инфекционного и/или неинфекционного генеза. Спектр поражения кожи и слизистых оболочек при ВИЧ-инфекции чрезвычайно широкий, условно он подразделяется на три основные группы:

1. Инфекционные дерматозы: вирусные; бактериальные; грибковые; протозойные.

2. Неинфекционные дерматозы: сосудистые поражения кожи; папуло-сквамозные дерматозы; другие.

3. Неопластические поражения кожи: саркома Капоши; спиноцеллюлярные эпителиомы; В-клеточные формы.

Особенностью инфекционных дерматозов у ВИЧ-инфицированных является ассоциативность микробной флоры и ее агрессивность, дессиминированный характер поражений, тяжелое и рецидивирующее течение дерматоза, стойкость к назначаемой терапии, возможность поражений не только кожи, а и внутренних органов.

По частоте инфекционные дерматозы при СПИДе распределяются следующим образом:

1. На первое место следует поставить себорейный дерматит. Особенностью себорейного дерматита у ВИЧ-инфицированных является то, что он начинается на типичных местах, в основном на лице и волосистой части головы. При этом процесс быстро распространяется на участки верхних и нижних конечностей, туловища, а затем принимает генерализованный характер. Воспалительный процесс существенно выражен и сопровождается значительной экссудацией (мокнутием).

2. Вторым по частоте наблюдается простой пузырьковый лишай. Его особенностью у ВИЧ-инфицированных является то, что высыпания могут быть разнообразной локализации, но чаще страдает кожа кистей, ступней и аноректальных участков. Нередко возникают геморрагические высыпания в сочетании петехий с пурпурой. При этом высыпания сопровождаются резкой болезненностью. Возможно также герпетическое поражение внутренних органов. Характерна высокая резистентность к применяемой терапии и часто рецидивирующий характер в течении дерматоза..

3. Опоясывающий лишай занимает третье место по частоте регистрации. Для его клинических проявлений при ВИЧ-инфекции характерна большая вариабельность от легких локализованных форм до тяжелых диссеминированных геморрагических и язвенных форм.

4. Контагиозный моллюск является характерным для вторичной и терминальной стадий СПИДа. Часто локализуется на коже лица, шеи, волосистой части головы. Наряду с типичными блестящими полушаровидными папулами с пупковидным вдавлением, наблюдаются большие (до 1 см в диаметре) элементы высыпаний, склонные к изъязвлению.

5. Папилломо-вирусные заболевания у больных СПИДом имеют свои особенности: во-первых, к ним относятся остроконечные кондиломы, плоские бородавки, обычные бородавки и бовеноидные бородавки на гениталиях.

6. Волосатая (волосяная) лейкоплакия. На нынешнее время считается, что волосатая лейкоплакия встречается исключительно у ВИЧ-инфицированных. В ее развитии доказана роль вируса Эпштейн-Барра. Типичным является поражение краев зоны языка, при этом процесс может распространяться на всю поверхность языка и слизистую оболочку щек. Поражения представлены нитевидными разрастаниями эпителия слизистой оболочки, которая имеет вид поверхности, покрытой волосками. Очаги поражения не имеют четкой границы и напоминают "гофрированную" поверхность. Субъективные ощущения отсутствуют.

7. Кандидоз слизистых оболочек и кожи также имеет свое своеобразное течение. Стойкий кандидоз, особенно слизистой оболочки ротовой полости и перианальной области, относится к ранним проявлениям ВИЧ-инфекции и встречается у большей части инфицированных. Особенностями кандидоза у ВИЧ-инфицированных является комбинированное (генерализованное) поражение слизистой полости рта, пищевода, кандидозный хейлит, заеды и дрожжевая опрелость больших складок. Нередко наблюдается сочетание грибковых и вирусных поражений.

8. Глубокие микозы. Из всех глубоких микозов у ВИЧ-инфицированных чаще встречается критпококкоз и гистоплазмозГистоплазмоз кожи характеризуется неспецифическими проявлениями на коже — пятнисто-папулезные, папуло-некротические высыпания, в том числе в перианальной области. Возбудителем заболевания является Histoplasma, которая выявляется при помощи бактериологических и бактериоскопических исследований.

9. Бактериальные инфекции. У ВИЧ-инфицированных чаще всего встречаются стафилококковые и стрептококковые пиодермиты. Особенностями их проявлений и течения являются диссеминированный характер поражения, необычная клиническая картина поражения, обусловленная комбинацией нескольких возбудителей (стафилококк золотистый, стрептококк, вирус герпеса, цитомегаловирус; атипичные микробактерии и др.), торпидность к терапии и частые рецидивы.

66. Течение нелеченного сифилиса.

Пути заражения: половой, бытовой (через предметы обихода - стаканы, ложки, губная помада, докуривание сигарет и т.д.), сексуальных поцелуях, трансфузионный, трансплацентарный.

Инкубационный период в среднем равен одному месяцу. Однако может удлиняться до 2-6 месяцев при приеме антибиотиков, в старческом возрасте, у алкоголиков, наркоманов, токсикоманов, при хронических заболеваниях. Укорочение до 1-2 недель может быть у молодых физически здоровых лиц, при биполярных и множественных шанкрах.

Первичный период сифилиса (lues primaria) начинается с момента появления твердого шанкра и длится в течение 6-8 недель. Делится на серонегативный - первые 3-4 недели наличия твердого шанкра, когда реакция Вассермана (RW) отрицательная, и серопозитивный, когда RW становится положительной.

Вторичный период сифилиса (lues secundaria) наступает через 6-8 недель от появления твердого шанкра или через 10-12 недель после предполагаемого заражения. Общая продолжительность вторичного периода может быть до 5 лет. В этом периоде на коже и слизистых появляются высыпания в виде пятен, папул, пустул, образуются очаги облысения (алопеция) и лейкодерма. Течение вторичного периода сифилиса волнообразное и подразделяется на: свежий (lues II recens), скрытый (lues latens), рецидивный (lues II recidiva).

Во вторичном периоде происходит генерализация сифилитического процесса, поражаются не только кожа и слизистые, но также все органы и системы. Считается самым заразным, опасным для окружающих больных лиц.

Третичный период (lues tertiaria) может наступить сразу после вторичного периода, или через десятки лет после него. Продолжительность периода до 10 и более лет. Течение волнообразное, подразделяется на активный и скрытый. Проявляется наличием на коже и слизистых бугорков, гумм и третичной розеолы Фурнье. Третичный период считается мало заразным, не представляет опасность для окружающих. Опасен для самого больного, так как поражение внутренних органов и систем носит органический, деструктивный характер.

Инкубационный период — первичный период – вторичный период – третичный период — поздние формы сифилиса (нейро-и висцеросифилис).

 2. Длительно бессимптомное течение — скрытый поздний сифилис — поздние формы сифилиса (нейро- и висцеросифилис).

 3. Инкубационный период — первичный период — вторичный период — случаи самоизлечения.

Нелеченный сифилис может длиться годами, чередуя периоды обострений и скрытого (латентного) течения. В активный период сыпь проявляется на коже, слизистых оболочках и внутренних органах, в скрытый период практически ничем не проявляется. Сыпь менее обильная, более крупная и располагается группами, образуя дуги, кольца, гирлянды и полукольца.

Нелеченный сифилис вовлекает в процесс печень, что приводит к возникновению желтой атрофии печени (выраженная желтуха, уменьшение размеров печени, увеличение селезенки, судороги и галлюцинации вплоть до развития печеночной комы).

Вызывает тяжёлое поражение ЦНС, ССС и костной системы. Может стать причиной врождённой глухоты и различных уродств.

Нелеченный сифилис в половине случаев приводит к мертворождению, недонашиванию или смерти новорожденного. Ещё в половине случаев имеется врожденный сифилис.

В большинстве случаев - до 70% нелеченный сифилис далее переходит либо в длительно протекающую форму скрытого позднего сифилиса, либо возникают специфические очаги (гуммы) - третичный сифилис (Syphili tertiary) либо происходит самоизлечение

67. Общая характеристика возбудителя сифилиса. Электронно- микроскопическое строение спирохеты.

- Бледная трепонема представляет собой спираль из 8-14 завитков, на концах которых имеются блефаробласты, от которых отходит 3-6 и более фибрилл.
- Наружная стенка спирохеты состоит из 2-х электронно - плотных листков диаметром около 25 А, разделенных электронно - прозрачным слоем диаметром около 30 А, которая предохраняет спирохету от воздействия антител, антибиотиков и других вредных факторов. Имеющаяся цитоплазматическая мембрана участвует в процессах метаболизма клетки, ее делении и спорообразовании.
- В скрытом периоде болезни спирохета находится в виде цист или L – форм.
- Различают 4 вида движения: маятникообразное, поступательное, вращательное (вокруг оси), волнообразное.
- Размножение происходит путем поперечного деления.
- Спирохета малоустойчива к внешним воздействиям.
- При температуре 50-600С погибает через 15-20 минут, губительным является высыхание. В крови сохраняется от 2 до 5 дней.
- Во внешней среде и при низкой температуре сохраняется месяцами. Дезинфицирующие средства быстро убивают спирохету
- Плохо окрашивается анилиновыми красителями ввиду наличия большого числа гидрофобных компонентов в цитоплазме, окрашивается в бледно-розовый цвет по методу Романовского-Гимзе, применяют также методы протравления и импрегнации серебром.
- Неокрашенные нефиксированные клетки не видны в световой микроскоп , для визуализации тепеонем в живом состоянии используют метод темнопольной микроскопии.

Известно 4 подвида Т ./ pallidum

- T. pallidum pallidum- сифилис
- T. pallidum pertenue- фрамбезия
- T. pallidum carateum- пинта
- T. pallidum endemicum- беджель

68. Условия и способы заражения сифилисом. Пути распространения инфекции в организме.

Источник заражения:

- Больной человек
- Наиболее заразителен больной в первые 2 года болезни
- Больные с поздними формами сифилитической инфекции малоконтагиозны

Пути передачи инфекции:

- П**рямой** (половой, бытовой (через предметы обихода - стаканы, ложки, губная помада, докуривание сигарет и т.д.), сексуальных поцелуях, трансфузионный, трансплацентарный.
- **Непрямой** (через различные предметы, загрязненные грязными трепонемами.

Самыми заразными являются больные первичным и вторичным сифилисом, имеющие эрозивный или язвенный шанкр, эрозивные мацерированные или мокнущие папулы, особенно в складках кожи и на слизистой полости рта. Сперма и грудное молоко заразны даже при отсутствии проявлений болезни в области половых органов и молочных желез . Гуммы и бугорки третичного сифилиса практически не заразны. Пот и моча не заразны.

Пути распространения инфекции: после внедрения возбудителя в кожу или слизистую оболочку они начинают интенсивно размножаться в месте внедрения и распространяться по лимфатическим и кровеносным сосудам во все органы и ткани. Возможен и периневральный путь распространения трепонем . Принцип и сроки личной профилактики после случайной связи, заключается в обрабботке половых органов дезинфицирующими растворами в течение 2 часов после половой связи.

69. Иммунитет при сифилисе. Реинфекция, суперинфекция.

- Истинный иммунитет отсутствует.
- У больных развивается нестерильный или инфекционный иммунитет, который сохраняется на время нахождения возбудителя в организме больного.
- Максимальной активности он достигает во вторичном периоде.
- В ответ на присутствие трепонем выделяются антитела- иммуноглобулины(A,M,G).В реализации иммунного ответа организма на внедрение трепонемы участвуют макрофаги, Т- и В- лимфоциты.
- Наличие в организме антигена приводит к иммунобиологическим реакциям, вследствие чего часть трепонем погибает – наступает скрытый период вторичного сифилиса
- Процесс поглощения трепонемы мононуклеарными фагоцитами делится на стадии:
  - стадию сближения фагоцита и трепонемы
  - стадию прилипания
  - стадию погружения трепонемы в протоплазму фагоцита
  - стадия переваривания
- Массовое размножение и распространение происходит в начале первичного и в начале вторичного сифилиса
- Наступает спирохетовый сепсис, который сопровождается нередко температурой, слабостью, недомаганием, болями в костях и суставах полиаденит
- Наличие в организме антигена приводит к иммуннологическим реакциям, вслдествие чего трепонема погибает – наступает скрытый период вторичного сифилиса.
- **Суперинфекция**- это повторное поступление в организм уже больногоо человека дополнительного количества возбудителей сифилиса
  - В инкубационном периоде и на начальном этапе первичного сифилиса когда еще инфеционный иммунитет не успел сформироваться, повторное заражение приводит к последовательному развитию новых шанкров.
  - В других стадиях сифилиса при суперинфекции организм отвечает на новое заражение высыпаниями этой стадии в которой находится больной.
  - Однако в третичном сифилисе когда трепонемы очень мало в организмесуперинфекция приводит в козникновению новых шанкров или симптомов вторичного сифилиса.
- **Реинфекция**- у человека ранее болевшего сифилисом и излеченного, не развивается приобретенный иммунитет и поэтому от заражается заново.
- **Критерии реинфекции**
  1. **Достоверность первого заражения**
  2. **Полноценность лечения по поводу первогоо заражения**
  3. **Полная негативация серореакций**
  4. **Выявление нового источника заражения**
  5. **Классическое течение сифилиса в результате повторного зараения**
  6. **Обнаружение бледных трепонем на поверхности нового твердого шанкра.**

70. Клиника первичного периода сифилиса. Дифференциальный диагноз.

Первичный период сифилиса (lues primaria) начинается с момента появления твердого шанкра и длится в течение 6-8 недель. Делится на серонегативный - первые 3-4 недели наличия твердого шанкра, когда реакция Вассермана (RW) отрицательная, и серопозитивный, когда RW становится положительной.

Первичный период проявляется твердым шанкром, лимфангитом, регионарным лимфаденитом, полиаденитом.

Твердый шанкр (ulcus durum) появляется на месте внедрения спирохеты, бывает в виде эрозии или язвы.

Типичный твердый шанкр характеризуется:

- правильным круглым или овальным очертанием
- четкими границами
- отсутствием перифокального воспаления
- плотно - эластической консистенцией у основания эрозии или язвы, не выходящей за пределы дефекта
- гладким, блестящим дном
- блюдцеобразной формой
- безболезненностью, (анестезирующий эффект на нервыные окончания)за исключением при локализации в мочеиспускательном канале, в анальной области.

Разновидности твердых шанкров:

По виду дефекта: эрозивный, язвенный.

По числу шанкров: одиночный, множественный.

По размерам: классический, карликовый(меньше 3 см), гигантский (более 3 см)

По локализации: генитальный, экстрагенитальный, биполярный.

При расположении твердых шанкров на соприкасающихсяповерхностях могут наблюдаться шанкры-отпечатки.

Дифференциальная диагностика твердого шанкра.

Пузырьковый лишай (herpes simplex)

Пузырьки возникают на гиперемированном основании и через 3-4 дня вскрываются

Образуется эрозия, которая отличается от твердого шанкра:

- полициклическими очертаниями
- отсутствием плотного инфильтрата у основания
- острым течением
- быстрым заживлением
- субъективно - зуд, жжение, болезненность
- отсутствие регионарного лимфаденита
- отрицательными результатами лабораторных исследований на бледную трепонему, отрицательными серореакциями.

71. Осложнения твердого шанкра.

Фимоз – невозможность открыть головку полового члена. Возникает вследствие повреждения лимфатических коллекторов и развития лимфостаза. При наличии фимоза нельзя принудительно пытаться обнажить головку полового члена из-за опасности ее ущемления.

Парафимоз - невозможность закрыть головку полового члена вследствие еѐ ущемления суженным

препуциальным кольцом. Вправление головки полового члена может быть весьма затруднительным из-за выраженного отѐка и болезненности. Нарастание сдавления в области венечной борозды может привести к трофическим нарушениям тканей головки полового и потребовать оперативного вмешательства.

Гангренизация- возникает глубокий некроз всей или части поверхности шанкра. Наблюдается на фоне сахарного диабета, выраженного иммунодефицита. Цвет – серо-бурый или чѐрный. После отторжения некротических масс обнажается язвенный дефект с гнойно-геморрагическим отделяемым, который постепенно заполняется грануляционной тканью.

Фагеденизация –гнойное расплавление тканей (их «поедание»). Причина – присоединение стафилококковой, стрептококковой, фузоспирилѐзной инфекции. Очаг некроза распространяется по периферии, и в результате возникает глубокая гнойная с неправильными очертаниями язва. Иногда процесс осложняется кровотечениями.

Вторичное инфицирование твѐрдого шанкра пиогенной микрофлорой - характерно появление гнойного отделяемого, формирование на поверхности шанкра гнойных или серозно- гнойных корок. Вокруг сифиломы возникает воспалительный ободок, усиливаются периферическая инфильтрация, явления лимфангоита и лимфаденита, появляется и усиливается болезненность.

Облигатный физический(химический) дерматит – возникает, как правило, вследствие самолечения пациентов: прижигания (даже окурками сигарет), смазывания агрессивными химическими препаратами (кислоты, щѐлочи и т.п.), ванночек с нерастворѐнными кристаллами перманганата калия и т.д.

72. Твердый шанкр. Дифференциальная диагностика.

- Классический твѐрдый шанкр представляет собой эрозию или язву с округлыми или овальными очертаниями, блюдцеобразной формы, с чѐткими ровными краями, находящимися на уровне окружающих тканей или слегка приподнятыми над ними.
- Дно – гладкое, блестящее, «лакированное», розово- красного, мясо-красного или желтовато-розового цвета.
- На поверхности первичной сифиломы, как правило, имеется лимфоидное отделяемое – серум, в котором содержится большое количество бледных трепонем.
- Возбудителя всегда больше в отделяемом эрозивных шанкров, по сравнению с язвенными; в периферической зоне по сравнению с центральной.
- Характерно отсутствие островоспалительных явлений в окружающих тканях.
- Шанкр безболезненный – анестезирующий эффект бледной трепонемы на нервные окончания в области шанкра.
- При пальпации в основании определяется инфильтрат хрящевидной плотности.
- Заживают шанкры без лечения обычно через 4-6 недель, оставляя после себя рубчик («печать дьявола») если он был в виде язвы, или бесследно – если в виде эрозии.
- Разновидности твёрдых шанкров:
    1. По виду дефекта: эрозивный, язвенный.
    2. По числу шанкров: одиночный, множественные
    3. По размерам: классический (типичный, стандартный); карликовый – 1-3 мм в диаметре; гигантский – более 3 см в диаметре.
    4. По локализации: генитальный; экстрагенитальный, биполярный
- При расположении твѐрдых шанкров на соприкасающихся поверхностях могут наблюдаться шанкры-отпечатки («целующиеся» шанкры), возникающие за счѐт аутоинокуляции бледных трепонем в прилегающую зону.
- При наличии у пациента генитальных и экстрагенитальных шанкров говорят о биполярных твѐрдых шанкрах.
- Дифференциальная диагностика
    1. твердого шанкра
    2. Пузырьковый лишай
    3. Мягкий шанкр
    4. Эрозивный баланит и баланопостит
    5. Шанкриформная пиодермия
    6. Чесоточная эктима
    7. Гонококковые и трихомонадные язвы
    8. Туберкулезная язва
    9. Карцинома кожи
    10. Эритроплазия Кейра
    11. Острая язва вульвы
    12. Эрозии, вследствие травм

73. Атипичные твердые шанкры.

Кроме классических (типичных) выделяют атипичные твёрдые шанкры. Атипичными они называются не по своему расположению, а по клиническим проявлениям.

- Шанкр индуративный отѐк – представляет собой выраженный безболезненный плотный лимфатический отѐк тканей с богато развитой лимфатической сетью: препуциального мешка, мошонки у мужчин и больших и малых половых губ у женщин. Островоспалительных изменений нет. Углубления после надавливания не остаѐтся. Цвет очага может быть телесным, но чаще – застойно-красный.
- Шанкр-амигдалит – одностороннее увеличение нѐбной миндалины без дефектов, гнойных пробок на еѐ поверхности. Миндалина безболезненна. В отличие от банальной ангины отсутствуют островоспалительные явления, лихорадка, выраженное нарушение общего состояния пациентов. Характерен односторонний специфический подчелюстной и шейный лимфадентит.
- Шанкр-панариций – возникает на пальцах кистей на местах микротравм, царапин, заусениц в результате проникновения через них возбудителя сифилиса при контакте с острозаразными высыпаниями больного человека (источника заражения) во время секса, или при выполнении профессиональных манипуляций (медицинские работники). Характерно увеличение кубитальных лимфатических узлов на стороне поражения.
- Эрозивный баланит (баланопостит) Фольмана – возникают поверхностные эрозии с полициклическими, иногда географическими, очертаниями. Поверхность эрозий гладкая, блестящая, выглядит лакированной из-за обильного серума. Элементы склонны к слиянию, но весьма характерно наличие островков здоровой кожи между ними. В отличие от типичных шанкров при данной разновидности первичной сифиломы практически нет уплотнения в основании шанкра.

74. Клинические проявления регионарного лимфаденита при сифилисе.

- Развивается через 7-10 дней после возникновения шанкра) Бывает односторонним (чаще на стороне поражения, но может быть и перекрѐстным или двухсторонним.
- При расположении шанкра на наружных половых органах вовлекаются паховые лимфатические узлы; на шейке матки, слизистой прямой кишки далее 4-5 см от наружного сфинктера – тазовые; на слизистой полости рта – подчелюстные, шейные; на пальцах кистей – кубитальные

Регионарный лимфаденит

- плеяда Рикора – ближайший к очагу лимфатический узел более крупный, по мере удаления – меньше.
- Лимфатические узлы при сифилисе плотные, безболезненные, подвижные, не спаянные между собой и окружающими тканями.
  Регионарный лимфангит
- Воспаление лимфатических сосудов на протяжении от твѐрдого шанкра до регионарных лимфатических узлов.
- При расположении шанкра на головке полового члена, в области венечной борозды данный симптом определяется пальпацией в виде плотных безболезненных тяжей на спинке полового члена (дорсальный лимфангит).
- Через 3 недели после возникновения твѐрдого шанкра вследствие распространения возбудителя по лимфатической системе может возникнуть системная гиперплазия лимфатических узлов или полиаденит

75. Поражение кожи при вторичном периоде сифилиса.

- Развивается вследствие гематогенной диссеминации возбудителя, который попадает в кровь из лимфатической системы. Наблюдается транзиторная спирохеттемия. Бледные трепонемы оседают на сосудистой стенке, тканях и органах, в том числе на коже и слизистой оболочке.
- **Розеолѐзная сыпь:**
    1. Представляет собой сосудистые пятна диаметром 0,5-1 см с нерезкими очертаниями, округлой или овальной формы, не шелушащиеся и не возвышающиеся над уровнем окружающей кожи.
    2. Цвет на начальном этапе – розово-красный или красный, при регрессе и на более поздних этапах сифилитической инфекции – бледно-розовый.
    3. Исчезает при надавливании.

Разновидности сифилитической розеолы: возвышающаяся (элевирующая, уртикарная, экссудативная), шелушащаяся, фолликулярная (зернистая, точечная),сливная розеола.

Дифференциальная диагностика розеолезной сыпи: следует дифференцировать с розовым лишаем, крапивницей, разноцветным лишаем, токсикодермией, корью, скарлатиной, краснухой, сыпным и брюшным тифом, укусами насекомых и др.

Папулѐзный сифилид: разновидность папул

- милиарные – диаметр 0,1-0,2 мм;
- лентикулярные – диаметр 0,3-0,9 мм;
- нумулярные (монетовидные) – диаметр 1-3 см;
- бляшковидные (бляшки) – диаметр более 3 см.

Клиника папулезного сифилида

Папулы обычно плотно-эластической консистенции, плоской или полушаровидной формы, возвышаются над уровнем окружающих тканей. Цвет сначала розово-красный, позднее – синюшно-красный. Может появляться шелушение, причѐм в центре папул оно быстро прекращается, что приводит к формированию довольно типичного для сифилиса симптома – ободка периферического шелушения вокруг папул или «воротничка Биетта».

Если папулы возникают как проявление первой манифестации вторичного периода сифилиса, то они располагаются симметрично или беспорядочно на любом участке тела больного. Размеры обычно небольшие (милиарные и лентикулярные папулы). Элементы не склонны к слиянию, группировке и периферическому росту.

Клинические разновидности сифилитических папул: себорейные папулы, псориазиформные папулы, кокардный папулѐзный сифилид, бризантный (коримбиформный) папулѐзный сифилид, эрозивные, мацерированыые папулы, широкие кондиломы (вегетирующие папулы),ладонно-подошвенный папулѐзный сифилид.

Дифференциальная диагностика папулезного сифилида: Псориаз, Парапсориаз,Красный плоский лишай, Вегетирующая пузырчатка,Остроконечные кондиломы и др.

Пустулѐзная сыпь: разновидности: импетигинозный сифилид, угревидный (акнеиформный) сифилид, оспенновидный сифилид, сифилитическая эктима, сифилитическая рупия.

Дифференциальная диагностика пустулезного сифилида: вульгарное импетиго, вульгарная эктима, угри,ветряная оспа и др.

76. Сравнительная характеристика клинических проявлений свежего и рецидивного вторичного сифилиса.

Вторичный свежий сифилис.

Развивается вследствие гематогенной диссеминации возбудителя, который попадает в кровь из лимфатической системы. Бледные трепонемы оседают на сосудистой стенке, тканях и органах, в том числе на коже и слизистой оболочке.

разновидности высыпаний: пятнистые высыпания; папулёзные высыпания; пустулёзные высыпания; нарушения пигментации; выпадения волос. постепенное развитие, без существенных субъективных ощущений; расположение на любом участке кожи и слизистой оболочки; волнообразность течения: периоды наличия высыпаний сменяются периодами их отсутствия; доброкачественность – регресс элементов без разрушения кожи и слизистой оболочки; полиморфизм высыпаний; высокая заразительность эрозивных, мацерированных и язвенных элементов сыпи; склонность с спонтанному разрешению проявлений на коже и слизистой оболочке.

У 60-80% пациентов наряду с высыпаниями вторичного периода сифилиса выявляются эпителизирующийся (рубцующийся) твёрдый шанкр или его следы (вторичное пигментное пятно, свежий рубчик), а также регионарный лимфаденит.

Особенности вторичного свежего сифилиса: обильность элементов сыпи;

симметричность их расположения; яркость высыпаний, цвет – розово-красный, красный; размеры – мелкие; элементы сыпи не склонны к слиянию и группировке.

Сифилис вторичный рецидивный. Дифференциальная диагностика.

- уменьшение количества элементов сыпи с каждым рецидивом;
- увеличение размеров высыпаний (иногда за счѐт их периферического роста);
- склонность сифилидов к слиянию и группировке (в ряде случаев с образованием разнообразных фигур);
- преимущественная локализация сыпи – в места давления, трения, мацерации.

.

Клинические разновидности папулёзного сифилида:

*себорейныйе *псориазиформные *эрозивные *широкие кандиломы *ладонно-подошвенный.

Дифф: псориаз, парапсориаз, КПЛ, вегетирующая пузырчатка, кандиломы.

77. Поражение слизистых при вторичном периоде сифилиса.

Поражения слизистой оболочки полости рта при вторичном сифилисе

Проявляется в основном пятнистыми и (или) папулёзными высыпаниями. Сифилиды слизистой полости рта имеют важное эпидемиологическое значение ввиду высокой заразительности.

Разновидности поражений слизистых полости рта

сифилитический ларингит

папулёзые сифилиды слизистой языка, щёк, нёба отличаются разнообразием проявлений. Выделяют:

«лоснящеся» папулы или феномен «скошенного луга»;гипертрофичекие папулы; «опаловые» папулы ; сифилитическая заеда; сифилитическая ангина; катаральная (эритематозная) сифилитическая ангина; папулёзная сифилитическая ангина. Поражения слизистой оболочки полости рта следует дифференцировать с афтозным стоматитом, красным плоским лишаем, пузырчаткой, ангиной и др.

Разновидности поражений слизистых полости рта

- сифилитическая ангина
  - катаральная (эритематозная)
  - сифилитическая ангина
- папулѐзная сифилитическая ангина

Поражения слизистой оболочки полости рта следует дифференцировать с афтозным стоматитом, красным плоским лишаем, пузырчаткой, ангиной и др.

78. Сифилитическая алопеция и лейкодерма.

алопеция Чаще локализуется на коже теменной и височных областей. Процесс возникает и прогрессирует довольно быстро.

Разновидности сифилитического облысения (алопеции)

- **мелкоочаговая алопеция** – характеризуется появлением множества мелких очагов выпадения волос. Выпадают не все волосы в очагах. Из-за этого волосистая часть головы становится похожа на «мех, изъеденный молью». Кроме волосистой части головы мелкие очаги выпадения волос могут быть в области бровей (латеральное поражение бровей); ресниц (из-за частичного выпадения и последующего отрастания они имеют различную длину, напоминают ступеньки) – признак Пинкуса.
- **диффузная алопеция** в течение короткого промежутка времени возникает общее поредение волос без других субъективных и объективных симптомов. Выпадать могут волосы на любом участке тела, включая пушковые.
- **смешанная форма** сифилитической алопеции - у одного и того же больного сифилисом могут наблюдаться обе формы выпадения волос. Под влиянием лечения выпадение волос прекращается в течение 1-5 дней, а спустя 1,5-2 месяца волосы полностью восстанавливаются.

Сифилитическая лейкодерма:

Типичная локализация – заднебоковые поверхности шеи, поэтому иначе данный сифилид называют «ожерельем Венеры».

Участки гипопигментации чередуются с гиперпигментированными пятнами. В зависимости от соотношения указанных участков различают следующие формы сифилитической лейкодермы:

пятнистая; сетчатая; мраморная.

Продолжительность наличия высыпаний – 6 и более месяцев, затем цвет кожи восстанавливается.

Её развитие может быть связано с длительным воздействием токсинов бледных трепонем на симпатические шейные ганглии, что приводит к нарушению регуляции меланиногенеза.

79. Скрытый сифилис: классификация. Злокачественный сифилис (клинические проявления). Трансфузионный сифилис.

1). Ранний - давность инфицирования не более 2 лет

2). Поздний - инфицирование более 2 лет. Менее опасен, чем ранний, т.к. он может проявляться поражением ЦНС, внутренних органов. Показана пункция спинного мозга, чтобы посмотреть возбудителя в ликворе.

3). Неуточненный - дату инфицирования установить не удается.

Злокачественный сифилис - редкая форма вторичного сифилиса. Изредка она возникает как рецидив на 5-6 мес болезни. Особенностью клинических проявлений злокачественного сифилиса является сравнительно частая склонность твердого шанкра к некрозу и периферическому росту, сокращение первичного периода до 3-4 нед, преобладание на коже и слизистых пятнистых, папулезных, пустулезных сифилоидов. Высыпания на слизистых склонны к изъязвлению. Специфический полиаденит отсутствует. Серологические реакции на сифилис иногда бывают отрицательны.

Для злокачественного сифилиса характерны нарушения общего состояния больного, длительная лихорадка, интоксикация. У нелеченных больных в течение многих месяцев патологический процесс не имеет склонности переходить в скрытое состояние, рецидивы заболевания возникают один за другим, почти без латентных периодов.

Тяжелое течение злокачественного сифилиса связывают с резким снижением защитных сил организма под влиянием общих заболеваний интоксикаций, алкоголизма. Возможно так же, что у больных злокачественным сифилисом имеется гиперергическая реакция на бледную трепонему.

80. Клинические проявления третичного периода сифилиса.

Третичный сифилис развивается не ранее 3-5 лет после заражения.

Переходу сифилитической инфекции в третичный период способствуют:

- отсутствие или неполноценное лечение ранних форм сифилиса;
- острые и хронические заболевания, сопровождающиеся первичным и вторичным иммунодефицитом (туберкулѐз, гепатиты и т.д.);
- хронические интоксикации (алкоголизм, наркомания, токсикомания), в том числе – промышленные;
- хронические авитаминозы;
- пожилой возраст пациентов;
- физические и психические травмы: сифилиды при третичном сифилисе чаще возникают в местах ударов, ожогов.

Общие особенности третичного периода сифилиса:

- локализация высыпаний на ограниченных участках кожи или слизистой оболочки;
- сифилиды характеризуются образованием глубокого инфекционного инфильтрата плотноэластической консистенции, представляющего собой инфекционную гранулему, располагающуюся в дерме (бугорки) или в подкожной клетчатке (гуммы);
- третичные сифилиды развиваются медленно, не имеют признаков острого воспаления и обычно не сопровождаются субъективными ощущениями. Длительность активных проявлений на коже и слизистых – до 1,5 лет;
- склонность сифилидов к изъязвлению с образованием в исходе рубца или разрешению малозаразительность высыпаний (бледные трепонемы обнаруживаются с большим трудом и в незначительном количестве);
- наряду с проявлениями на коже и слизистой оболочке часто имеет место поражение и внутренних органов, двигательного аппарата, центральной нервной системы;
- при развитии объѐмных процессов в головном или спинном мозге (гуммы) возможно злокачественное течение заболевания;
- –стандартные серологические реакции у больных третичным сифилисом бывают положительными у 50-70% больных, РИФ и РИБТ – у 100%;
- –сравнительно быстрое разрешение третичных сифилидов под влиянием специфического лечения.сухим путѐм с формированием участка рубцовой атрофии;

81. Гуммозный сифилид, клинические разновидности, исход, дифференциальный диагноз.

- Сначала представляет собой безболезненный узел размером до лесного ореха, плотно-эластичной консистенции, подвижный, не спаянный с окружающими тканями и кожей. Кожа над узлом не изменена, а сам он располагается глубоко в подкожной жировой клетчатке, реже в мышце или в кости. Вскоре узел увеличивается в размерах до куриного яйца, теряет подвижность, спаивается с окружающими тканями, приподнимает кожу, которая над гуммой становится синюшно-красной, багровой. В центре появляется размягчение, флюктуация, гумма вскрывается с выходом через свищевое отверстие ничтожно малого количества (1-2 капли) вязкого кровянистого отделяемого.
- Постепенно формируется кратерообразная язва с омозолелыми краями, дно которой представлено гуммозным стержнем (масса омертвевшего инфильтрата, некротический распад с неприятным запахом). По мере отхождения стержня язва заполняется грануляциями. После заживления дефекта формируется звёздчатый рубец.
- Субъективные ощущения зависят от локализации: от полного отсутствия до сильных болей (если гумма давит на нервное сплетение).
- Локализация гумм на ранее поврежденных участках (голени, лицо; слизистая полости рта – у любителей очень горячей пищи и т.д.).

<u>Разновидности гуммозного сифилида:</u>

- гуммозные инфильтрации
- "площадкой".

Дифференциальная диагностика гуммозного сифилида:

- липома
- раковая язва
- твердый шанкр
- глубокий бластомикоз
- актиномикоз
- кожный лейшманиоз
- скрофулодерма
- язвенный туберкулез кожи

82. Бугорковый сифилид, клинические разновидности, дифференциальный диагноз.

Бугорковый сифилид – элементы сыпи полушаровидной формы, размером до горошины. Эволюция бугорков может идти двумя путями: через изъязвление с последующим образованием мозаичного рубца или сухим путём с формированием рубцовой атрофии.

Разновидности бугоркового сифилида:

*сгруппированный *серпигинирующий (ползучий)* карликовый

*бугорковый сифилид площадкой (диффузный бугорковый сифилид) .

Дифференциальная диагностика бугоркового сифилида:

- туберкулезная волчанка
- красные (розовые) угри
- лепра (туберкулоидный тип)
- саркоидоз
- базалиома.

83. Сифилис костной системы.

Для сифилиса, в отличие от туберкулеза, характерно преобладание остеосклероза над остеопорозом, что является важным диагностическим признаком при рентгенологическом исследовании. Ограниченные гуммозные узлы и диффузные инфильтрации могут поражать любые кости, но чаще всего страдают большеберцовые кости, реже — кости предплечий, ключиц, черепа. Основными клиническими формами позднего сифилиса костей являются ограниченные и диффузные гуммозные остеопериоститы и гуммозный остеомиелит.

•При ограниченном гуммозном остеопериостите в корковом слое кости появляются одиночные или множественные гуммы, которые могут распространяться как снаружи, так и в глубь кости. Клинически это выражается появлением на поверхности кости плотной на ощупь, ограниченной припухлости, значительно возвышающейся над ее уровнем. Больные жалуются на сильную боль в кости, усиливающуюся по ночам и при поколачивании по участку поражения. В дальнейшем гуммозный остеопериостит может рассосаться, подвергнуться замещению соединительной тканью и оссификации, либо он распадается с образованием типичной глубокой гуммозной язвы.

•Гуммозная язва отличается глубиной, неровным, покрытым серовато-желтым плотным налетом дном. Она окружена валом плотного инфильтрата. При ощупывании дна такой язвы зондом ощущается неровная, шероховатая поверхность некротизированной кости. По заживлении остается втянутый спаянный с костью рубец, окруженный костным валиком. На рентгенограммах в начальном периоде видны ограниченные периостальные наслоения и утолщение коркового слоя кости. В более поздних стадиях развития периостита в центре пораженного участка обнаруживается ограниченный остеопороз в виде нежного пятна, окруженного зоной реактивного остеосклероза, дающего на рентгенограмме отчетливое просветление.

84. Поражение внутренних органов, нервной системы и опорно- двигательного аппарата при сифилисе.

Сифилитические поражения нервной системы обычно условно делятся на ранний нейросифилис (до 5 лет с момента заражения) и поздний нейросифилис. По симптоматике же различаются мезодермальный нейросифилис, для которого характерно поражение мозговых оболочек и сосудов, и эктодермальный нейросифилис, протекающий в виде спинной сухотки, прогрессивного паралича, амиотрофического сифилиса.

Среди поздних висцеральных поражений ведущее место принадлежит сердечно-сосудистой системе(90-94% случаев); у 4-6% больных поражается печень. Во всех случаях поздней висцеральной патологии во внутренних органах образуются ограниченные гуммозные узлы. Из поражений сердечно-сосудистой системы встречаются специфические миокардиты, аортиты и изменения коронарных сосудов. Наиболее распространенная патология – это сифилитический аортит, а в дальнейшем сопровождается осложнениями – аневризмой аорты, недостаточностью аортальных клапанов и (или) стенозом устьев коронарных артерий, которые и определяют клиническую картину заболевания. Исходом аневризмы аорты может быть ее разрыв и

мгновенная смерть больного.

Сифилитические гепатиты и гепатоспленитиы, зачастую сопровождаются желтухой. Поражения желудка могут давать симптоматику по типу хронического гастрита, язвы желудка или рака.

Поражения легких могут проявляться в виде интерстициальной пневмонии или очагового процесса, который приходится дифференцировать с раком и туберкулезом.

Сифилитические изменения почек представляются в виде амилоидоза, нефросклероза или изолированных гумм.

Поражения других органов встречаются чрезвычайно редко.

К поздним проявлениям патологии опорно-двигательного аппарата относятся артропатия и гуммозные поражения костей и суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, а так же тела позвонков). Характерны деформации суставов и значительные разрушения костной ткани при хорошем самочувствии больного и сохранении функции суставов. Если гумма прорастает всю толщину кости и достигает костного мозга — развивается остеомиелит. В этот период наблюдается усиление болей и появляются признаки воспалительного процесса — общее недомогание, лихорадка. Артриты на фоне сифилиса характеризуются интенсивными болями в области крупных суставов. Коленные, локтевые и голеностопные суставы деформированы и воспалены. После такого воспаления часто развивается инвалидность.

Установление данного диагноза в венерологии считается наиболее сложным и очень ответственным и не должно производиться без подтверждения РИФ и РПГА (иногда такие исследования осуществляют повторно с перерывом в несколько месяцев, а также после санации о При аортите формируется воспалительный процесс в средней и восходящей части аорты. После этого происходит расширение её полости и деформация стенки сосуда. Серьёзным и жизнеугрожающим осложнением сифилиса является аневризма — истончение и расслоение сосудистой стенки, способное привести к разрыву аорты. Миокардит на фоне сифилиса не отличается от миокардитов другого происхождения. Больного беспокоит одышка, ощущение перебоев в работе сердца, периодические боли за грудиной. При осмотре можно обнаружить расширение левой границы сердца и приглушение сердечных тонов.

85. Ранний врожденный сифилис: сифилис плода, грудного возраста, раннего детского возраста (от 1 года до 2-х лет). Клиника. Диагностика.

Сифилис плода - малый вес, кожа мацерированная, морщинистая, дряблая. Подкожно-жировая клетчатка недоразвита, увеличение массы плаценты по отношению к плоду 1:3 (в норме 1:6). Поражаются внутренние органы (увеличение печени и селезенки, милиарные сифиломы печени, "белая пневмония"), специфические остеохондриты и остеопериоститы.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА

- выкидыши (чаще на 12-16-й неделе): ранние (до 12 недель) и поздние (до 22 недель);
- преждевременные роды (в сроке 22-36 недель беременности);
- мертворождения;
- рождение детей с ранними проявлениями врожденного сифилиса;
- рождение детей без внешних сифилитических инфекций со стойко положительными серологическими реакциями, у которых в последующем появляются признаки позднего врожденного сифилиса (если лечение не проводится) или наступает выздоровление (при адекватном лечении);
- рождение здоровых детей (редко).

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ СИФИЛИСА ИЗ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ РЕБЕНКУ

- через пупочную вену в виде эмбола;
- через лимфатическую систему (лимфатические щели пупочных сосудов);
- с током крови матери при повреждении плаценты токсинами бледных трепонем (нормальная плацента непроницаема для возбудителя сифилиса).

ПОРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ СИФИЛИСЕ ПЛОДА

В пораженных сифилисом органах плода преимущественно поражаются капилляры, вокруг которых развивается инфильтрация лимфоцитами и гистиоцитами, что приводит к сужению их вплоть до обтурации. Гипертрофия печени (соотношение веса печени и веса плода в норме составляет 1:21,5; при сифилисе-1:14,7). Поверхность гладкая, на разрезе матовая, жирная, коричневато-желтого цвета, с очагами продуктивного воспаления. Гипертрофия селезенки (в норме1:325, а при сифилис плода-1:198). Изменения в легких (явления интерстициальной пневмонии; белой пневмонии; очаговой пневмонии). Изменения со стороны нервной системы (менингоэнцефалит). Изменения со стороны почек (задержка развития почечной ткани, инфильтраты из лимфоцитов и гистиоцитов). Изменения со стороны поджелудочной железы (диффузный интерстициальный воспалительный процесс, гиперплазия соединительной ткани, задержка дифференциации паренхимы). Изменения со стороны надпочечников (задержка развития паренхимы, гиперплазия соединительной ткани, очаговые некрозы, инфаркты). Изменения со стороны костной системы.

РАННИЙ ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС ПРОЯВЛЕНИЯ: Сифилитическая пузырчатка, Сифилитический ринит (диффузный гиперпластический передний ринит по Гохзингеру, coryza syphilitica); сифилитическое поражение рта и зева; гортани Диффузная папулезная сифилитическая инфильтрация кожи Гохзингера, Поражения костей, суставов, Папулезная, розеолезная сыпь, Поражение ногтевых пластинок, Поражение волос, Расстройства пигментации, Поражения внутренних органов: печень, селезенка, кишечник, почки, ссс, легкие, железы внутренней секреции, ЦНС, глаза.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАННЕГО ВРОЖДЕННОГО

СИФИЛИСА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ: Папулезная сифилид, Пустулѐзный сифилид (у ослабленных, Гуммозные поражения, Сифилитический ринит, Алопеция, Периоститы длинных трубчатых костей, Поражения печени, селезенки, яичек у мальчиков, Поражения ЦНС, Изменения в ОАК

86. Клинические проявления позднего врожденного сифилиса.

ДОСТОВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ - ТРИАДА
ГЕТЧИНСОНА:
 Паренхиматозный кератит
 Гетчинсоновские зубы
 Специфический лабиринтит

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЗНАКИ
ПОЗДНЕГО ВРОЖДЁННОГО СИФИЛИСА
 сифилитический хориоретинит
 врожденный нистагм и сходящееся косоглазие
 саблевидные голени Вегенера
 седловидный «козлиный» нос
 ягодицеобразный череп
 зубные дистрофии:
а) первых моляров: почкообразный зуб, кисетообразный зуб, зубы Муна, «бутонный» зуб
б) клыка (щучий зуб)
 симметричные синовиты коленных суставов Глеттона
 ложно-белая опухоль крупных суставов
 радиарные рубцы Робинсона-Фурнье
 поражения нервной системы: *поздняя врожденная гемиплегия, ювенильная спинная сухотка, детский и юношеский прогрессирующий паралич, сифилитическая эпилепсия, умственная отсталость*
 поражение кожи и слизистых (бугорковые и гуммозные высыпания)
 поражения внутренних органов

СТИГМЫ И ДИСТРОФИИ
 Признак Авситидийского-Гигуменакиса
 Аксифоидия
 Дистрофии костей черепа в виде: «олимпийского лба», «пузатого лба», «ладьеобразного черепа», «акроцефалического черепа»
 Высокое «готическое» или «стрельчатое» твердое небо
 Инфантильный мизинец Дюбуа-Гиссара
 Диастема Гаше
 Бугорок Карабелли
 Признак Тарновского
 Гипертрихоз
 Специфические лимфадениты
 Изменения эндокринных желез: инфантилизм, гипофизарный нанизм, адипозогенитальные дистрофии.
 Малозначительные: «копчиковая ямка», выемка в области угла лопатки, паукообразные пальцы (арахнодактилия)

87. Профилактика врожденного сифилиса.

Профилактика врожденного сифилиса осуществляется трехкратным серологическим обследованием беременных: в первую половину беременности (при взятии на учет), в сроки 20-24 недели и при получении обменной карты. При получении у беременной положительных результатов КСР необходимо провести исследование сыворотки крови на РИФ и РИБТ. При подтверждении положительных результатов беременная подлежит стационарному обследованию и лечению. При положительных данных КСР, но отрицательных результатов РИБТ и РИФ беременная должна находиться на клинико-серологическом контроле с ежемесячным исследованием КСР, РИФ и РИБТ до родов и в течение трех месяцев после них. При резко положительных КСР и невозможности постановки РИФ и РИБТ, повторяют исследования КСР и при повторном резко положительном результате диагностируют скрытый сифилис.

При повторных слабоположительных КСР беременная подлежит клинико-серологическому наблюдению в динамике для дифференцирования ложноположительных результатов КСР, обусловленных беременностью.

Беременные, болевшие в прошлом сифилисом, подлежат профлечению во время каждой беременности до снятия с учета. Если все серологические реакции негативировались до наступления беременности, то профилактическое лечение не проводится. После снятия с учета профилактическое лечение проводится при первой беременности только тем женщинам, у которых сохраняется серорезистентность.

Женщины, получившие превентивное противосифилитическое лечение, профилактическому лечению в период беременности не подлежат.

Если основное специфическое лечение проведено в ранние сроки беременности, то профлечение следует начинать не позднее 6-7 месяца беременности. Если основное лечение проводится в поздние сроки беременности, то профлечение начинают с интервалом не более 2 недель после основного.

88. Основы диагностики сифилиса. Конфронтация.

Выделение возбудителя сифилиса обычно не проводят. Основа диагностики сифилиса — методы, направленные на обнаружение возбудителя в материале микроскопией и выявление АТ серологическими реакциями. Материал для исследования — отделяемое шанкра, пункта лимфатических узлов, соскобы розеол, кровь, СМЖ. Наиболее оптимальные микроскопические методы — темнопольная и фазово-контрастная микроскопия. Также возможно приготовление гистологических препаратов, импрегнированных серебром по Морозову или Левадити (трепонемы выглядят как чёрные спирали).

Для ранней диагностики сифилиса применяют иммунофлюоресцентные методы; наибольшее распространение получила РНИФ с адсорбированной сывороткой. Основное значение в микробиологической диагностике сифилиса имеют серологические методы. Их разделяют на неспецифические и специфические.

Основные методы диагностики сифилиса — РСК, предложенная А. Вассерманном, и VDRL— специализированная флоккуляционпая проба на предметных стёклах с использованием кардиолипин-лецитин-холестеринового Аг. В качестве метода экспресс-диагностики применяют тест на реагины плазмы, представляющий собой РА частиц угля, нагруженных кардиолипином. данные так называемой конфронтации (обследование половых партнеров) - выявление у них ранней или поздней формы сифилиса или отсутствие заболевания.8. Основы диагностики сифилиса. Конфронтация.

89. Серологические реакции при сифилисе. Их клиническое значение. Ложноположительные серологические реакции.

Для диагностики сифилитической инфекции используют комплекс серологических реакций: RW, РИФ, РИБТ. Реакция Вассермана основана на феномене связывания комплемента и обладает достаточной чувствительностью, становится положительной через 3-4 недели после появления твердого шанкра. Посредством этой реакции определяются в крови антитела (реагины). Реакция Вассермана может давать ложноположительные результаты при некоторых инфекционных заболеваниях при алкогольном опьянении

В настоящее время при обследовании больных, на профосмотрах широко применяется микрореакция на стекле, или экспресс-метод. Микрореакция менее специфична для сифилиса, чем реакция Вассермана, но более чувствительна, результат получают через 30-40 мин., а кровь для исследования берется из пальца. Она является отборочной, т.е. положительный ее результат является основанием для углубленного обследования на сифилис.

РИБТ - реакция иммобилизации бледных трепонем, основана на феномене обездвиживания бледных трепонем антителами (иммобилизинами), имеющимися в сыворотке крови больного сифилисом, является высокоспецифичной и чувствительной реакцией. Становится положительной во вторичном периоде сифилиса, остается положительной и после полноценного лечения.

РИФ - реакция иммунофлюоресценции, основана на выявлении в сыворотке крови антител, обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Может быть использована для диагностики первичного периода сифилиса, но не может быть использована для установления излеченности, т.к. остается продолжительное время положительной и после полноценного лечения. Результаты РИБТ и РИФ позволяют отличить ложноположительные реакции Вассермана. Серологические исследования можно проводить и со спинномозговой жидкостью.

ИФА - иммуноферментный анализ заключается в том, что антигенами бледной спирохеты сенсибилизируется поверхность лунки панелей из полистирола или акрила (носитель). Затем в лунки вносится исследуемая сыворотка. При наличии в сыворотке антител к бледным спирохетам образуется комплекс антиген + антитело, связанный с поверхностью носителя. В лунки наливают меченную ферментом сыворотку против глобулинов человека. Меченные антитела взаимодействуют с комплексом антиген + антитело, образуя новый комплекс. Для его выявления в лунки добавляют раствор специального субстрата, который под действием фермента меняет цвет, что указывает на положительный результат реакции. Показания к постановке ИФА такие же, как для РИФ.

90. Принципы лечения сифилиса. Превентивное и профилактическое лечение сифилиса.

До начала лечения необходимо уточнить у больного переносимость препаратов пенициллина или других антибиотиков в прошлом. основные принципы: 1.Лечение необходимо назначать как можно раньше, немедленно по установлению диагноза, что обеспечивает наилучший результат терапии, а своевременная изоляция больных с заразными формами сифилиса предотвращает заражение здоровых людей.

2. Лекарственные средства применять в соответствующей дозировке с соблюдением разовых и курсовых доз согласно стадии болезни.

3.Специфическую терапию необходимо сочетать с неспецифической стимулирующей терапией, так как результаты лечения зависят и от общего состояния организма больного.

4.Лечение должно быть индивидуальным с учетом возраста больного, наличия сопутствующих заболеваний, переносимости препаратов. В процессе лечения необходимо проводить систематический контроль за его эффективностью и переносимостью, клинико - лабораторные обследования с исследованием крови, мочи, серологических реакций в динамике, спинномозговой жидкости.

Превентивное лечение проводят с целью предупреждения сифилиса лицам, находившимся в половом или тесном бытовом контакте с больными заразными формами сифилиса.

Профилактическое лечение проводят находящимся на учете беременным, болеющим или болевшим сифилисом, и детям, рожденным такими матерями.

Пробное лечение можно назначить при подозрении на специфическое поражение внутренних органов, нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата, когда лабораторные данные и клиническая картина не позволяют исключить сифилитическую инфекцию.

91. Мягкий шанкр. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение.

Возбудитель - стрептобацилла Ферарра - Петерсона - Дюкрея - Унна.

Пути заражения - половой, редко через предметы обихода.

Инкубационный период от 2-3 дней до 3 недель у мужчин, у женщин от 2-3 недель до 5 месяцев.

Поражаются половые органы, внутренняя поверхность бедер, перианальная область, лимфатические сосуды и лимфатические узлы. На месте внедрения инфекции образуется пустула, затем язва с подрытыми краями мягкой консистенции с воспалением вокруг. Заживание происходит рубцеванием.

Дифференциальная диагностика проводится с эрозивным баланопоститом, герпетическими эрозиями, первичным сифилисом, донованозом, венерической лимфогранулемой.

Диагноз подтверждается обнаружением возбудителя болезни.

Лечение. Сульфаниламиды, стрептомицин, тетрациклин, цефалоспорины, фторхинолоны.

Профилактика. Использование презерватива, обмывание половых органов с последующим втиранием сульфаниламидной эмульсии. В течение первых 3 часов после полового акта принять внутрь сульфаниламидный препарат

92. Венерическая лимфогранулема (четвертая венерическая болезнь). Эпидемиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.

Возбудитель – хламидия трахоматис, серотипы Л1, Л2, Л3.

Пути заражения - половой, при попадании гноя из очагов поражения на кожу или слизистые здорового человека.

Инкубационный период в среднем составляет 1-2 недели, может увеличиваться до 4-х недель. Поражаются преимущественно лимфатические узлы, мягкие ткани аногенитальной области. Болезнь проходит три периода. Первичный период - на месте внедрения возбудителя появляется пузырек, затем эрозия и язва без уплотнения в основании. Вторичный период начинается через 1,5 - 2 месяца. Уплотняются лимфоузлы, спаиваются, нагнаиваются, вскрываются с образованием свищей, заканчивается процесс рубцом. Третичный период наступает через 1-2 года и проявляется в виде генито - аноректального синдрома – фистулезно-спаечного процесса, развивающегося в результате распространения инфекции.

Диагностика основывается на данных реакций РИФ, ИФА, ПЦР, посева соскоба из уретры на культуру клеток МсСоу.

Дифференциальная диагностика проводится с мягким шанкром, сифилисом, донованозом, глубокими микозами, лепрой, новообразованиями.

Лечение. Антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, биогенные стимуляторы, физиотерапия, хирургическое лечение.

Профилактика идентична другим венерическим болезням.

93. Свежая острая гонорея. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.

Гонорея - инфекционное заболевание, вызываемое гонококком Нейсера и передающееся преимущественно половым путем.

Классификация:

1.Свежая гонорея (с давностью заражения до 2 месяцев):

- острая
- подострая
- торпидная (малосимптомная).

2. Хроническая гонорея (с давностью заражения более 2 месяцев).

Основные клинические проявления - острая форма свежей гонореи: рези при мочеиспускании, обильные гнойные выделения, отек и гиперемия губок наружного отверстия уретры.

Подострая форма: умеренные боли, слизисто-гнойные выделения, воспалительные явления выражены слабо.

Торпидная форма: субъективные расстройства, выделения и признаки воспаления незначительны, либо отсутствуют.

Диагностика гонореи:

- половой анамнез
- осмотр наружных половых органов
- исследование уретры: осмотр, пальпация, характер и количество выделений
- взятие мазков
- двухстаканная проба Томпсона
- пальцевое исследование простаты
- пальцевое исследование семенных пузырьков
- лабораторное исследование секретов простаты и семенных пузырьков
- уретроскопия.

Лабораторная диагностика:

- микроскопия мазков, окрашенных метиленовым синим и бриллинтовым зеленым
- микроскопия мазков, окрашенных по Граму
- культуральная диагностика (посев на среду, содержащую человеческий белок, асцит - агар).

Методы провокации при торпидной и хронической гонорее:

- биологическая - введение внутримышечно гоновакцины в количестве 500 млн. микробных тел или пирогенала 20 мкг
- химическая - инстилляция в уретру 0,5% раствора азотнокислого серебра (до 5 мл)
- механическая - массаж уретры на металлическом буже
- физическая (термическая) - прогревание половых органов с помощью индуктотермии
- алиментарная - употребление пива, соленой или острой.

Общее.лечение.Применение.антибиотиков: препараты группы пенициллина; антибиотики тетрациклинового ряда; антибиотики макролиды- эритромицин, макропен; антибиотики.аминогликозиды– канамицин; рифампицины-рифампицин;

иммунотерапия: специфическая иммунотерапия - гонококковая вакцина назначается при торпидных и хронических формах, с осложненной и восходящей гонореей. неспецифическая иммунотерапия – назначается пирогенал.Рекомендуется аутогемотерапия.

- местное лечение (инстилляция 0,25%-0,5% раствора азотнокислого серебра) физиотерапия (УВЧ, индуктотермия)

94. Хронический гонорейный уретрит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.

Хроническая гонорея: малосимптомное течение с периодическими обострениями после полового акта, употребления алкоголя, острой пищи, простудных заболеваний.

Диагностика гонореи:

- половой анамнез
- осмотр наружных половых органов
- исследование уретры: осмотр, пальпация, характер и количество выделений
- взятие мазков
- двухстаканная проба Томпсона
- пальцевое исследование простаты
- пальцевое исследование семенных пузырьков
- лабораторное исследование секретов простаты и семенных пузырьков
- уретроскопия.

Лабораторная диагностика:

- микроскопия мазков, окрашенных метиленовым синим и бриллинтовым зеленым
- микроскопия мазков, окрашенных по Граму
- культуральная диагностика (посев на среду, содержащую человеческий белок, асцит - агар).

Методы провокации при торпидной и хронической гонорее:

- биологическая - введение внутримышечно гоновакцины в количестве 500 млн. микробных тел или пирогенала 20 мкг
- химическая - инстилляция в уретру 0,5% раствора азотнокислого серебра (до 5 мл)
- механическая - массаж уретры на металлическом буже
- физическая (термическая) - прогревание половых органов с помощью индуктотермии
- алиментарная - употребление пива, соленой или острой пищи.

Общее.лечение.Применение.антибиотиков:

- препараты группы пенициллина;

- антибиотики тетрациклинового ряда;

- антибиотики макролиды- эритромицин, макропен;

-антибиотики.аминогликозиды–канамицин;

-рифампицины-рифампицин;

- иммунотерапия:

- специфическая иммунотерапия - гонококковая вакцина назначается при торпидных и хронических формах, с осложненной и восходящей гонореей.

- неспецифическая иммунотерапия –назначается пирогенал.Рекомендуется аутогемотерапия.

- местное лечение (инстилляция 0,25%-0,5% раствора азотнокислого серебра)

- физиотерапия (УВЧ, индуктотермия)

95. Осложнения при острой и хронической гонорее.

I. Местные осложнения:

- баланит, баланопостит
- тизонит
- парауретрит
- периуретральный абсцесс
- лимфангит полового члена
- паховый лимфаденит
- куперит
- эпидидимит, орхоэпидидимит\
- периорхоэпидидимит
- везикулит
- простатит: катаральный, фолликулярный паренхиматозный, парапростатит
- стриктура уретры.

II. Экстрагенитальные осложнения:

- проктит
- конъюнктивит, кератит
- орофарингеальная гонорея

диссеминированная гонорейная инфекция: артриты, эндокардит, менингит, перигепатит, абсцесс печени, гонококковый сепсис

96. Негонорейные уретриты (трихомонадные, бактериальные, микоплазменные, кандидозные, хламидийные) у мужчин. Этиология, клинические проявления, принципы лечения.

Возбудитель – влагалищная трихомонада.

Пути заражения: половой, у женщин и девочек бытовой (полотенца, мочалки, тазики и т.д.).

Инкубационный период от 7-14 дней до 4 недель.

Различают:

свежий – острый, подострый и малосимптомный

хронический – свыше двух месяцев

трихомонадоносительство.

Клинические проявления трихомониаза не отличаются от проявлений гонореи и других воспалительных процессов мочеполовых органов.

Диагностика: анамнез, клинические проявления, данные лабораторных исследований (обнаружение трихомонад).

Лечение: метронидазол (флагил, трихопол, клион, метрогил), тинидазол (тиниба, триканикс, фасижин), оридазол (тиберал), нитазол и др.

Местное лечение назначается при хронических процессах инстиляцией 0,25-0,5% раствора азотнокислого серебра или 1-2% раствора проторгола через 1-2 дня.

Профилактика – выявление и лечение больных трихомониазом и их половых партнеров.

ХЛАМИДИОЗ

Возбудитель – хламидии.

Пути заражения: половой, при прохождении инфицированных родовых путей, через предметы обихода, загрязненные выделениями.

Инкубационный период – 5-30 дней.

Клинические проявления хламидиоза напоминают проявления гонорейного процесса. Кроме того, могут быть боли в пояснично-крестцовой области, промежности, мошонки, заднего прохода.

Диагностика: анамнез, клинические проявления и лабораторные исследования – определение хламидий непосредственно в пораженных клетках, культуральный (посев на культуру клеток McCoy), имунофлюоресцентный и иммуноферментный методы.

Лечение: назначаются препараты тетрациклинового ряда в больших дозах в течение 7-14 дней, клацид, сумамед, вильпрафен, таривид, максаквин в течение 10 дней; иммунотерапию, антиоксиданты. Обязательное лечение всех половых партнеров!

МИКО - И УРЕАПЛАЗМОЗ

Возбудитель – занимает промежуточное место между бактериями, вирусами и простейшими.

Пути заражения – половой, через постельное белье, ночные горшки, необработанные медицинские инструменты, от матери к плоду.

Инкубационный период от недели до 2-х месяцев. *Клиника* напоминает обычный уретрит.

Диагностика основывается на данных лабораторных исследований (культуральный, серологический и иммунологический методы).*Лечение*. Назначается тетрациклин, доксициклин, эритромицин, абактал, максаквин и другие в течение двух недель. Кроме того, рекомендуются аутогемотерапия, пирогенал, иммуномодуляторы. Обязательное лечение половых партнеров!